



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE BIOLOGIA
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM DIVERSIDADE E INCLUSÃO

DANIELLE DE MORAES GÓIS DINIZ

Guia para a Formulação de Políticas Públicas: A
Perspectiva dos Pais e Cuidadores sobre Pessoas
com Dupla Excepcionalidade (AHSD e TEA)

Orientadoras: Dra. Fernanda Serpa Cardoso
Dra. Viviane Lione



DANIELLE DE MORAES GÓIS DINIZ

Guia para a Formulação de Políticas Públicas: A Perspectiva
dos Pais e Cuidadores sobre Pessoas com Dupla
Excepcionalidade (AHSD e TEA)

Trabalho desenvolvido no Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão da
Universidade Federal Fluminense

Dissertação submetida à
Universidade Federal Fluminense
como requisito parcial, visando à
obtenção do grau de Mestre em
Diversidade e Inclusão.

**Orientadoras: Dra. Fernanda Serpa Cardoso
Dra. Viviane Lione**

Ficha catalográfica automática - SDC/BCV
Gerada com informações fornecidas pelo autor

D585g Diniz, Danielle de Moraes Góis
 Guia para a Formulação de Políticas Públicas : A
 Perspectiva dos Pais e Cuidadores sobre Pessoas com Dupla
 Excepcionalidade (AHSD e TEA) / Danielle de Moraes Góis
 Diniz. - 2025.
 138 f.

 Orientador: Fernanda Serpa Cardoso.
 Coorientador: Viviane de Oliveira Freitas Lione.
 Dissertação (mestrado profissional)-Universidade Federal
 Fluminense, Instituto de Biologia, Niterói, 2025.

 1. Superdotação. 2. Autismo. 3. Dupla Excepcionalidade. 4.
 Políticas Públicas. 5. Produção intelectual. I. Cardoso,
 Fernanda Serpa, orientadora. II. Lione, Viviane de Oliveira
 Freitas, coorientadora. III. Universidade Federal Fluminense.
 Instituto de Biologia. IV. Título.

CDD - XXX

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

DANIELLE DE MORAES GÓIS DINIZ

Guia para a Formulação de Políticas Públicas: A Perspectiva dos Pais e Cuidadores sobre Pessoas com Dupla Excepcionalidade (AHSD e TEA)

Dissertação submetida à
Universidade Federal Fluminense
como requisito parcial, visando à
obtenção do grau de Mestre em
Diversidade e Inclusão.

Banca Examinadora:

Prof.^a Dra. Fernanda Serpa Cardoso – (Presidente da Banca - Orientadora)

Prof.^a Dra. Vera Lúcia Prudência dos Santos Caminha - CMPDI - UFF

Prof.^a Dra. Ana Luiza Bastos - UFF - Instituto Biomédico

Prof.^a Dra. Jacqueline Ramos – CMPDI - UFF

Prof.^a Dra. Karine Serpa Franco – FAMATH

**Prof.^a Dra. Viviane de Oliveira Freitas Lione - Coorientadora - FF-
UFRJ/CMPDI-UFF**

Prof.^a Dra. Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz – CMPDI - UFF

Dedico este trabalho, antes de tudo, à mulher que me tornei. Àquela que, entre desafios, incertezas e dores, aprendeu a ressignificar cada obstáculo em força, cada queda em aprendizado e cada dúvida em coragem. Que essa versão de mim continue florescendo, reinventando-se e, acima de tudo, inspirando outras mulheres a acreditarem no imenso poder que carregam dentro de si.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, por Sua orientação, força e amor, que me sustentaram e iluminaram durante toda esta jornada.

Minha gratidão profunda ao meu esposo, Rafael Diniz, e aos meus filhos, Júlia Diniz e Rafael Diniz Filho, pelo amor, paciência e carinho incondicionais. Vocês foram meu alicerce, minha motivação e meu porto seguro em todos os momentos deste percurso.

Aos meus pais, Osmário e Maria de Fátima, minha eterna gratidão pelo amor, cuidado, apoio incansável e por sempre estarem prontos a me socorrer e acolher. Ao meu irmão, Júnior, que, mesmo à distância, vibrou por cada uma das minhas conquistas e esteve presente em pensamento e coração.

Registro aqui minha grata surpresa e imensa honra por ter tido como orientadoras as professoras Fernanda Serpa e Viviane Lione, mulheres fortes, inteligentes, generosas e inspiradoras, que não apenas me orientaram academicamente, mas também me acolheram com paciência, empatia e carinho em todas as minhas dificuldades. São profissionais que admiro profundamente e levo como referência, exemplo e inspiração — confesso, sem medo, que as copio! Que privilégio aprender com vocês!

À minha revisora, professora Osilene Cruz, minha sincera admiração. Fiquei encantada não apenas pela sua competência e rigor acadêmico, mas também por sua beleza, delicadeza, formosura e pela didática impecável, que demonstra um cuidado singular com cada aluno e uma generosidade admirável no ato de ensinar. Seu olhar atento foi fundamental para aprimorar este trabalho.

Agradeço aos amigos com os quais a vida acadêmica me presenteou: Alan Macedo, Bianca Borges, Tatiana Zahal e Cássia Cortines, que estiveram comigo em trocas valiosas, incentivos, conversas e aprendizados que levarei para sempre. Deixo um agradecimento especial à minha querida amiga Vanusa Braga, que, mesmo de longe, nunca deixou de torcer por mim.

Estendo minha gratidão à banca examinadora, pelos olhares atentos e contribuições enriquecedoras, e aos colegas de turma, que foram fonte constante de empatia, solidariedade e companheirismo. Levo cada um de vocês comigo, no meu coração.

Por fim, agradeço imensamente ao Programa de Pós-Graduação em Diversidade e Inclusão (CMPDI/UFF), por ter me proporcionado um ambiente acolhedor, inclusivo e intelectualmente estimulante, onde este sonho pôde se concretizar. A cada um de vocês, minha eterna gratidão. Este sonho só se tornou possível porque tive pessoas tão especiais ao meu lado.

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	XI
LISTA DE GRÁFICOS	XII
LISTA DE QUADROS.....	XIII
LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS.....	XVI
LISTA DE TABELAS.....	XV
RESUMO.....	XVII
ABSTRACT.....	XVIII
1. INTRODUÇÃO	1
1.1 Apresentação	1
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	3
2.1 Altas Habilidades ou Superdotação (AHSD)	3
2.2 Modelos Teóricos Relevantes	4
2.2.1 Teoria dos Três Anéis (Renzulli)	4
2.3 Teoria das Inteligências Múltiplas (Gardner)	7
2.4 Transtorno do Espectro Autista (TEA).....	9
2.5 Dupla Excepcionalidade (DE): Conceito e Características.....	11
3. TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: UM PANORAMA HISTÓRICO-LEGAL	14
3.1 Lacunas Legislativas sobre Dupla Excepcionalidade	17
4. OBJETIVOS.....	18
4.1 Objetivo Geral	18
4.2 Objetivos Específicos	19
5. MÉTODO DA PESQUISA	19
5.1 Comitê de Ética	19
5.2 Busca por Legislações	20
5.3 Público-Alvo da Pesquisa.....	20
5.3.1 XIII Curso de Verão para Alunos Superdotados da UFF	21
5.3.2 Caminhada de conscientização mundial sobre autismo das cidades de Maricá (GAMAM) e Rio Bonito (GAIARB)	22
5.4 Construção e Validação do Questionário	23
5.5 A roda de conversa	24
5.5.1 Oficina para responsáveis dos indivíduos com AHSD	24
5.5.2 Roda de Conversa para responsáveis dos indivíduos com TEA	25

5.6. Aplicação dos questionários.....	26
5.6.1 Pais de alunos superdotados.....	26
5.6.2 Pais das crianças autistas	27
5.7 Tratamento dos dados	28
5.8 Organização do material para a construção do guia	29
6. RESULTADOS E DISCUSSÃO	29
6.1 Busca por Legislações Brasileiras sobre Dupla Excepcionalidade	29
6.2 Análise das respostas dos questionários	38
6.2.1 Responsáveis das crianças inicialmente identificadas com AHSD	38
6.2.2 Responsáveis das crianças inicialmente identificadas com Autismo .	42
6.3 Análise geográfica.....	46
6.3.1 Famílias das crianças inicialmente identificadas com Altas Habilidades ou Superdotação	47
6.3.2 Famílias das crianças inicialmente identificada com Autismo.....	48
6.4. Diagnósticos das crianças e/ou adolescentes.....	49
6.4.1 Informações dadas pelos familiares AHSD.....	50
6.4.2 Informações dadas pelos familiares TEA.....	51
6.5 Idade Atual dos Filhos/Tutelados dos Participantes da Pesquisa	53
6.6 A Idade do Diagnóstico AHSD E TEA.....	54
6.7 Descobrimo a Dupla Excepcionalidade: Pais AHSD e TEA	57
6.8 Superdotação, Autismo ou Dupla Excepcionalidade: identificação da(s) condição(ções) da(s) criança(s) e adolescente(s).....	60
6.8.1 Estrutura familiar das crianças e adolescentes.....	62
6.8.2 A Dupla Excepcionalidade na visão dos responsáveis	64
6.9 Desvendando a Dupla Excepcionalidade: Percepções Familiares, Desafios e Suporte	67
6.9.1 Percepções Familiares AHSD.....	67
6.9.2 Percepções Familiares TEA.....	68
6.10 Detalhamento das condições de prevalência das características: AHSD e/ou TEA	69
6.11 Distribuição das Inteligências acima da média dos filhos dos participantes	73
6.12 Nível de Suporte das crianças com AHSD e/ou TEA	74
6.13 Rede de apoio dos responsáveis das crianças com AHSD e TEA.....	78
6.14 Análise Descritiva e Crítica sobre Políticas Públicas e Suportes para Crianças com AHSD e TEA	79
6.15 Tipos de Terapias Realizadas AHSD e TEA	83

6.16 Tipo de Escola.....	87
6.17 Reconhecimento Institucional da AHSD e/ou TEA.....	88
6.18 Distribuição por Ano Escolar e Percepções sobre Atendimento – Grupos AHSD e TEA	90
6.19 Sugestões para Políticas Públicas e Atendimento Ideal: A Voz das Famílias	92
6.19.1 Percepções e Demandas do Grupo AHSD	92
6.19.2 Percepções e Demandas do Grupo TEA	92
6.19.3 Análise Comparativa: Convergências e Especificidades	93
6.19.4 Elementos Essenciais do Atendimento Ideal	94
6.19.5 Prioridades Familiares no Atendimento	95
7. ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL PARA CONSTRUIR O GUIA	96
7.1 Disponibilização gratuita e alcance ampliado.....	98
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	98
8.1 Perspectivas.....	100
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	102
10. APÊNDICES E ANEXOS	110
10.1 Apêndices.....	110
10.1.1 Apêndice I - Termo de Anuência.....	110
10.1.2 Apêndice II - Termo de compromisso Pesquisador.....	111
10.1.3 Apêndice III - TCLE - Pais e Responsáveis Termo de Consentimento Livre e Esclarecido	112
10.1.4 Apêndice IV - Termo de Cessão do Uso de Imagem (TCU)	114
10.1.5 Apêndice V - Questionário I da pesquisa	115
10.1.6 Apêndice VI - Questionário II da pesquisa	117
10.2. ANEXOS	120
10.2.1. Aprovação Plataforma Brasil.....	120

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Teoria dos Três Anéis (CS – Comportamentos Superdotados). Fonte: Renzulli e Reis, 1986 (adaptado por Cardoso, 2016).....	5
Figura 1: Teoria dos Três Anéis (CS – Comportamentos Superdotados). Fonte: Renzulli e Reis, 1986 (adaptado por Cardoso, 2016).....	Erro! Indicador não definido.
Figura 2: Diagrama de Venn: Interseção entre as características entre as AHSD e TEA (Adaptado de Baum et al. (2017) e Nakano (2021)).....	13

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Pesquisa Legislativa	31
Gráfico 2: Análise Comparativa de Diagnóstico	61
Gráfico 3: Composição familiar dos participantes dos grupos AHSD e TEA quanto à residência com o genitor(a)	62
Gráfico 4: Número de filhos com diagnóstico de AHSD ou Dupla Excepcionalidade (Grupo AHSD)	63
Gráfico 5: Número de filhos com diagnóstico de TEA ou Dupla Excepcionalidade (Grupo TEA)	64
Gráfico 6: Conhecimento prévio sobre Dupla Excepcionalidade (Grupo AHSD)...	65
Gráfico 7: Conhecimento prévio sobre Dupla Excepcionalidade (Grupo TEA)	66
Gráfico 8: Percepção sobre Dupla Excepcionalidade após a Oficina (responsáveis AHSD)	67
Gráfico 9: Percepção sobre Dupla Excepcionalidade após a Oficina (responsáveis TEA)	69
Gráfico 10: AHSD Diagnóstico como ponto de partida.....	71
Gráfico 11: Grupo TEA Diagnóstico como ponto de partida.....	72
Gráfico 12: Comparativo de apoio Familiar	79
Gráfico 13: Tipos de Terapias Realizadas – Grupo AHSD.....	83
Gráfico 14: Tipos de Terapias Realizadas – Grupo TEA.....	84
Gráfico 15: Comparação Atendimento terapêutico.....	85

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Teoria das Inteligências Múltiplas (Adaptado de Gardner, 2001).....	7
Quadro 2: Características comumente apresentadas em casos de DE (AHSD E TEA). (Adaptado de Nakano, 2021)	14
Quadro 3: Pesquisa Legislativa.....	30
Quadro 4: Legislação e Documentos sobre o AHSD no Brasil, mas não inclui o TEA	31
Quadro 5: Legislações e Documentos sobre o TEA no Brasil, mas não inclui o AHSD	33
Quadro 6: Legislações e Documentos sobre Dupla Excepcionalidade (DE).....	35
Quadro 7: Marcos Legais sobre AHSD, TEA e DE	36
Quadro 8: Faixa Etária (AHSD)	38
Quadro 9: Estado Civil (AHSD)	39
Quadro 10: Composição Familiar (AHSD)	40
Quadro 11: Grau de Escolaridade (AHSD)	41
Quadro 12: Ocupação Atual (AHSD).....	41
Quadro 13: Faixa Etária (TEA).....	43
Quadro 14: Estado Civil (TEA)	43
Quadro 15: Composição Familiar (TEA)	44
Quadro 16: Grau de Escolaridade (TEA)	44
Quadro 17: Ocupação Atual (TEA).....	45
Quadro 18: Análise Geográfica (AHSD).....	47
Quadro 19: Análise Geográfica (TEA).....	48
Quadro 20: Distribuição dos Diagnósticos nos tutelados do Grupo AHSD	50
Quadro 21: Distribuição dos diagnósticos no grupo TEA	51
Quadro 22: Comparativo - Idade Atual dos Filhos dos Participantes	53
Quadro 23: Idade Atual e Idade do Diagnóstico (Grupo AHSD) - O traço (—) indica que a condição não foi diagnosticada ou não se aplica.	54
Quadro 24: Idade Atual e Idade do Diagnóstico (Grupo TEA). Nota: O traço (—) indica que a condição não foi diagnosticada ou não se aplica	56
Quadro 25: Distribuição das sugestões para avaliação (AHSD)	57
Quadro 26: Quem Sugeriu a Avaliação - Grupo TEA.....	58
Quadro 27: Detalhamento das Condições que prevalecem (Grupo AHSD).....	70
Quadro 28: Detalhamento das Condições que prevaleceram (Grupo TEA).....	71
Quadro 29: Distribuição das inteligências (Grupo AHSD)	73
Quadro 30: Tipos de Inteligências e Números de Crianças (Grupo TEA)	74

Quadro 31: Nível de Suporte (Grupo AHSD)	76
Quadro 32: Nível de Suporte (Grupo TEA)	76
Quadro 33: Rede de apoio dos responsáveis das crianças com AHSD.....	78
Quadro 34: Rede de apoio dos responsáveis das crianças com AHSD e TEA.....	78
Quadro 35: Necessidades e Suportes – Grupo AHSD.....	80
Quadro 36: Necessidades e Suportes – Grupo TEA.....	81
Quadro 37: Tipo de Escola (AHSD e TEA).....	87
Quadro 38: Comparativo do Reconhecimento Institucional – AHSD e TEA.....	88
Quadro 39: Distribuição dos Alunos por Ano Escolar.....	91
Quadro 40: Sugestões para Políticas Públicas (Grupo AHSD	92
Quadro 41: Sugestões para Políticas Públicas (Grupo TEA)	93
Quadro 42: Sugestões para Políticas Públicas (Grupos AHSD e TEA)	93
Quadro 43: Prioridades Familiares no Atendimento	96
Quadro 44: Etapas da Elaboração do Guia.....	97

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 : Elementos Essenciais para o Atendimento Ideal	95
Tabela 2: Atendimento Ideal segundo Pais TEA	95

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

ABSD	Associação Brasileira para Superdotados
AEE	Atendimento Educacional Especializado
AHSD	Altas Habilidades ou Superdotação
APA	Associação Americana de Psiquiatria
CENESP	Centro Nacional de Educação Especial
CID	Classificação Internacional de Doenças
DE	Dupla Excepcionalidade
DIECI	Desenvolvimento e Inovação em Ensino de Ciências
DSM-5	Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
ISERJ	Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro
LB	Lei Brasileira de Inclusão
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC	Ministério da Educação e Cultura
OMS	Organização Mundial de Saúde
PNE	Plano Nacional da Educação
QI	Quociente de Inteligência
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TDAH	Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
TEA	Transtorno do Espectro Autista
TGD	Transtornos Globais do Desenvolvimento
UNIRIO	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

RESUMO

A Dupla Excepcionalidade (DE) refere-se à presença simultânea de Altas Habilidades ou Superdotação (AHSD) e de alguma condição que comprometa o desenvolvimento global, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o TDAH ou deficiências específicas. Embora reconhecida internacionalmente desde os anos 1970, essa condição ainda é pouco visibilizada no cenário educacional brasileiro, carecendo de diretrizes legais e práticas pedagógicas adequadas. Esta pesquisa adotou como recorte metodológico a análise das vivências, desafios e percepções de pais e cuidadores de indivíduos com AHSD e com TEA, estudados separadamente, com o propósito de identificar pontos de interseção entre os dois grupos que evidenciam a urgência do reconhecimento institucional da DE, especialmente na configuração AHSD + TEA. A investigação, de abordagem qualitativa e quantitativa, foi organizada em duas etapas complementares: uma análise documental e legislativa das normativas nacionais, e uma pesquisa empírica com familiares, realizada por meio da aplicação de questionários e da condução de rodas de conversa. A coleta de dados ocorreu em contextos distintos — o XIII Curso de Verão para Alunos Superdotados da Universidade Federal Fluminense e eventos promovidos pelos grupos GAMAM (Maricá-RJ) e GAIARB (Rio Bonito-RJ), voltados a pessoas com TEA e suas famílias. Os dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas e interpretação qualitativa das narrativas, com o apoio dos softwares Microsoft Excel e Word. Os resultados revelam a fragilidade institucional na identificação e no atendimento à Dupla Excepcionalidade, a ausência de articulação entre os setores de saúde e educação e a carência de formação docente voltada à complexidade desses estudantes. As famílias relataram experiências marcadas por diagnóstico tardio, negligência escolar, invisibilidade institucional e ausência de suporte emocional. Como contribuição central, a pesquisa propõe a construção de um documento orientador que possa subsidiar ações mais eficazes no campo educacional e intersetorial.

Palavras-chaves: Altas Habilidades; Superdotação; Autismo; Dupla Excepcionalidade; Políticas Públicas.

ABSTRACT

Twice Exceptionality (2E) refers to the simultaneous presence of Giftedness or High Abilities (AHSD) and a condition that compromises overall development, such as autism spectrum disorder (ASD), ADHD, or specific disabilities. Although internationally recognized since the 1970s, this condition remains largely invisible in the Brazilian educational and legislative landscape, lacking legal frameworks and appropriate pedagogical practices. This research adopted a methodological approach focused on analyzing the lived experiences, challenges, and perceptions of parents and caregivers of individuals with AHSD and ASD, studied separately, aiming to identify points of intersection that highlight the urgent need for institutional recognition of 2E, especially in the AHSD + ASD configuration. The investigation followed a mixed-methods approach, structured in two complementary stages: a documental and legislative review of Brazilian norms, and empirical research with families, conducted through questionnaires and discussion groups. Data were collected in two main contexts — the XIII Summer Course for Gifted Students at the Fluminense Federal University and events promoted by the GAMAM (Maricá-RJ) and GAIARB (Rio Bonito-RJ) advocacy groups, focused on individuals with ASD and their families. The data analysis combined descriptive statistics and qualitative interpretation of narratives, supported by Microsoft Excel and Word software. The findings reveal institutional fragility in the identification and support of Twice Exceptional students, a lack of coordination between education and health sectors, and insufficient teacher training to address the complexity of this population. Families reported late diagnoses, school neglect, institutional invisibility, and a lack of emotional support. As a central contribution, the study proposes the development of a practical policy guide aimed at supporting more effective educational and intersectoral actions.

Keywords: High Abilities; Giftedness; Autism; Double Exceptionality, Public Policies.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

A Dupla Excepcionalidade (DE) diz respeito à coexistência, em um mesmo indivíduo, de Altas Habilidades ou Superdotação (AHSD) e de alguma condição que comprometa o desenvolvimento, o funcionamento adaptativo ou a aprendizagem, como ocorre, por exemplo, no caso do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O termo foi introduzido por James J. Gallagher, em 1975, e, desde então, tem desafiado os modelos tradicionais de identificação e atendimento educacional, ao evidenciar que altas capacidades cognitivas podem coexistir com necessidades educacionais específicas (Gallagher, 1975; Assouline et al., 2010). Como reforçam Pérez e Freitas (2012, p. 9), “[...] a Dupla Excepcionalidade inclui a presença simultânea de altas habilidades/superdotação e algum tipo de deficiência ou transtorno, o que implica necessidades educacionais complexas”.

A presente pesquisa tem como foco compreender os desafios enfrentados por famílias de crianças e adolescentes com DE, mais especificamente aqueles que apresentam a combinação entre AHSD e o TEA. Ao articular potencialidades cognitivas elevadas com aspectos desafiadores do neurodesenvolvimento, esse perfil configura uma condição singular e, frequentemente, invisibilizada pelas políticas públicas, pelas práticas pedagógicas e pelos sistemas de saúde e educação.

Embora tanto a AHSD quanto o TEA sejam reconhecidos pela legislação brasileira como parte do público-alvo da Educação Especial (conforme a Resolução CNE/CEB nº 4/2009 e a Lei nº 12.764/2012), a coexistência dessas condições ainda carece de diretrizes específicas, de reconhecimento institucional e de políticas integradas. Estudantes com DE, muitas vezes, oscilam entre rótulos que ora ignoram suas dificuldades, ora negligenciam seus talentos, resultando em atendimentos fragmentados, lacunas na identificação, despreparo docente e ausência de uma rede de apoio consistente nas escolas.

A motivação para o desenvolvimento desta pesquisa nasce de uma vivência pessoal profundamente transformadora: sou mãe de um adolescente identificado com Altas Habilidades ou Superdotação, atualmente em processo de avaliação diagnóstica para TEA. Ao longo dessa trajetória, vivida entre encontros e

desencontros com os serviços educacionais e clínicos, ficou evidente o quanto as famílias enfrentam silêncios institucionais, a falta de escuta qualificada e a ausência de diretrizes integradas que sustentem processos de acolhimento, diagnóstico e atendimento adequados. Diante desse cenário, surgiu não apenas o desejo de compreender melhor essa condição, mas a necessidade de contribuir com soluções concretas, viáveis e socialmente comprometidas.

Minha formação acadêmica e profissional também foi determinante para o amadurecimento deste estudo. A graduação em Direito despertou o interesse pelas questões ligadas à justiça social e ao direito à educação, especialmente na perspectiva dos direitos humanos. Posteriormente, a licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) possibilitou a articulação entre os fundamentos legais e pedagógicos da inclusão, fornecendo base teórica para o entendimento dos desafios educacionais que atravessam as infâncias e juventudes neurodivergentes. No Mestrado em Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense (UFF), encontrei o ambiente ético, afetivo e científico necessário para transformar essa vivência pessoal em uma pesquisa de interesse coletivo.

A escassez de estudos brasileiros sobre Dupla Excepcionalidade — sobretudo, sob a perspectiva das famílias — tem sido destacada por diversos autores (Medeiros; Silva; Filgueiras, 2021; Nakano, 2021; Assouline et al., 2020). Em geral, a produção acadêmica ainda trata a AHSD e o TEA de forma isolada, desconsiderando as sobreposições, complexidades e singularidades que caracterizam os sujeitos com DE. Além disso, como apontam Mendonça e Fleith (2021), a formação docente e as políticas públicas voltadas a esse público ainda são incipientes e insuficientes, contribuindo para o aumento das desigualdades educacionais.

Diante desse panorama, a presente pesquisa propõe analisar, a partir das vozes de pais e cuidadores, como têm sido vivenciados os processos de identificação, escolarização, suporte institucional e atendimento especializado. Mais do que mapear dificuldades, a proposta é construir, em diálogo com as famílias, diretrizes que possam subsidiar um Guia para formulação de políticas públicas específicas, baseadas na escuta sensível, no respeito às singularidades e no compromisso com o desenvolvimento integral de crianças e jovens com Dupla Excepcionalidade.

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seção teórica apresenta os conceitos de Altas Habilidades ou Superdotação, Transtorno do Espectro Autista e Dupla Excepcionalidade, detalhando suas características e desafios para identificação e atendimento. São discutidos os principais modelos teóricos, como a Teoria dos Três Anéis de Renzulli e a Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner, que fundamentam a necessidade de práticas pedagógicas personalizadas e inclusivas. Destaca-se a importância da formação continuada de professores e da adaptação curricular para garantir o desenvolvimento das potencialidades dos alunos com DE.

2.1 Altas Habilidades ou Superdotação (AHSD)

Altas Habilidades ou Superdotação (AHSD) refere-se a indivíduos com potencial elevado em uma ou mais áreas do conhecimento, como intelectual, acadêmica, artística, psicomotora ou liderança. Esses indivíduos costumam apresentar características como criatividade elevada, grande envolvimento em tarefas desafiadoras e habilidades acima da média em contextos específicos (Renzulli, 1986). No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) reconhece os alunos com AHSD como parte do público-alvo da Educação Especial, assegurando-lhes direitos como adaptações curriculares e aceleração escolar para atender às suas necessidades específicas (Brasil, 1996).

A identificação de AHSD exige uma análise abrangente que considere desempenho acadêmico, criatividade e motivação. Modelos como a Teoria dos Três Anéis, de Joseph Renzulli, têm sido amplamente utilizados para compreender e identificar esses indivíduos. Essa teoria propõe que a superdotação resulta da interação entre habilidades acima da média, criatividade e envolvimento em tarefas específicas (Renzulli; Reis, 2014).

Apesar do reconhecimento legal e teórico, ainda há desafios significativos no atendimento educacional desse público. A falta de formação adequada dos professores e a escassez de políticas públicas específicas limitam o desenvolvimento pleno das potencialidades desses alunos (Alencar; Fleith, 2001).

Além disso, muitos estudantes com AHSD permanecem subidentificados devido à ausência de critérios claros e ferramentas apropriadas para avaliação (Nakano, 2021).

2.2 Modelos Teóricos Relevantes

2.2.1 Teoria dos Três Anéis (Renzulli)

A Teoria dos Três Anéis, desenvolvida por Joseph Renzulli (1985), oferece uma concepção inovadora sobre a superdotação, compreendendo-a não como uma característica fixa, inata ou restrita a um grupo seletivo de indivíduos, mas como o resultado da interação dinâmica entre três componentes essenciais: habilidades acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. Essa abordagem rompe com modelos reducionistas, que, tradicionalmente, associam superdotação apenas ao quociente intelectual elevado, e propõe uma leitura mais ampla, contextual e relacional das potencialidades humanas. Nessa perspectiva, o papel dos ambientes educacionais e dos estímulos oferecidos ao longo do desenvolvimento torna-se central para o florescimento das habilidades excepcionais.

O primeiro componente, habilidades acima da média, abrange tanto as capacidades gerais — como raciocínio lógico, verbal e abstrato — quanto habilidades específicas em domínios como matemática, artes, ciências ou linguagem. Já a criatividade está relacionada à capacidade de inovação, pensamento divergente, sensibilidade estética e originalidade na resolução de problemas. O terceiro elemento, envolvimento com a tarefa, diz respeito à motivação intrínseca, ao comprometimento pessoal, à persistência e à dedicação diante de atividades desafiadoras e significativas para o sujeito.

Quando esses três elementos se inter-relacionam, ocorre o que Renzulli denomina de comportamento superdotado, uma manifestação ativa de potencialidade, que pode emergir em diferentes momentos e contextos da vida escolar e social. Essa concepção é ilustrada pela representação gráfica dos três anéis interligados, comumente organizada em forma de diagrama de Venn, cuja interseção representa o ponto de convergência entre as habilidades, a criatividade

e o envolvimento — ou seja, o núcleo da expressão da superdotação. Essa representação visual é apresentada na Figura 1, intitulada *Teoria dos Três Anéis (CS – Comportamentos Superdotados)*, e serve como uma síntese gráfica da proposta teórica de Renzulli (1986).

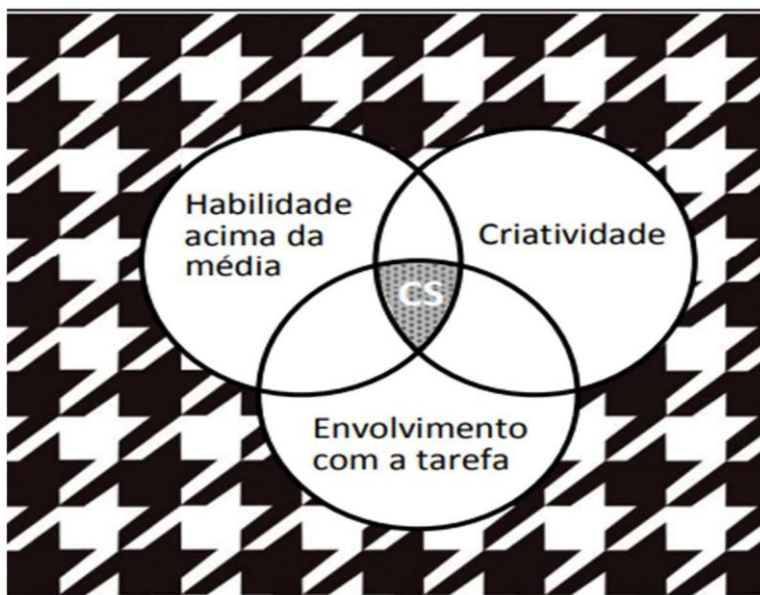


Figura 1: *Teoria dos Três Anéis (CS – Comportamentos Superdotados)*. Fonte: Renzulli e Reis, 1986 (adaptado por Cardoso, 2016)

Essa perspectiva conceitual evidencia a superdotação como uma construção em constante movimento, que depende diretamente das oportunidades e estímulos oferecidos. A partir disso, destaca-se a importância de ambientes educacionais ricos, desafiadores e acolhedores, que promovam o engajamento dos estudantes com suas áreas de interesse e fortaleçam suas habilidades cognitivas e socioemocionais.

No contexto brasileiro, esse entendimento dialoga diretamente com os princípios da educação inclusiva, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996) e em outras normativas complementares, como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2009). Esses documentos reconhecem o direito de todos os estudantes ao acesso, permanência e

desenvolvimento pleno no ambiente escolar, incluindo os alunos com Altas Habilidades ou Superdotação (AHSD), considerados público da Educação Especial conforme o Art. 58 da LDB.

Tais normativas ainda determinam que os sistemas de ensino ofereçam currículos, métodos, recursos e organizações pedagógicas específicas, incluindo possibilidades como a aceleração de estudos (Art. 59) e a criação de um cadastro nacional para subsidiar políticas públicas específicas (Art. 59-A, Lei nº 13.234/2015). Entretanto, para que essas garantias se concretizem, é fundamental a consolidação de práticas pedagógicas efetivas e sensíveis às singularidades desses alunos.

A implementação de currículos flexíveis e enriquecidos, a oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em salas de recursos multifuncionais e o investimento na formação inicial e continuada dos professores são medidas indispensáveis para assegurar uma resposta educacional à altura das necessidades desse público. A aceleração, quando pertinente, e o acompanhamento psicopedagógico também são estratégias reconhecidas como eficazes para promover o desenvolvimento integral dos estudantes com AHSD.

Ainda assim, persistem obstáculos significativos na implementação dessas políticas, especialmente em relação à formação insuficiente de educadores para lidar com a superdotação, ao desconhecimento institucional sobre o tema, à escassez de recursos materiais e humanos e à dificuldade na identificação precoce desses alunos. Como apontam Nakano (2021), Baum et al. (2017) e outros autores da área, a ausência de políticas efetivas e de formação adequada impede que muitos desses estudantes tenham suas potencialidades reconhecidas e desenvolvidas, resultando em invisibilidade, frustração escolar e perdas cognitivas e emocionais irreparáveis.

A Resolução CNE/CEB nº 4/2009 explicita a influência da Teoria dos Três Anéis no cenário brasileiro, ao adotá-la como referência para a identificação de alunos com Altas Habilidades ou Superdotação. Com isso, amplia-se o olhar institucional para além do desempenho acadêmico tradicional, incorporando a criatividade e a motivação como dimensões essenciais do processo de identificação.

Por fim, vale destacar a contribuição dessa teoria para a compreensão da Dupla Excepcionalidade (DE) – quando AHSD coexistem com condições como o

Transtorno do Espectro Autista (TEA). A estrutura tripla de Renzulli permite reconhecer que, mesmo diante de desafios no desenvolvimento ou na socialização, é possível identificar e nutrir habilidades excepcionais, desde que se criem estratégias pedagógicas personalizadas. Ao integrar as dimensões cognitivas e motivacionais do comportamento superdotado com uma abordagem acolhedora e responsiva às especificidades do TEA, essa teoria sustenta práticas inovadoras e verdadeiramente inclusivas.

2.3 Teoria das Inteligências Múltiplas (Gardner)

A Teoria das Inteligências Múltiplas, proposta por Howard Gardner, em 1983, transformou a compreensão da cognição humana ao desafiar a visão tradicional de inteligência como um constructo único, mensurável apenas por testes de QI. Gardner propôs que a inteligência é composta por diferentes modalidades, cada uma representando formas distintas de processar informações e resolver problemas (Gardner, 2001).

Inicialmente, ele identificou sete tipos de inteligência, posteriormente ampliados para oito, conforme ilustrado no Quadro 1. Cada uma dessas inteligências reflete uma maneira única de interação com o mundo e processamento de informações.

Quadro 1: Teoria das Inteligências Múltiplas (Adaptado de Gardner, 2001)

INTELIGÊNCIA	DESCRIÇÃO
Linguística	Habilidade de utilizar a linguagem de forma eficaz, tanto na comunicação oral quanto na escrita.
Lógico- Matemática	Capacidade para raciocínio lógico, resolução de problemas matemáticos e científicos.
Espacial	Habilidade de perceber, transformar e criar imagens mentais, essencial para arquitetos, designers e artistas.
Musical	Sensibilidade a ritmos, tons e timbres, fundamental para músicos, compositores e profissionais da área musical.
Corporal- Cinestésica	Controle refinado dos movimentos do corpo, importante para atletas, dançarinos, cirurgiões, entre outros.

Interpessoal	Capacidade de compreender, se comunicar e interagir efetivamente com outras pessoas; presente em líderes, educadores e terapeutas.
Intrapessoal	Habilidade de compreender a si mesmo, seus sentimentos, emoções, desejos e de autorregular seu comportamento.
Naturalista	Capacidade de identificar, reconhecer e categorizar elementos da natureza, como espécies, fenômenos e padrões ambientais.

A proposta de Gardner destaca que cada indivíduo possui um perfil cognitivo singular, combinando diferentes inteligências em graus variados. Assim, a educação deve ser personalizada, considerando as forças e fragilidades de cada aluno para promover um ensino mais dinâmico e eficaz. Segundo Gardner (2001), "[...] a escola deve permitir que cada aluno explore e desenvolva suas potencialidades, promovendo múltiplos caminhos para a aprendizagem." Essa abordagem reforça a necessidade de práticas pedagógicas que respeitem a diversidade cognitiva dos alunos e valorizem suas potencialidades individuais.

Se aceitarmos a premissa de que a inteligência não pode ser mensurada por um único critério, as oportunidades educacionais devem ser amplamente diversificadas para refletir essa pluralidade. Diferente dos modelos tradicionais, que enfatizam habilidades linguísticas e lógico-matemáticas, a Teoria das Inteligências Múltiplas reconhece que a inteligência se manifesta de formas distintas em cada indivíduo (Gardner, 1999). No contexto brasileiro, a legislação educacional busca alinhar-se às ideias de Gardner ao promover uma Educação Inclusiva que valorize a diversidade cognitiva e ofereça suporte adequado aos alunos com Altas Habilidades ou Superdotação (AHSD).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Plano Nacional de Educação (PNE) reforçam a importância da adaptação curricular para atender às necessidades desses alunos (Brasil, 1996). Essa abordagem visa garantir que cada estudante tenha acesso a oportunidades educacionais compatíveis com suas aptidões e interesses, promovendo um ambiente de aprendizagem mais significativo e motivador.

A Teoria das Inteligências Múltiplas também tem implicações no atendimento aos alunos com Dupla Excepcionalidade (DE), pois reconhece as múltiplas formas de manifestação da inteligência. Isso é especialmente relevante quando

habilidades excepcionais coexistem com desafios associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou outros transtornos do neurodesenvolvimento. Ao oferecer uma estrutura para identificar e valorizar diferentes tipos de inteligência, essa teoria subsidia práticas pedagógicas inclusivas que atendam às necessidades específicas desses indivíduos.

Portanto, ao integrar os princípios da Teoria das Inteligências Múltiplas à educação brasileira, é possível criar estratégias pedagógicas mais inclusivas e eficazes. Essas estratégias devem considerar tanto as potencialidades quanto os desafios enfrentados pelos alunos com AHSD ou DE, promovendo seu pleno desenvolvimento acadêmico e social.

2.4 Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por alterações persistentes na comunicação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades (APA, 2013). Por tratar-se de um espectro, suas manifestações variam amplamente em intensidade, configuração e impacto funcional, conferindo a cada indivíduo um perfil singular de habilidades, desafios e modos de interação com o ambiente (OMS, 2022).

Entre as manifestações mais comuns destacam-se: dificuldades na reciprocidade social, comportamentos de autoestimulação, hipersensibilidade ou hipossensibilidade a estímulos sensoriais, interesses restritos e intensos, além de forte resistência a mudanças na rotina. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças – CID-11, o TEA é classificado em três níveis de suporte – leve, moderado e intenso – conforme a necessidade de apoio nas áreas de comunicação, comportamento adaptativo e autonomia (OMS, 2022).

A identificação precoce do TEA é considerada um fator essencial para o desenvolvimento do indivíduo. Diretrizes internacionais e estudos nacionais apontam que intervenções iniciadas ainda na primeira infância, preferencialmente até os três anos de idade, estão associadas a melhores prognósticos, incluindo avanços na linguagem, nas habilidades sociais, na autorregulação e na autonomia

funcional (Zanon et al., 2020; Brasil, 2015). Tais intervenções devem ser individualizadas, contínuas e fundamentadas em evidências científicas, respeitando o perfil e as potencialidades de cada criança. Abordagens recomendadas incluem a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), o Modelo Denver de Intervenção Precoce, além de terapias específicas, como fonoaudiologia, integração sensorial, terapia ocupacional e psicoterapia, em articulação com apoio educacional estruturado e ações intersetoriais.

No Brasil, o reconhecimento legal dos direitos das pessoas com TEA avançou significativamente com a promulgação da Lei nº 12.764/2012, também conhecida como Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Essa legislação estabelece que pessoas com TEA são, legalmente, consideradas pessoas com deficiência, nos termos do art. 1º, §1º, garantindo-lhes o acesso à educação, saúde, trabalho, assistência social e inclusão comunitária.

Complementando esse marco, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI (Lei nº 13.146/2015) assegura o direito à educação inclusiva em todos os níveis, proíbe a cobrança de mensalidades adicionais por parte de escolas particulares e determina a oferta de apoios e adaptações razoáveis para garantir a aprendizagem. No âmbito da saúde, a Portaria nº 199/2014 do Ministério da Saúde regulamenta o acesso a Centros Especializados em Reabilitação (CER) e Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), assegurando atendimento multiprofissional pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na área da assistência social, pessoas com TEA em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem ser beneficiadas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), conforme previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993).

Apesar desses avanços legais, persistem desafios significativos na implementação efetiva dos direitos garantidos. A escassez de profissionais especializados, a concentração dos serviços em regiões urbanas, a falta de políticas públicas integradas e o diagnóstico tardio – sobretudo, em meninas, indivíduos verbais ou com perfil de altas habilidades – dificultam o acesso a um atendimento adequado e comprometem a inclusão plena (Macedo, 2019; Schmidt et al., 2020). Embora haja avanços normativos, a efetivação dos direitos das pessoas com TEA ainda encontra entraves significativos, como a escassez de serviços especializados, a carência de formação continuada dos profissionais

envolvidos e o diagnóstico frequentemente tardio — especialmente quando os sinais não seguem o padrão tradicionalmente reconhecido, como ocorre nos casos em que há altas habilidades coexistindo com o TEA (Assouline et al., 2010; Ronksley-Pavia, 2015; Schmidt; Gomes; Souza, 2020).

Esse é o caso da Dupla Excepcionalidade (DE), condição em que o indivíduo apresenta, simultaneamente, Altas Habilidades ou Superdotação (AHSD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Embora essas duas condições, isoladamente, sejam reconhecidas como parte do público-alvo da Educação Especial no Brasil (Resolução CNE/CEB nº 4/2009), sua coexistência ainda é pouco compreendida e subidentificada, tanto nos contextos educacionais quanto nos serviços de saúde e assistência social.

Esta pesquisa tem como recorte justamente essa intersecção — AHSD + TEA — por compreender que indivíduos com esse perfil enfrentam desafios singulares, que não podem ser plenamente compreendidos nem respondidos a partir de abordagens voltadas exclusivamente para o TEA ou para a superdotação. A combinação de habilidades cognitivas acima da média com características próprias do espectro autista configura um quadro complexo e, muitas vezes, paradoxal, no qual os sinais de uma condição podem mascarar os da outra, dificultando o diagnóstico e comprometendo o acesso a estratégias de apoio eficazes (Assouline et al., 2010; Ronksley-Pavia, 2015; Reis et al., 2021).

Ao destacar o TEA nesta seção, portanto, não se trata apenas de contextualizar uma das duas condições presentes na Dupla Excepcionalidade, mas de evidenciar a necessidade de reconhecimento institucional, diagnóstico sensível e atendimento intersetorial articulado que considere a complexidade desse perfil. A compreensão da DE requer uma abordagem integrada, capaz de reconhecer e valorizar as potencialidades ao mesmo tempo em que oferece suporte às dificuldades — especialmente nos sistemas educacional, de saúde e de proteção social.

2.5 Dupla Excepcionalidade (DE): Conceito e Características

A compreensão da Dupla Excepcionalidade exige, antes de tudo, uma

abordagem clara sobre o que são as AHSD, uma temática que, conforme aponta Virgolim (2018), ainda é cercada por equívocos e mitos. A concepção contemporânea desse fenômeno supera a ideia de inteligência única e inata, ampliando o entendimento para uma multiplicidade de inteligências, conforme defendido por Gardner (1994). Essa perspectiva incorpora aspectos cognitivos, criativos, emocionais e sociais, reconhecendo o potencial humano em sua diversidade e complexidade.

Ainda que tais características sirvam como parâmetro para identificação, autores como Sabatella (2013) e Virgolim (2019) destacam a grande variabilidade nos perfis desses indivíduos. São comuns traços como pensamento avançado, vocabulário elaborado, argumentação sofisticada, sensibilidade emocional acentuada, senso crítico aguçado, perfeccionismo, humor peculiar, liderança e criatividade. Contudo, essas mesmas características podem coexistir com dificuldades de socialização, baixa tolerância à frustração, ansiedade e quadros depressivos, sobretudo, quando suas necessidades educacionais não são reconhecidas ou atendidas.

Neumann (2022) observa que a superdotação deve ser compreendida como uma condição de desenvolvimento que, por sua natureza assíncrona, manifesta discrepâncias entre diferentes domínios – intelectual, emocional e psicomotor. Essa assincronia pode gerar vulnerabilidades emocionais e dificuldades no processo de socialização, afetando diretamente o desempenho e o bem-estar desses estudantes.

No ambiente escolar, espera-se que alunos com AHSD apresentem desempenho exemplar em todas as áreas. No entanto, muitos vivenciam frustrações profundas quando suas expectativas não são correspondidas pela estrutura educacional. Esse cenário se agrava ainda mais quando há a presença de outra condição associada, como transtornos ou deficiências – quadro conhecido como Dupla Excepcionalidade (DE).

Alves e Nakano (2021) ressaltam que a DE se refere à coexistência de altas habilidades com uma condição que compromete o desenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), transtornos de aprendizagem ou deficiências sensoriais. Essa condição representa um desafio ao modelo educacional tradicional por reunir, em um mesmo indivíduo, potencial elevado e necessidades educacionais

específicas.

Nakano (2021) estima que cerca de 30% dos superdotados apresentam outra condição associada – sendo o TEA uma das mais recorrentes. Essa interseção gera perfis atípicos e complexos, que nem sempre são compreendidos pelos profissionais da educação ou da saúde. O mascaramento recíproco – quando os sinais de uma condição ocultam a outra – é um dos principais obstáculos à identificação. Assim, traços autísticos podem camuflar a superdotação, ao passo que o alto desempenho pode mascarar dificuldades sociais ou sensoriais.

A seguir, apresenta-se a figura 2, que ilustra, visualmente, a sobreposição entre características de AHSD e TEA.

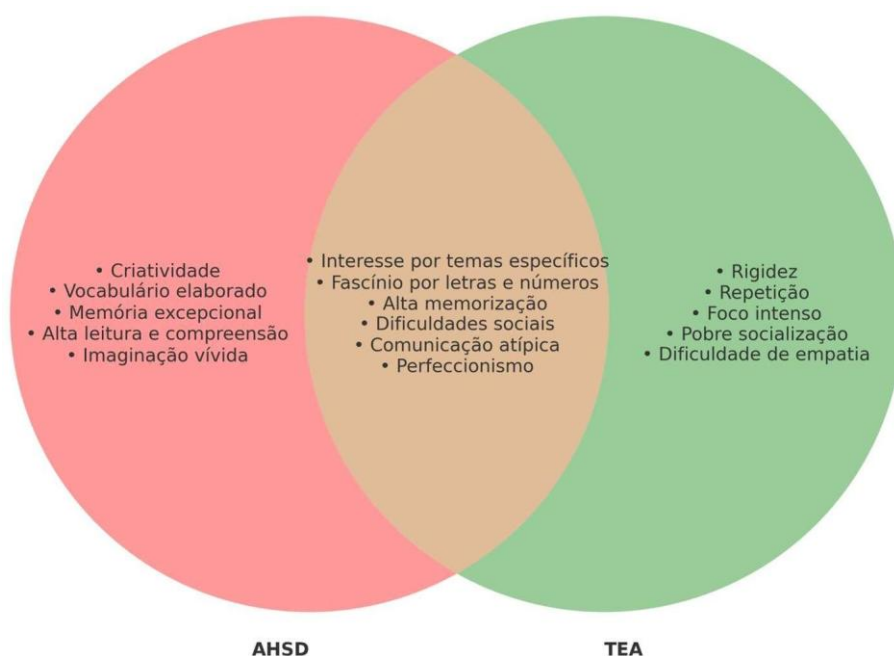


Figura 2: Diagrama de Venn: Interseção entre as características entre as AHSD e TEA (Adaptado de Baum et al. (2017) e Nakano (2021))

Esse perfil híbrido, quando não identificado adequadamente, pode levar a estratégias pedagógicas ineficazes, diagnósticos equivocados e sofrimento psicoemocional. Baum, Schader e Owen (2017) argumentam que a resposta educacional para esses estudantes deve ser sensível, personalizada e integrada, valorizando suas habilidades ao mesmo tempo em que oferece suporte às suas dificuldades.

Hakim (2019) destaca que a falta de formação específica é uma das principais barreiras no atendimento desses estudantes. Muitas vezes, são assistidos apenas com foco em uma das condições – seja a superdotação ou o

transtorno, o que resulta em práticas fragmentadas e ineficientes.

Já Ourofino e Guimarães (2007) defendem que a DE demanda ações intersetoriais, uma vez que esses alunos apresentam desenvolvimento multipotencial, assíncrono e com alta variabilidade individual. Como exemplificado no quadro 2, a combinação de AHSD com diferentes transtornos ou deficiências dá origem a múltiplos perfis, que exigem estratégias diferenciadas de acolhimento e intervenção.

*Quadro 2: Características comumente apresentadas em casos de DE (AHSD E TEA).
(Adaptado de Nakano, 2021)*

CONDIÇÕES	CARACTERÍSTICAS
AHSD + TEA	Foco intenso em temas específicos, pouca sociabilidade, dificuldade de comunicação, habilidades avançadas em leitura e memória.

Esses perfis, frequentemente, passam despercebidos no ambiente escolar, pois não se encaixam nos estereótipos convencionais de superdotação ou de deficiência. A compreensão limitada por parte de profissionais da saúde e da educação dificulta o reconhecimento da DE, perpetuando práticas excludentes e impedindo que esses estudantes recebam o suporte necessário para seu pleno desenvolvimento. Assim, é fundamental avançar em políticas públicas, formação docente e instrumentos diagnósticos que reconheçam a complexidade da Dupla Excepcionalidade, promovendo ações educativas verdadeiramente inclusivas e alinhadas às singularidades desse grupo.

3. TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: UM PANORAMA HISTÓRICO-LEGAL

Neste capítulo, traça-se um panorama da evolução da Educação Especial, desde o modelo segregacionista até a atual perspectiva inclusiva. São abordados os principais marcos legais, como a Constituição Federal de 1988, a LDB, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e a Lei Brasileira de Inclusão. Ressalta-se, contudo, a ausência de diretrizes específicas para a DE, o que dificulta a identificação e o atendimento adequado desse público, comprometendo seu desenvolvimento integral.

A evolução histórica da Educação Especial no Brasil demonstra um processo

contínuo de transformação das concepções educacionais, do modelo segregacionista para uma abordagem inclusiva.

- **Início da Educação Especial (1854):** o marco inicial da Educação Especial no Brasil remonta à criação do Instituto dos Meninos Cegos em 1854. Essa iniciativa pioneira, seguida pelo surgimento de outras instituições voltadas ao atendimento de crianças com diferentes deficiências, representou um primeiro passo na oferta de educação para indivíduos com necessidades específicas (OJS-UEL, 2023).
- **Modelo Segregacionista (1950-1960):** durante grande parte do século XX, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, predominou um modelo educacional segregacionista, no qual escolas especializadas eram consideradas a única alternativa para a escolarização desses indivíduos. Esse modelo, fundamentado em concepções assistencialistas e perspectivas clínicas, limitava as oportunidades educacionais e reforçava estereótipos que marginalizavam pessoas com deficiência (Beyer, 2006).
- **Movimento em Direção à Inclusão (Década de 1980):** o avanço dos debates sobre direitos humanos e políticas educacionais resultou em um movimento progressivo em direção à inclusão escolar. A partir da década de 1980, com a redemocratização do país, pesquisadores, professores e movimentos sociais intensificaram a luta pelo direito à educação, culminando na promulgação da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988).
- **Constituição Federal de 1988:** o artigo 208, inciso III, da Constituição Federal de 1988 estabelece a obrigatoriedade de o Estado garantir o Atendimento Educacional Especializado (AEE) a estudantes com deficiência, preferencialmente em classes regulares de ensino. Esse dispositivo jurídico consolidou a perspectiva de inclusão como princípio fundamental da educação brasileira (Brasil, 1988).
- **Redefinição Conceitual (Década de 1990):** a década de 1990 marcou um período de redefinição conceitual da Educação Especial, impulsionado por documentos internacionais como a Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990) e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). Essas diretrizes destacaram a necessidade de substituir a visão medicalizante da deficiência por uma abordagem que valorizasse o potencial

dos indivíduos, promovendo a igualdade de acesso à educação e incentivando o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas (Beyer, 2006).

- **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996):** constitui um marco normativo essencial para a consolidação de uma escola democrática e inclusiva. O documento reconhece a Educação Especial como modalidade integrante do sistema educacional brasileiro, prevendo a matrícula de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 58) e garantindo a oferta de serviços de apoio especializado para atender às especificidades desse público. Além disso, estabelece a necessidade de formação continuada de professores (art. 59, inciso III) e reforça o compromisso estatal com a ampliação do Atendimento Educacional Especializado na rede pública (art. 60, parágrafo único) (Brasil, 1996).
- **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008):** instituída em 2008, foi orientada por avanços teóricos provenientes das áreas de Antropologia, Psicologia e Educação. Essa política substituiu o termo “portador de deficiência” por expressões mais adequadas, como “estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação”, ampliando o escopo da Educação Especial. O documento enfatiza a necessidade de garantir a permanência desses estudantes em classes regulares, assegurando o Atendimento Educacional Especializado no contraturno escolar, quando necessário (Brasil, 2008).
- **A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA (Lei nº 12.764/2012)** considera a pessoa autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Essa Lei garante acesso à educação, saúde e assistência social, além de regulamentar políticas de inclusão escolar e profissional (Brasil, 2012).
- **Lei Brasileira de Inclusão (LBI, Lei nº 13.146/2015):** estabelece diretrizes para a inclusão de pessoas com deficiência, garantindo o direito à educação inclusiva em instituições regulares de ensino. Embora não aborde explicitamente a Dupla Excepcionalidade, contribui para a garantia dos

direitos educacionais de pessoas com deficiência (Brasil, 2015).

No entanto, os desafios persistem, sobretudo, no que se refere à efetivação das políticas públicas, à formação de professores e à adaptação curricular. O sucesso da inclusão escolar depende da implementação de práticas pedagógicas fundamentadas em pesquisas científicas e na construção de um ambiente educacional acessível e equitativo para todos (Brasil, 2008).

3.1. Lacunas Legislativas sobre Dupla Excepcionalidade

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), representou um avanço significativo na garantia dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. No entanto, observa-se uma lacuna legislativa no que tange aos indivíduos com DE, ou seja, aqueles que apresentam simultaneamente AHSD e alguma deficiência ou transtorno do neurodesenvolvimento.

A ausência de diretrizes específicas para esse público dificulta processos essenciais, como identificação, avaliação e oferta de atendimento educacional adequado, que contemple tanto as necessidades relacionadas às AHSD quanto às demandas associadas à deficiência. Consequentemente, estudantes com DE, por vezes, passam despercebidos ou são diagnosticados de forma parcial, focando apenas na deficiência ou nas Altas Habilidades, o que pode resultar em intervenções pedagógicas inadequadas (Brasil, 2015).

As dificuldades de aprendizagem associadas às deficiências podem mascarar as Altas Habilidades desses estudantes, levando ao subaproveitamento de seu potencial. Essa situação pode gerar frustração e desinteresse, decorrentes do descompasso entre as demandas escolares e suas capacidades, culminando em problemas comportamentais tanto em sala de aula quanto em outros contextos sociais (Neihart et al., 2016).

A desigualdade de oportunidades para estudantes com DE, quando suas necessidades específicas não são atendidas, limita seu desenvolvimento e aprendizado. A falta de reconhecimento e de um ambiente escolar que acolha suas particularidades pode resultar em baixa autoestima, dificuldades de socialização e,

em casos mais graves, evasão escolar. Além disso, a sociedade perde ao não aproveitar plenamente os talentos desses indivíduos, que poderiam contribuir significativamente para o avanço social e cultural (Alencar; Fleith, 2001).

Embora a LBI e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) sejam marcos legais importantes para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, a ausência de diretrizes específicas para a DE representa um desafio a ser superado. É imperativo que ações sejam implementadas para assegurar que todos os estudantes, independentemente de suas características, tenham acesso a uma educação de qualidade, que promova o desenvolvimento integral de seu potencial (Brasil, 2008).

A falta de uma definição clara e consensual de DE contribui para a invisibilidade legislativa desses indivíduos. Sem uma legislação específica que reconheça e aborde suas necessidades únicas, as políticas educacionais frequentemente falham, não fornecendo o suporte necessário para que esses alunos prosperem (Nakano, 2021).

A DE exige uma abordagem educacional e social diferenciada, que inclua a formação adequada de professores, a implementação de políticas públicas específicas e a criação de ambientes escolares de apoio. A identificação precoce e as intervenções personalizadas são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico e social desses alunos, permitindo que alcancem seu máximo potencial (Reis et al., 2014).

A legislação brasileira oferece uma base para o atendimento educacional de alunos com DE, mas ainda existem lacunas significativas na implementação prática dessas normas. É essencial promover uma abordagem mais integrada e multiprofissional que considere tanto as altas habilidades quanto às dificuldades associadas, garantindo, assim, o suporte adequado para o desenvolvimento pleno desses indivíduos (Brasil, 1996).

4 OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral

Elaborar um guia para a formulação de políticas públicas, fundamentado na perspectiva dos pais e cuidadores de alunos com Dupla Excepcionalidade (AHSD e TEA).

4.2. Objetivos Específicos

- I. Mapear a legislação nacional referente à Dupla Excepcionalidade.
- II. Elaborar e validar instrumentos para a coleta de dados.
- III. Aplicar os instrumentos para responsáveis e/ou cuidadores pertencentes a grupos de acolhimento a superdotados e/ou autistas.
- IV. Realizar rodas de conversa sobre a Dupla Excepcionalidade.
- V. Analisar percepções e conhecimentos dos responsáveis a partir dos dados coletados durante as rodas de conversa.

5. MÉTODO DA PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida em 2 etapas: em um primeiro momento, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a legislação brasileira no que tange à identificação e atendimento aos indivíduos superdotados, os que estão no Espectro Autista e os que apresentam as duas características simultaneamente (dupla excepcionalidade). O levantamento foi de natureza exploratória voltada à identificação de tendências, lacunas e perspectivas que pudessem fomentar novas perguntas e investigações no campo (Gil, 2008). Em um segundo momento, foi realizado um estudo do tipo descritivo-analítico com abordagem quantitativa e qualitativa (Condurú; Pereira, 2010). Para a obtenção dos resultados, foi realizada pesquisa participante (Gil, 2008).

5.1. Comitê de Ética

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e aprovada sob o parecer nº 7.258.631/2025. Durante todas as etapas, foram seguidos rigorosamente os princípios éticos estabelecidos pela Resolução CNS nº 466/2012, que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil.

5.2. Busca por Legislações

A primeira etapa da pesquisa consistiu em buscas por legislações que abarquem a Dupla Excepcionalidade. Elas foram realizadas no site LexML(<https://www.lexml.gov.br>), uma rede de informação Legislativa e Jurídica que traz todas as legislações no âmbito federal, estadual e municipal do Brasil, importante ressaltar que o recorte temporal utilizado contempla o período de 2020 a 2024.

A pesquisa documental incluiu diversos descritores para garantir um levantamento abrangente das normativas relacionadas à Dupla Excepcionalidade. Inicialmente, foram utilizados descritores como Altas Habilidades OU Superdotação e Altas Habilidades E Superdotação, a fim de identificar documentos que abordassem o reconhecimento e o atendimento educacional de indivíduos com essas características.

Posteriormente, foram realizadas buscas combinando com operadores booleanos ("AND", "OR"): 'Autismo', 'Altas Habilidades', 'Superdotação', 'Autismo', 'Altas Habilidades', 'Superdotação', buscando normativas que contemplassem tanto as habilidades cognitivas avançadas quanto os desafios associados ao espectro autista.

Além disso, foram exploradas buscas específicas com terminologias mais detalhadas, como Transtorno do Espectro Autista E Superdotação e Transtorno do Espectro Autista E Altas Habilidades, permitindo um refinamento na identificação de documentos voltados para políticas públicas e diretrizes educacionais para esse grupo.

5.3. Público-Alvo da Pesquisa

A pesquisa teve como público-alvo responsáveis por crianças e jovens, especificamente aqueles com AHSD e/ou TEA. A coleta de dados ocorreu em dois contextos distintos para abranger diferentes vivências:

Primeiramente, foram envolvidos os responsáveis pelos alunos participantes do XIII Curso de Verão para Alunos Superdotados da UFF. Este grupo era composto por famílias cujas crianças e jovens já haviam sido previamente identificados com AHSD.

Em um segundo momento, a pesquisa contemplou responsáveis integrantes de grupos de apoio a famílias de pessoas autistas: o Grupo de Apoio a Mães de Crianças Autistas de Maricá (GAMAM) e o Grupo de Apoio a Indivíduos Autistas de Rio Bonito (GAIARB). Neste caso, o público consistiu em responsáveis por crianças e jovens já diagnosticados com TEA.

Essa abordagem metodológica permitiu contemplar distintas perspectivas familiares – tanto aquelas cujo ponto de partida foi o diagnóstico de AHSD quanto as que iniciaram pela identificação do TEA, enriquecendo significativamente a análise das demandas e experiências relacionadas à DE

Para assegurar o sigilo e a confidencialidade das informações, todos os participantes foram identificados por códigos alfanuméricos compostos pela letra “P” seguida de numeração sequencial. Ao longo do trabalho, os familiares de crianças e adolescentes com Altas Habilidades ou Superdotação serão referidos como Grupo AHSD, enquanto aqueles vinculados a estudantes com Transtorno do Espectro Autista serão identificados como Grupo TEA.

5.3.1. XIII Curso de Verão para Alunos Superdotados da UFF

Em sua XIII edição, o Curso de Verão para Alunos Superdotados da UFF é organizado pelo grupo de pesquisa Desenvolvimento e Inovação em Ensino de Ciências (DIECI-UFF) em parceria com o projeto Escola de Inclusão da UFF.

Ele acontece sempre em uma semana das férias de janeiro, ofertando Oficinas Interativas para 36 crianças e adolescentes identificados com AHSD oriundos da Educação Básica, de escolas públicas e privadas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (Nogueira et al., 2020). Concomitantemente,

são ofertadas atividades no formato de rodas de conversa ou palestras para os responsáveis dos alunos participantes.

5.3.2. Caminhada de conscientização mundial sobre autismo das cidades de Maricá (GAMAM) e Rio Bonito (GAIARB)

A pesquisa de campo deste estudo foi desenvolvida junto a dois importantes coletivos atuantes no estado do Rio de Janeiro: o Grupo de Apoio a Mães de Autistas de Maricá (GAMAM) e o Grupo de Apoio a Indivíduos Autistas de Rio Bonito (GAIARB). Ambos emergem da mobilização familiar e comunitária em torno da defesa de direitos, do acolhimento e da construção de políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo espaços de escuta, fortalecimento e articulação social.

A coleta de dados ocorreu durante as caminhadas de conscientização sobre o autismo, realizadas anualmente no mês de abril, no contexto da campanha internacional “Abril Azul”. Esses eventos, que reúnem familiares, pessoas autistas e apoiadores da causa, configuram ambientes de mobilização afetiva e cidadã, onde se compartilham vivências, se ampliam redes de apoio e se reivindica visibilidade social para a neurodiversidade.

O GAMAM, fundado em 2016 por mães de crianças atendidas no SAREM (Serviço de Atendimento de Reabilitação Especial de Maricá), consolidou-se como um coletivo de referência em apoio mútuo, orientação familiar e incidência política local. Composto por mulheres de diversas origens, formações e trajetórias, o grupo atua promovendo encontros periódicos, rodas de conversa, campanhas de informação e ações em defesa de melhores condições de atendimento e inclusão para pessoas autistas no município.

Uma de suas conquistas mais expressivas foi a idealização da Casa do Autista de Maricá, um centro público, gratuito e multidisciplinar voltado ao atendimento de pessoas com TEA. A proposta nasceu a partir de escutas coletivas organizadas pelo grupo e foi formalizada em um projeto entregue à Prefeitura em 2018. Desde então, as integrantes do GAMAM acompanharam todas as etapas da iniciativa — do desenho arquitetônico às discussões com o poder público e à execução da obra — como parte de um processo de participação ativa e engajada.

Já o GAIARB tem suas raízes na trajetória pessoal de sua fundadora, diagnosticada tardiamente com Dupla Excepcionalidade (AHSD e TEA). Sua experiência de invisibilidade diagnóstica, marcada por dificuldades de compreensão, acesso a apoios e construção de identidade, impulsionou a criação de um coletivo voltado à informação, acolhimento e conscientização sobre o autismo. O grupo atua em Rio Bonito com ações educativas, encontros de apoio, eventos de sensibilização e campanhas contra o estigma, o seu foco é a valorização da neurodiversidade e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Ambos os grupos ainda não possuem sede física própria, mas contam com uma presença ativa nas redes sociais e em grupos virtuais de troca. Por meio dessas plataformas, realizam convites para reuniões, divulgam ações, compartilham informações sobre direitos e organizam estratégias de apoio. Interessados em conhecer ou acompanhar suas atividades podem encontrá-los no Instagram: o GAMAM utiliza o perfil @gama_maesatipicas e o GAIARB está presente como @gaiarb_rj.

As histórias do GAMAM e do GAIARB revelam a potência das redes formadas a partir da escuta e da dor transformada em ação. São exemplos vivos de como o protagonismo de mães, familiares e pessoas neurodivergentes pode gerar impactos concretos na construção de políticas públicas mais humanas, sensíveis e inclusivas, contribuindo para a valorização da diversidade e a ampliação de direitos.

5.4. Construção e Validação do Questionário

Dois questionários semiestruturados foram elaborados para coletar dados junto aos responsáveis por alunos com DE (AHSD e TEA). O primeiro questionário visava traçar o perfil sociodemográfico dos participantes, enquanto o segundo buscava compreender as percepções e necessidades das famílias.

Antes da aplicação, os questionários foram submetidos a um processo de validação por especialistas na área de Dupla Excepcionalidade. Três profissionais participaram da análise:

1. Uma psicopedagoga com experiência no atendimento de

- crianças superdotadas e com DE;
2. Um professor doutor especializado em Superdotação;
 3. Uma doutora em Educação Especial com foco em DE.

Os especialistas avaliaram os instrumentos quanto à clareza, relevância das perguntas e abrangência dos temas abordados. Após essa análise, ajustes foram realizados para garantir que os questionários fossem adequados ao público-alvo e alinhados aos objetivos da pesquisa.

Os critérios utilizados para validação incluíram: clareza - verificar se as perguntas eram compreensíveis para os participantes; relevância - avaliar se os itens abordavam aspectos essenciais sobre DE; exaustividade - garantir que os instrumentos cobriam as dimensões necessárias para responder às questões da pesquisa.

5.5. A roda de conversa

A roda de conversa foi cuidadosamente estruturada para proporcionar um ambiente descontraído e acolhedor, incentivando a participação ativa dos responsáveis. Utilizando os resultados obtidos nos questionários como ponto de partida, as discussões foram direcionadas para aprofundar o entendimento das dificuldades e necessidades relatadas pelas famílias.

O principal objetivo foi estimular os responsáveis a refletirem sobre as características de seus filhos, promovendo uma autoavaliação e o compartilhamento de experiências.

5.5.1. Oficina para responsáveis dos indivíduos com AHSD

No segundo dia do XIII Curso de Verão para Alunos Superdotados da UFF, foi realizada uma oficina fundamental para a presente pesquisa, direcionada aos pais e responsáveis, intitulada: “O que é Dupla Excepcionalidade? A Importância da sua aceitação pelos pais”. Durante esta oficina, uma dinâmica participativa e elucidativa foi proposta: os pais e responsáveis (N=33) foram organizados em

pequenos grupos. A cada um desses grupos, foram distribuídas diversas palavras-chave.

A tarefa central consistia em analisar essas palavras e classificá-las em três categorias distintas: aquelas que os participantes associavam predominantemente às AHSD, aquelas que remetiam ao TEA e, crucialmente, aquelas que consideravam comuns a ambas as condições, indicando assim uma possível manifestação de Dupla Excepcionalidade.

Essa atividade de categorização visava estimular o debate, a troca de percepções e a reflexão aprofundada sobre as características de cada condição isoladamente, mas, sobretudo, sobre a intersecção entre elas. Ao identificarem palavras aplicáveis tanto à AHSD quanto ao TEA, os pais eram convidados a visualizar e discutir concretamente o conceito de Dupla Excepcionalidade e os desafios inerentes à sua aceitação e compreensão no contexto familiar. A dinâmica serviu, portanto, como um catalisador para externalizar conhecimentos prévios, desmistificar conceitos e construir um entendimento mais nuançado sobre o tema central da oficina.

5.5.2. Roda de Conversa para responsáveis dos indivíduos com TEA

A roda de conversa online sobre Dupla Excepcionalidade (AHSD e TEA) foi concebida como um espaço para fomentar o diálogo, a troca de experiências e uma reflexão aprofundada entre os participantes. Buscando facilitar a participação, esta atividade foi oferecida em dois horários distintos (9h às 11h e 18h às 20h) no dia 08 de maio de 2025.

O encontro convidou os presentes (N=5) a explorarem o conceito de Dupla Excepcionalidade por meio de uma atividade interativa que estimulou o compartilhamento de vivências e percepções sobre as características e desafios desses perfis singulares.

A dinâmica teve início com a apresentação de situações, comportamentos e traços frequentemente observados em crianças e jovens com AHSD, TEA ou ambos. Em seguida, foi apresentada aos participantes uma lista de palavras e expressões emblemáticas dessas condições, como 'facilidade de aprendizagem', 'dificuldade em interações sociais', 'excelente memória', 'atraso na fala' e 'uso repetitivo da linguagem'.

A tarefa proposta foi que, a partir dessa lista, os participantes discutissem e classificassem colaborativamente essas manifestações, identificando se as associavam predominantemente à AHSD, ao TEA, ou a uma intersecção entre ambos, o que poderia indicar a Dupla Excepcionalidade, gerando um rico debate sobre as semelhanças, diferenças e sobreposições entre AHSD e TEA. Essa troca possibilitou que identificassem como certos talentos podem, por vezes, mascarar desafios inerentes ao autismo, e como estereótipos podem dificultar o reconhecimento de habilidades latentes. Evidenciou-se, ainda, a complexidade do diagnóstico e a premência de abordagens educacionais específicas para esses indivíduos.

Ao final, a dinâmica culminou em uma reflexão coletiva sobre a importância crucial do reconhecimento da Dupla Excepcionalidade, do acolhimento e aceitação familiar, e da implementação de estratégias educacionais inclusivas e personalizadas, visando o desenvolvimento pleno das potencialidades dessas crianças e jovens. Essa abordagem interativa, alicerçada no diálogo e na classificação colaborativa de características, revelou-se fundamental para a construção de um entendimento mais amplo, sensível e embasado sobre a Dupla Excepcionalidade.

5.6. Aplicação dos questionários

5.6.1. Pais de alunos superdotados

O questionário foi aplicado para 33 responsáveis durante a oficina “O que é Dupla Excepcionalidade? A Importância da sua aceitação pelos pais”. Os participantes responderam ao 1º questionário (*Apêndice 1*) antes do início da palestra, com o objetivo de levantar informações sociodemográficas, e ao 2º questionário (*Apêndice 2*) após o encerramento. Nesse período, as crianças e adolescentes sob sua responsabilidade estiveram engajados em oficinas específicas, cuidadosamente planejadas de acordo com a faixa etária e seus interesses, o que proporcionou acolhimento e um ambiente seguro para eles. Essa organização favoreceu um momento de tranquilidade para os responsáveis,

permitindo que participassem das atividades com atenção e serenidade.

A apresentação da pesquisa, assim como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 3), foram assinados antes de iniciarem o preenchimento do 1º questionário (Apêndice 1). Os participantes tiveram a liberdade de não responderem a perguntas caso não se sentissem confortáveis. Durante todo o processo de coleta de dados, foram rigorosamente respeitados os princípios éticos e os termos de confidencialidade estabelecidos no TCLE (Apêndice 3), garantindo a privacidade e segurança das informações compartilhadas.

Ao final da Oficina, foi aplicado o segundo questionário (Apêndice 2), que tinha como objetivo verificar os diagnósticos dos tutelados, assim como as condições socioeconômicas dos familiares. Os responsáveis que quiseram deixaram seus contatos para serem convidados para Rodas de Conversa sobre o Tema Dupla Excepcionalidade. Os contatos contínuos permitirão ajustes metodológicos e contribuirão para a construção de um documento fundamentado para subsidiar futuras políticas públicas voltadas ao atendimento da população com DE.

Os dados coletados nos questionários aplicados durante a Oficina foram sistematizados por meio de planilhas e gráficos elaborados com o auxílio dos softwares Microsoft Excel e Word, versão Windows 10. A abordagem utilizada integrou análises qualitativas e quantitativas, permitindo uma visão aprofundada das demandas e desafios enfrentados pelos indivíduos com Dupla Excepcionalidade e suas famílias.

5.6.2. Pais das crianças autistas

A primeira etapa da coleta de dados com responsáveis por indivíduos com TEA consistiu na aplicação de um questionário inicial, realizada durante as caminhadas de conscientização mundial sobre o autismo — eventos anuais alusivos ao Abril Azul — nos municípios de Maricá e Rio Bonito. Nessas ocasiões, a pesquisadora esteve presente junto ao Grupo de Apoio a Mães de Autistas de Maricá (GAMAM) e ao Grupo de Apoio a Indivíduos Autistas de Rio Bonito

(GAIARB), buscando contemplar as perspectivas de famílias cuja identificação primária dos filhos foi o TEA. Ao todo, foram coletadas 16 respostas em Rio Bonito e 27 em Maricá, totalizando 43 questionários respondidos.

Todos os participantes manifestaram interesse e consentiram em participar da etapa seguinte do estudo — as rodas de conversa online — que tinham como objetivo promover o diálogo sobre desafios, potencialidades e estratégias de inclusão para pessoas com Dupla Excepcionalidade (AHSD e TEA). Para viabilizar essa etapa, foi criado um grupo no WhatsApp, a fim de facilitar a comunicação. Nesse espaço, a pesquisadora disponibilizou uma enquete para identificar os horários mais adequados, considerando que muitos responsáveis possuíam agendas já comprometidas com terapias e cuidados diários voltados aos filhos.

A aplicação do primeiro questionário exigiu uma abordagem personalizada: a pesquisadora frequentemente conversava individualmente com os participantes, muitas vezes enquanto estes acompanhavam os filhos, em um contexto no qual, diferentemente do grupo AHSD, não havia outra pessoa disponível para supervisionar as crianças naquele momento. Apesar do interesse inicial, as dificuldades logísticas e a sobrecarga cotidiana impactaram diretamente na adesão. Assim, dos 43 responsáveis que confirmaram participação, apenas 5 mães compareceram efetivamente à roda de conversa, realizada de forma online e foi oferecida em dois horários distintos (9h às 11h e 18h às 20h) no dia 08 de maio de 2025.

Paralelamente, foi conduzida a análise de um segundo instrumento — o *Forms* “Questionário 2: Conhecendo a Dupla Excepcionalidade (Superdotação e Autismo)” — que obteve cinco respostas. Esse material forneceu dados mais detalhados sobre o perfil e o interesse dos participantes, seu nível de compreensão sobre a dupla excepcionalidade, os diagnósticos de seus filhos, o reconhecimento escolar das necessidades específicas e as prioridades de atendimento apontadas por eles.

5.7. Tratamento dos dados

Os dados coletados nos questionários aplicados durante a Oficina foram

sistematizados por meio de planilhas e gráficos elaborados com o auxílio dos softwares Microsoft Excel e Word, versão Windows 10. A abordagem utilizada integrou análises qualitativas e quantitativas, permitindo uma visão aprofundada das demandas e desafios enfrentados pelos indivíduos com Dupla Excepcionalidade e suas famílias.

Com a coleta e análise de dados, pretende-se construir um Guia para a Formulação de Políticas Públicas, a partir da perspectiva dos pais e cuidadores sobre alunos com Dupla Excepcionalidade (AHSD e TEA), para que se reconheçam as necessidades dos indivíduos com Dupla Excepcionalidade em sua integralidade.

5.8. Organização do material para a construção do guia

Após a análise da legislação brasileira relacionada à identificação e ao atendimento de alunos Superdotados, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e/ou com Dupla Excepcionalidade, foi realizado um levantamento das principais demandas legislativas vigentes no país.

Esse levantamento, aliado aos dados obtidos por meio dos questionários aplicados aos responsáveis, serviu como base para a seleção dos materiais e das seções que compõem o guia.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1. Busca por Legislações Brasileiras sobre Dupla Excepcionalidade

O presente trabalho teve como objetivo inicial mapear legislações e diretrizes que reconheçam e proponham medidas específicas para indivíduos com DE. Para isso, foi realizada uma pesquisa legislativa, apresentada no quadro 3, utilizando os descritores: *“Dupla Excepcionalidade E Altas Habilidades OU Superdotação”* e *“Dupla Excepcionalidade E Transtorno do Espectro Autista OU Autismo E*

Superdotação OU Altas Habilidades”.

Quadro 3: Pesquisa Legislativa

Legislação/ Norma	Autismo	Altas Habilidades ou Superdotação	Autismo e/ou Superdotação	TEA e/ou Superdotação
Jurisprudência	38	1	1	0
Decreto	6	0	0	0
Leis	39	6	4	1
Lei Complementar	0	1	1	0
Projeto de Lei	21	12	12	0
Proposta de Emenda Constitucional (PEC)	0	0	0	0
Doutrina	2	0	0	0
Resolução	1	0	0	0

Apesar dos avanços na legislação brasileira, a Educação Inclusiva para alunos com DE ainda enfrenta desafios significativos, especialmente pela ausência de políticas públicas que contemplem suas necessidades de forma específica. Embora a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) assegurem o direito à educação tanto para pessoas com deficiência quanto com AHSD, ainda não existem diretrizes que considerem as particularidades da Dupla Excepcionalidade.

Como destacam Vieira e Wellausen (2012), os estudos na área de Educação Especial ainda se concentram, em sua maioria, de forma isolada, seja em Altas Habilidades ou Superdotação, seja no Transtorno do Espectro Autista, sem explorar adequadamente as especificidades da DE.

A partir dos dados sistematizados no quadro 3, foi elaborado o Gráfico 1, com o objetivo de apresentar visualmente os resultados. Essa representação gráfica reforça de forma ainda mais evidente a lacuna nas políticas públicas brasileiras, ao demonstrar a ausência de legislações, normas ou diretrizes que reconheçam formalmente a DE como uma condição específica no ordenamento jurídico nacional.

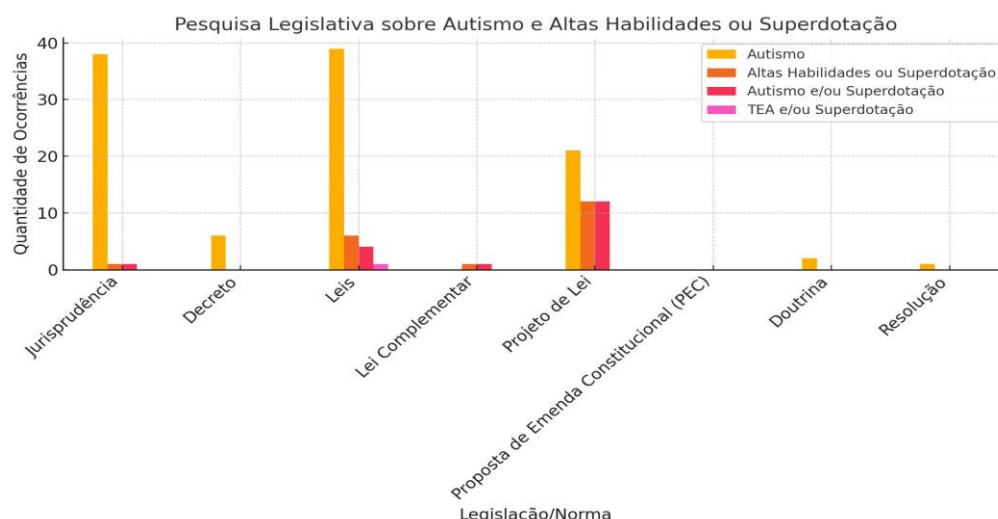


Gráfico 1: Pesquisa Legislativa

O panorama legislativo brasileiro evidencia diferenças significativas na atenção normativa destinada ao TEA, às AHSD e à DE. Enquanto o autismo já é contemplado por um número expressivo de leis, decretos e projetos em diferentes esferas do poder público, observa-se que as normativas voltadas à superdotação ainda são relativamente limitadas — e aquelas que tratam especificamente da DE permanecem incipientes. Para ampliar a compreensão sobre o cenário jurídico atual, o quadro 4 reúne algumas das principais legislações e documentos que tratam especificamente das AHSD, mas que não mencionam o TEA. Ao destacar essas ausências, o quadro contribui para refletir sobre a necessidade de políticas mais integradas e sensíveis às múltiplas dimensões desses sujeitos

Quadro 4: Legislação e Documentos sobre o AHSD no Brasil, mas não inclui o TEA

LEGISLAÇÃO / DOCUMENTO	ANO	ÂMBITO	DESCRIPTORES UTILIZADOS	OBSERVAÇÕES
Constituição Federal	1988	Federal	Superdotação	Art. 205 garante o direito à educação. O Art. 208, inciso III, assegura o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência e com superdotação.
Lei nº 9.394 – LDB	1996	Federal	Superdotação	Art. 58 inclui os superdotados como público da Educação Especial; prevê atendimento especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Decreto nº 6.571	2008	Federal	Altas Habilidades ou Superdotação	Regulamenta o AEE; inclui alunos com AHSD no atendimento obrigatório pelas escolas públicas.
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC)	2008	Federal	Altas Habilidades ou Superdotação	Reconhece as AHSD como público da Educação Especial.

O quadro 4 evidencia o foco predominante na identificação e atendimento desse público, sem abordar de forma direta a relação com o TEA e a DE. Assim, o quadro evidencia que, apesar dos avanços no reconhecimento das AHSD, ainda há lacunas na legislação quanto à abordagem integrada com outros transtornos ou condições associadas, como o TEA.

Em relação às AHSD, o número de leis e projetos é consideravelmente menor quando comparado ao autismo. O indivíduo superdotado é reconhecido como público da Educação Especial desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), sendo a condição, posteriormente, reforçada por normas como a Lei 12.796/2013, que inclui expressamente as AHSD na legislação, e a Lei 13.234/2015, que trata da identificação, cadastramento e atendimento desses estudantes (Basso et al., 2020). Apesar dessas garantias legais, a efetivação das políticas ainda é limitada. Como destacam Basso et al. (2020, p. 454), “[...] o número de estudantes identificados e acompanhados [...] ainda é muito aquém do esperado”, e o registro nacional de alunos superdotados permanece apenas no papel em muitos estados.

Embora a legislação assegure direitos como a aceleração de estudos e o atendimento educacional especializado, ainda persiste um grande desconhecimento sobre sua aplicação e sobre as práticas pedagógicas adequadas ao público com Altas Habilidades ou Superdotação, o que compromete a efetividade das normas e resoluções vigentes (Basso et al., 2020).

No caso do TEA, a construção normativa é mais ampla e consolidada, abrangendo desde marcos federais, como a Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/2012) — que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA — até iniciativas estaduais, municipais e a criação de instrumentos como a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA. Essas normativas tratam de

aspectos diversos, como saúde, educação e inclusão social, conforme sistematizado no quadro 5, que apresenta os principais dispositivos legais e projetos de lei, em diferentes esferas federativas, que tratam dos direitos, garantias e políticas de inclusão para pessoas com TEA no Brasil.

Quadro 5: Legislações e Documentos sobre o TEA no Brasil, mas não inclui o AHSD

LEGISLAÇÃO / DOCUMENTO	ANO	ÂMBITO	DESCRITORES UTILIZADOS	OBSERVAÇÕES
Lei nº 12.764/2012 – Lei Berenice Piana	2012	Federal	Autismo	Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA.
Decreto nº 8.368/2014	2014	Federal	Autismo	Regulamenta a Lei 12.764/2012.
Lei nº 13.977/2020 – Lei Romeu Mion	2020	Federal	Autismo	Institui a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA.
Lei nº 17.134/2017 – revogada (Santa Catarina)	2017	Estadual (SC)	TEA, Superdotação	Mencionava TEA e superdotação; revogada integralmente.
Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência	2015	Federal	TEA	Abrange pessoas com TEA em direitos e garantias.
Projeto de Lei nº 260/2020 (RJ)	2020	Estadual (RJ)	Autismo	Cria diretrizes para inclusão escolar de alunos com TEA no RJ.
Lei nº 6.924/2021 (RJ – Niterói)	2021	Municipal (RJ)	Autismo	Garante prioridade no atendimento de pessoas com TEA nos serviços públicos.
Projeto de Lei nº 1193/2019	2019	Federal (PL)	TEA	Propõe atendimento multiprofissional a alunos com TEA.
Lei nº 6.357/2018 (AL)	2018	Estadual (AL)	Autismo	Institui a Semana de Conscientização sobre o Autismo e ações educativas.
Lei nº 17.198/2019 (SP)	2019	Estadual (SP)	Autismo	Obriga formação de professores sobre TEA no sistema estadual de ensino.

Apesar desses avanços legislativos, a implementação efetiva dessas

normas ainda enfrenta desafios, especialmente devido a lacunas na aplicação e à ausência de uma rede de suporte adequada, o que compromete a efetivação dos direitos das pessoas com TEA. O ativismo, a mobilização de famílias e associações, bem como a crescente visibilidade do autismo na mídia e na sociedade, impulsionam, constantemente, novas propostas legislativas.

Nesse contexto, destaca-se o papel fundamental das organizações não governamentais (ONGs) e associações de pais na defesa dos direitos das pessoas com TEA, uma vez que essas entidades, conforme apontam Ramos e Silva (2024), frequentemente suprem lacunas deixadas pelo Estado, oferecendo apoio, informação e serviços essenciais.

A articulação entre os diversos setores da sociedade, incluindo governos, ONGs, comunidade acadêmica e setor privado, é essencial para a criação de uma rede de apoio eficaz para pessoas com TEA. Essa colaboração tem o potencial de maximizar recursos e ampliar os impactos positivos das ações voltadas à inclusão e à garantia dos direitos desse público.

Em contraste, a Dupla Excepcionalidade, no cenário legislativo, é ainda mais incipiente. Existem pouquíssimas normas que abordam diretamente essa condição, e mesmo as que tangenciam o tema o fazem de maneira fragmentada e insuficiente. Um dos poucos exemplos recentes é o Projeto de Lei nº 3549/2024, que propõe instituir o Dia Nacional de Conscientização sobre a Dupla Excepcionalidade. Embora a proposta contribua para ampliar a visibilidade da temática, ela ainda não apresenta diretrizes concretas

Outros documentos relevantes, como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) e as Diretrizes do MEC sobre Altas Habilidades ou Superdotação (2022), reconhecem as AHSD como parte do público da Educação Especial. No entanto, não avançam na abordagem da coexistência com outras condições, como o Transtorno do Espectro Autista, deixando a Dupla Excepcionalidade em um espaço de invisibilidade normativa.

Diante disso, o quadro 6 apresenta uma síntese das principais legislações e documentos que, mesmo de forma indireta, dialogam com o tema da Dupla Excepcionalidade, evidenciando lacunas importantes no reconhecimento e no atendimento intersetorial desse grupo.

Quadro 6: Legislações e Documentos sobre Dupla Excepcionalidade (DE)

LEGISLAÇÃO / DOCUMENTO	ANO	ÂMBITO	DESCRIPTORIOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÕES
Projeto de Lei nº 3549/2024	2024	Federal	Dupla Excepcionalidade e TEA	Propõe o Dia Nacional de Conscientização sobre a DE; amplia visibilidade, sem diretrizes concretas de atendimento.
Lei nº 17.134/2017 (SC)	2017	Estadual (SC)	Superdotação e TEA	Mencionava atendimento a pessoas com AHSD e TEA, mas foi revogada judicialmente.

Massuda e Rangni (2017, p. 61) observam que “[...] a palavra excepcional, há pouco mais de três décadas, não aparece nos textos oficiais das políticas públicas da educação brasileira”, revelando uma invisibilidade histórica que impacta diretamente as ações de inclusão escolar. Essa ausência de reconhecimento explícito compromete não apenas a visibilidade da Dupla Excepcionalidade — caracterizada pela presença simultânea de Altas Habilidades ou Superdotação e alguma deficiência ou transtorno —, mas também a construção de políticas públicas integradas e sensíveis às especificidades desse público.

Diante desse contexto, torna-se essencial mapear o arcabouço legal existente para identificar os avanços, as lacunas e as possibilidades de articulação entre os diferentes setores. O quadro 7 oferece uma visão panorâmica das principais legislações brasileiras, organizadas por grupo (AHSD, TEA e DE), por área de atuação (Educação, Saúde e Prioridade Legal) e por esfera normativa. Essa sistematização permite compreender como as políticas públicas vêm sendo formuladas e em que ainda é necessário avançar para garantir o reconhecimento pleno e o atendimento adequado às múltiplas dimensões da Dupla Excepcionalidade.

Quadro 7: Marcos Legais sobre AHSD, TEA e DE

Grupo	Âmbito	Leis/Normativas	Observações
AHSD	Educação	- LDB (Lei nº 9.394/1996), Art. 58 e 59 - Lei nº 12.796/2013 - Lei nº 13.234/2015	Prevê AEE, flexibilização curricular e identificação.
	Saúde	- ECA (Lei nº 8.069/1990), Art. 7º e 11 - Constituição Federal, Art. 227	Garante atenção à saúde e desenvolvimento integral.
	Prioridade Legal	- Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013), Art. 2º e 4º	Reconhecimento indireto da condição.
TEA	Educação	- Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) - LDB (Lei nº 9.394/1996), Art. 58 e 59	Prevê AEE, recursos multifuncionais e inclusão escolar.
	Saúde	- Lei nº 8.069/1990 (ECA) - Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) - Lei nº 13.977/2020 (Lei Romeo Mion)	Direito ao diagnóstico precoce, terapias e cuidados continuados.
	Prioridade Legal	- Lei nº 10.048/2000 - Constituição Federal, Art. 227	Prioridade em filas, serviços públicos e programas sociais.
Dupla Excepcionalidade	Educação	- Projeto de Lei nº 3549/2024	Tratamento fragmentado nos marcos legais.
	Saúde	- Ausência de normativas específicas Princípios constitucionais de integralidade e equidade (Art. 196 da CF)	Falta de reconhecimento específico compromete a atenção integral.
	Prioridade Legal	- Não há legislação específica; direitos garantidos por associação indireta a TEA e AHSD	Dependência de leis associadas a TEA ou AHSD.

O quadro permite uma leitura clara dos avanços normativos conquistados, dos reconhecimentos indiretos e das persistentes lacunas na legislação brasileira. Evidencia-se a fragilidade na articulação entre os campos da educação, da saúde

e do direito, o que compromete a construção de diretrizes específicas para o atendimento da Dupla Excepcionalidade. A ausência de um reconhecimento oficial dessa condição contribui para sua invisibilidade nos marcos legais e institucionais, dificultando a identificação dos estudantes que apresentam, simultaneamente, Altas Habilidades ou Superdotação e alguma deficiência ou transtorno do desenvolvimento. Essa invisibilidade afeta diretamente o acesso a serviços adequados e integrados.

No campo acadêmico, a produção científica nacional sobre Dupla Excepcionalidade ainda é escassa e marcada por limitações teóricas e conceituais. Como destacam Condurú e Pereira (2010, p. 120), “[...] as investigações sobre esse tema ainda são emergentes no Brasil e é necessário construir uma definição compatível com os estudos internacionais.” Nesse sentido, Alves e Nakano (2015) enfatizam que o avanço das pesquisas e a inserção do tema nas políticas públicas dependem não apenas da disseminação científica, mas também da consolidação do termo com base na literatura internacional.

A ausência de políticas específicas acentua as desigualdades, restringindo o acesso a serviços essenciais para o desenvolvimento desses estudantes. Estudos indicam que a não identificação da Dupla Excepcionalidade pode gerar impactos significativos, como desmotivação, baixa autoestima, dificuldades de socialização e, em casos mais graves, evasão escolar (Neihart; Pfeiffer; Cross, 2015). Sem normativas claras, os encaminhamentos tendem a ser fragmentados — ora para programas voltados à superdotação, ora para os destinados às deficiências — sem considerar as singularidades da coexistência desses perfis. Esse desencontro compromete o suporte educacional, afetando o desempenho acadêmico, a motivação e o bem-estar emocional dos estudantes, e conduzindo à adoção de estratégias pedagógicas inadequadas.

Baum, Schader e Owen (2017) ressaltam que o êxito educacional dos alunos com Dupla Excepcionalidade depende de abordagens que reconheçam e cultivem seus talentos, ao mesmo tempo em que ofereçam suporte consistente às suas dificuldades, promovendo uma educação verdadeiramente inclusiva e responsiva às suas necessidades.

6.2. Análise das respostas dos questionários

No início da oficina intitulada “O que é Dupla Excepcionalidade? A Importância da sua Aceitação pelos Pais”, realizada presencialmente nas dependências da Universidade Federal Fluminense (UFF), durante o XIII Curso de Verão para Alunos Superdotados, foi aplicado um questionário (Apêndice 1) com o objetivo de conhecer o perfil das famílias dos alunos com diagnóstico de superdotação e o entendimento que tinham a respeito da superdotação. Nesse contexto, 33 responsáveis responderam ao instrumento.

Por outro lado, no grupo de responsáveis por crianças e adolescentes diagnosticados com TEA (n=43), o processo ocorreu em um contexto bastante distinto. A coleta de dados foi realizada durante os encontros presenciais conhecidos como as “Caminhadas da Conscientização do Autismo”, bem como em outros eventos voltados para o lazer e socialização das crianças autistas. Nesse ambiente, os responsáveis permaneciam em constante deslocamento, acompanhando seus filhos, o que exigia deles atenção constante às demandas sensoriais, comportamentais e de segurança das crianças.

6.2.1. Responsáveis das crianças inicialmente identificadas com AHSD

O perfil dos responsáveis por crianças inicialmente identificadas com AHSD, incluindo aqueles cujos filhos receberam diagnóstico de Dupla Excepcionalidade (DE), está apresentado nos Quadros 8 a 12, compondo um retrato detalhado da amostra deste estudo.

Os dados sistematizados no Quadro 8 não apenas delineiam o perfil sociodemográfico dos responsáveis pelas crianças identificadas com AHSD, como também oferecem pistas relevantes sobre o contexto em que se constroem suas experiências, percepções e enfrentamentos.

Quadro 8: Faixa Etária (AHSD)

IDADE	QUANTIDADE
20 a 30 anos	1
31 a 40 anos	2
41 a 50 anos	21

51 a 60 anos	6
61 anos ou mais	2
Não Informado	1
TOTAL	33

A análise do Quadro 8 indica que a maioria dos responsáveis pelo grupo de crianças atendidas nessa edição do curso de verão encontra-se entre 35 e 55 anos, com maior concentração na faixa dos 40 anos. São adultos em fase ativa da vida, tanto no campo profissional quanto nas responsabilidades familiares. Essa etapa do ciclo de vida tende a refletir um envolvimento mais direto com os processos de acompanhamento escolar e terapêutico, influenciando o modo como esses cuidadores percebem e enfrentam os desafios associados à Dupla Excepcionalidade.

Essa condição etária se articula diretamente com os dados apresentados no Quadro 9, que revelam um predomínio de participantes casados ou em união estável. Essa configuração sugere a presença de uma estrutura familiar relativamente organizada, o que, em tese, poderia favorecer o compartilhamento de responsabilidades. No entanto, conforme destacam Nakano, Batagin e Fusaro (2021, p. 8), o desconhecimento institucional sobre a Dupla Excepcionalidade contribui para o surgimento de obstáculos que afetam toda a dinâmica familiar, resultando em sobrecarga emocional, insegurança e sensação de isolamento — muitas vezes assumidos majoritariamente pelas mães, que seguem como principais articuladoras dos cuidados e encaminhamentos necessários.

Quadro 9: Estado Civil (AHSD)

ESTADO CIVIL	QUANTIDADE
Casada/União Estável com companheiro(a)	26
Solteiro(a)	4
Divorciado(a)	2
Viúvo(a)	1
TOTAL	33

A maioria dos participantes declarou estar casada ou em união estável, o que aponta para a presença de núcleos familiares relativamente organizados. Essa configuração tende a favorecer a divisão das responsabilidades no cuidado e acompanhamento dos filhos, embora tal partilha nem sempre ocorra de forma

equitativa. Na prática, observa-se que a sobrecarga costuma recair sobre as mães, que seguem como principais responsáveis pela mediação dos processos de escolarização, busca por diagnóstico e articulação com os serviços de saúde. Tal cenário evidencia uma lógica de gênero amplamente discutida em estudos sobre parentalidade e educação inclusiva, que mostram como as mulheres frequentemente assumem, de forma isolada, a centralidade do cuidado.

Essa dinâmica se torna ainda mais compreensível quando observamos os dados do Quadro 10, que indicam que a maioria dos domicílios é composta por três ou quatro pessoas.

Quadro 10: Composição Familiar (AHSD)

COMPOSIÇÃO FAMILIAR	QUANTIDADE
2	1
3	14
4	16
5	2
TOTAL	33

A estrutura doméstica predominantemente compacta, composta por poucos membros e, em muitos casos, com apenas uma ou duas crianças, pode influenciar diretamente a forma como se organiza o cuidado de uma criança com AHSD. Em arranjos familiares reduzidos, há uma tendência de maior centralização da atenção e dos esforços em cada filho, o que pode favorecer um acompanhamento mais próximo e personalizado. No entanto, essa configuração também intensifica as exigências emocionais e práticas sobre os cuidadores, especialmente sobre as mães, que, conforme apontam estudos de Nakano, Batagin e Fusaro (2021), seguem assumindo o protagonismo nas ações relacionadas à identificação, escolarização e busca por apoio especializado.

Esse cenário contribui para o aumento da pressão e do sentimento de responsabilidade sobre o desenvolvimento integral da criança, o que pode gerar sobrecarga e desgaste emocional. Baum, Schader e Owen (2017) ressaltam que o equilíbrio entre apoio e desafio é essencial para crianças com Dupla Excepcionalidade, mas esse equilíbrio também precisa se estender aos cuidadores, cuja saúde emocional impacta diretamente na qualidade do suporte oferecido. Assim, embora famílias com menos filhos possam dedicar mais tempo e atenção, elas também tendem a enfrentar de forma mais intensa os efeitos da ausência de

uma rede de apoio ampla e de políticas públicas efetivas.

Essas questões se entrelaçam com os dados apresentados no quadro 11, que evidenciam um perfil de participantes com elevado nível de instrução, abrangendo desde a graduação até a pós-graduação *stricto e lato sensu*.

Quadro 11: Grau de Escolaridade (AHSD)

GRAU DE ESCOLARIDADE	QUANTIDADE
Especialização	14
Ensino Médio	8
Ensino Superior	7
Doutorado	4
TOTAL	33

Esse perfil revela um grupo com alto capital cultural, o que pode favorecer o acesso à informação, à busca por direitos e à compreensão crítica sobre os sistemas educacional e de saúde. Contudo, mesmo com essa qualificação, os relatos evidenciam barreiras persistentes relacionadas à identificação e ao atendimento adequado da Dupla Excepcionalidade. Isso confirma a afirmação de Nakano, Batagin e Fusaro (2021, p. 8) de que o desconhecimento generalizado sobre a temática pode gerar diagnósticos equivocados e sofrimento tanto para os indivíduos com DE quanto para suas famílias — mesmo em contextos de maior escolarização.

Essas questões ganham novos contornos quando analisamos o Quadro 12, que revela uma variedade de ocupações, um grupo profissionalmente diverso, mas atravessado por experiências comuns em relação às dificuldades de reconhecimento e de acesso a serviços adequados.

Quadro 12: Ocupação Atual (AHSD)

OCUPAÇÃO ATUAL	QUANTIDADE
Professor(a)	12
Dona de Casa	4
Neuropsicopedagoga	1
Assistente Social	2
Psicóloga	1
Médica	1
Assistente Social	1
Empresária	1
Manicure	1
Fisioterapeuta	1
Produtora de eventos	1

Técnico de Telecomunicações	1
Empreendedora	1
Designer	1
Analista de Sistema	1
Advogada	1
Técnico Químico	1
Funcionário Público	1
TOTAL	33

Com base na análise da ocupação dos participantes, é possível concluir que, apesar da diversidade de trajetórias profissionais — com forte presença de atuantes nas áreas da educação e da saúde, todos compartilham desafios semelhantes no enfrentamento das barreiras impostas pela invisibilidade da Dupla Excepcionalidade.

6.2.2. Responsáveis das crianças inicialmente identificadas com Autismo

No perfil dos responsáveis por crianças com TEA, os dados apresentados nos Quadros 13 a 17 reforçam que os responsáveis por indivíduos com TEA são, majoritariamente, femininos, com 82,7% das cuidadoras sendo mães.

A faixa etária dos responsáveis varia de 22 a 66 anos, com média em torno de 41 anos, padrão semelhante ao observado entre os responsáveis por crianças com AHSD. Em relação à escolaridade, predomina o ensino médio completo, embora haja casos de ensino fundamental e superior, indicando um nível intermediário de formação.

Quanto à ocupação, destaca-se a presença significativa de donas de casa além de profissionais da área de serviços, administração, saúde e educação, com uma parcela dos responsáveis dedicando-se integralmente ao cuidado dos filhos. A maioria dos participantes é casada ou vive em união estável, residindo em famílias pequenas, geralmente compostas por três ou quatro membros.

O impacto do diagnóstico de TEA na vida profissional dos cuidadores é evidente: muitos relatam a necessidade de reduzir ou abandonar atividades laborais para se dedicar ao cuidado dos filhos, o que acarreta desafios para a organização familiar, sobrecarga física e emocional, e dificuldades para o atendimento pleno das necessidades das crianças.

Quadro 13: Faixa Etária (TEA)

IDADE	QUANTIDADE
20 a 30 anos	3
31 a 40 anos	15
41 a 50 anos	14
51 a 60 anos	7
61 anos ou mais	3
Não Informado	1
TOTAL	43

A faixa etária dos responsáveis por crianças com TEA varia de 22 a 66 anos, com média em torno de 41 anos, perfil semelhante ao observado entre os cuidadores do grupo AHSD. Esse dado indica um grupo em fase ativa da vida profissional e familiar, em que a dedicação ao cuidado demanda constante reorganização da rotina e da vida pessoal. Tal contexto etário pode intensificar o impacto do diagnóstico, especialmente entre mães jovens, que, frequentemente, enfrentam desafios adicionais na conciliação entre maternidade, vida conjugal e inserção no mercado de trabalho.

Quadro 14: Estado Civil (TEA)

ESTADO CIVIL	QUANTIDADE
Casada/União Estável com companheiro(a)	26
Solteiro(a)	9
Divorciado(a)	5
Viúvo(a)	2
Não Informado	1
TOTAL	43

A maioria dos participantes é casada ou vive em união estável, indicando, à primeira vista, uma configuração familiar que poderia favorecer o compartilhamento das responsabilidades parentais. No entanto, os relatos e estudos complementares apontam para uma realidade distinta. Segundo Vilanova et al. (2022, p. 2), embora haja presença paterna no domicílio, a participação efetiva dos pais no cuidado tende a ser limitada. Muitos depoimentos revelam ausência de apoio prático, resistência à aceitação do diagnóstico e tensão conjugal, aspectos que intensificam a sobrecarga emocional e física das mães, que se tornam cuidadoras quase exclusivas. A solidão materna no exercício do cuidado reforça desigualdades de gênero profundamente enraizadas.

Quadro 15: Composição Familiar (TEA)

COMPOSIÇÃO FAMILIAR	QUANTIDADE
2	5
3	19
4	11
5	6
6	1
Não informado	1
TOTAL	43

A maioria das famílias participantes é composta por três ou quatro membros, o que sugere uma estrutura doméstica compacta. Essa configuração pode permitir uma atenção mais centrada à criança com TEA, mas também amplia a concentração de demandas sobre poucos adultos. Quando somada à baixa participação paterna, essa dinâmica agrava a sobrecarga materna, gerando desgaste físico, emocional e social. Kawa et al. (2018) destacam que o cuidado de crianças com TEA impõe desafios multifacetados às mães, refletindo-se em sobrecarga objetiva e subjetiva, alterações nos papéis familiares e implicações diretas na saúde mental dessas mulheres.

Quadro 16: Grau de Escolaridade (TEA)

GRAU DE ESCOLARIDADE	QUANTIDADE
Fundamental Completo	2
Especialização	6
Ensino Médio	24
Ensino Superior	10
Não informado	1
TOTAL	43

Os dados revelam predomínio do ensino médio completo entre os responsáveis, com menor incidência de ensino superior quando comparado ao grupo AHSD. Essa diferença evidencia um nível intermediário de formação acadêmica, o que pode interferir tanto na busca por informações quanto na mediação com os serviços especializados. Como destacam Zanatta e Pereira (2014), as trajetórias educacionais das mães cuidadoras costumam ser interrompidas ou impactadas negativamente pelas exigências intensas do cuidado contínuo. Assim, mesmo com dedicação integral, muitas dessas mães enfrentam dificuldades para compreender, reivindicar ou acessar plenamente os direitos

previstos para seus filhos.

Quadro 17: Ocupação Atual (TEA)

OCUPAÇÃO ATUAL	QUANTIDADE
Administradora	1
Advogada	4
Balconista	1
Costureira	1
Cozinheiro	1
Do Lar	24
Enfermeira	2
Funcionária Pública	1
Professora	2
Rota Escolar	1
Técnico de Elevador	1
Técnico de Enfermagem	1
Vigilante	1
Não informado	2
TOTAL	43

A análise da ocupação evidencia a predominância de mulheres fora do mercado de trabalho formal, muitas das quais se dedicam exclusivamente ao cuidado dos filhos com TEA. Esse afastamento da vida laboral está diretamente relacionado à intensidade das demandas diárias impostas pelo diagnóstico. Conforme reforça Kawa et al. (2018), o ônus do cuidado de crianças autistas gera profundas transformações nos papéis sociais e profissionais das mulheres, comprometendo sua autonomia financeira, saúde emocional e inclusão produtiva. Esses dados convergem com os achados qualitativos do presente estudo, que apontam sentimentos de exaustão, isolamento e abandono — especialmente quando o cuidado é exercido de forma solitária. Isso evidencia a urgência de políticas públicas que reconheçam e apoiem o papel das mães cuidadoras, mitigando os impactos sociais e emocionais associados ao cuidado contínuo no contexto do autismo infantil.

A análise comparativa das respostas evidencia que, em ambos os grupos investigados, observa-se o predomínio de mulheres. Contudo, destaca-se que, entre as mães de crianças autistas, o nível de escolaridade tende a ser inferior quando comparado ao grupo de mulheres com filhos com AHSD. Adicionalmente, verifica-se que a maioria dessas mulheres não está inserida no mercado de trabalho formal, o que sugere uma relação direta com a necessidade de dedicação

ao cuidado dos filhos.

Essa dinâmica é corroborada por estudos como o de Kawa et al. (2018), que demonstram que o cuidado parental de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) impõe um ônus significativo aos cuidadores, especialmente às mães, refletindo-se tanto em sobrecarga objetiva quanto subjetiva, maior incidência de sofrimento psicológico e menor inserção no mercado de trabalho formal.

Os dados apontam que mães de crianças autistas frequentemente apresentam menor escolaridade e se afastam do trabalho para dedicar-se integralmente ao cuidado dos filhos, uma vez que a gravidade dos sintomas do TEA e a necessidade de suporte constante tornam o cuidado uma tarefa extenuante e multifacetada.

Além disso, a literatura destaca que as demandas físicas e emocionais associadas ao cuidado de crianças com TEA resultam em mudanças profundas nos papéis sociais e profissionais dessas mulheres, reforçando a necessidade de políticas públicas e suporte institucional para mitigar os impactos negativos sobre a saúde mental e a qualidade de vida das cuidadoras. A citação abaixo destaca a articulação entre os achados quantitativos e qualitativos, e referenciando o artigo de Vilanova et al. (2022)

A análise quantitativa apontou, ainda, que, apesar da presença física, os pais não são participativos no cuidado com os filhos diagnosticados com TEA, o que contribui para sobrecarga materna, devido ao ato solitário de cuidar. Apesar da análise da variável estado civil ter indicado predominância de participantes casadas, foi relatado que muitos pais não aceitam o diagnóstico dos filhos, trazendo tensões familiares que repercutem na vida conjugal. Nesse contexto, os resultados qualitativos confirmaram os resultados quantitativos, visto que os depoimentos das participantes traduziram o sentimento de abandono e solidão, pela restrita participação paterna na divisão de tarefas (Vilanova et al., 2022, p. 2).

Segundo Zanatta e Pereira (2014), o ônus do cuidado recai majoritariamente sobre as mulheres, perpetuando desigualdades de gênero e impactando negativamente sua trajetória educacional e laboral. Dessa forma, os dados analisados reforçam a importância de políticas públicas que reconheçam e apoiem o papel das mães cuidadoras, especialmente no contexto do autismo infantil.

6.3. Análise geográfica

6.3.1. Famílias das crianças inicialmente identificadas com Altas Habilidades ou Superdotação

A análise geográfica da amostra revela uma expressiva concentração de participantes no estado do Rio de Janeiro, embora também estejam representados indivíduos de outros estados brasileiros. Essa distribuição territorial amplia a compreensão sobre as diferentes realidades vivenciadas por esse público em variados contextos educacionais e sociais, permitindo avaliar de que modo fatores regionais influenciam o acesso a recursos especializados e a políticas educacionais voltadas à Dupla Excepcionalidade (DE).

No âmbito do estado do Rio de Janeiro, destaca-se a predominância de participantes do município de Niterói, seguido por São Gonçalo, Rio de Janeiro (capital), Nova Friburgo, Resende, Maricá e Itaboraí. Além disso, a amostra inclui responsáveis provenientes de Campinas, em São Paulo, e de Barroso, em Minas Gerais. Ainda que a representatividade de outros estados seja menor, essa abrangência contribui para uma visão mais ampla do perfil dessas famílias, superando os limites de uma única unidade federativa (Quadro 18).

Quadro 18: Análise Geográfica (AHSD)

MUNICÍPIO/ESTADO	NÚMERO DE PARTICIPANTES
Barroso/MG	1
Campinas/SP	2
Itaboraí/RJ	1
Maricá/RJ	1
Niterói/RJ	16
Nova Friburgo/RJ	3
Resende/RJ	2
Rio de Janeiro/RJ	3
São Gonçalo/RJ	4
TOTAL	33

A análise geográfica das famílias de crianças inicialmente identificadas com AHSD no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, pesquisa de Souto e Delou (2022) identificou que a maioria dos estudantes com AHSD estava concentrada nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói, embora também houvesse participantes em outras regiões, como Região dos Lagos, Serrana e Baixada Fluminense.

As autoras atribuem essa concentração ao acesso diferenciado a avaliações especializadas, à presença de profissionais qualificados e ao tamanho populacional

dos municípios, destacando que o acesso restrito a serviços especializados permanece como um desafio persistente, influenciando diretamente o número de identificações e o atendimento a esse público.

6.3.2. Famílias das crianças inicialmente identificada com Autismo

A análise geográfica (Quadro 19) das famílias das crianças inicialmente identificadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na amostra é composta por 42 famílias.

Quadro 19: Análise Geográfica (TEA)

LOCAL DE RESIDÊNCIA	QUANTIDADE
Maricá	27
Niterói	1
Rio Bonito	14
Não informado	1
TOTAL	43

A análise indica uma concentração significativa das famílias participantes nos municípios de Maricá e Rio Bonito, ambos localizados no estado do Rio de Janeiro. A concentração dos participantes em Maricá e Rio Bonito, não é aleatória: ela reflete a atuação de grupos de apoio ativos nessas cidades.

Em Maricá, o Grupo de Apoio a Mães de Autista de Maricá (GAMAM) e em Rio Bonito, o Grupo de Apoio a Indivíduos com Autismo de Rio Bonito (GAIARB) que promovem encontros regulares, atividades de acolhimento, orientação sobre direitos e formação de redes de suporte, fundamentais para o enfrentamento do luto pós-diagnóstico e para o fortalecimento das famílias.

Essas redes de apoio locais demonstram claramente como o suporte comunitário pode impulsionar o engajamento das famílias e intensificar a busca por melhores condições de atendimento e inclusão para as crianças com TEA.

Em síntese, a atuação dos grupos de apoio em Maricá e Rio Bonito é um fator que fortalece as famílias e contribui para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e responsivas às suas necessidades. Este cenário ressalta a importância vital das iniciativas locais e comunitárias no enfrentamento dos complexos desafios impostos pelo Transtorno do Espectro Autista.

No grupo AHSD, observa-se uma concentração significativa em Niterói, mas também a presença de crianças provenientes de outros municípios, o que indica maior mobilidade e acesso a serviços especializados mesmo fora do núcleo urbano principal. Por outro lado, no grupo de crianças autistas, a participação está majoritariamente restrita à região de residência, evidenciando barreiras mais severas ao deslocamento.

Minatel e Matsukura (2014) identificaram que as famílias de crianças autistas organizam suas rotinas em função do filho, tanto no âmbito doméstico quanto no social, independentemente da fase de desenvolvimento, da presença de outros filhos ou das atividades profissionais e acadêmicas dos responsáveis.

Além disso, conforme Machado (2018), citado por Martins et al. (2022), essas famílias tendem a se afastar do convívio social, centram-se na criança, vivenciam falta de apoio e dificuldades no acesso aos tratamentos, e apresentam preocupações e perspectivas distintas de outras famílias, reconhecendo-se como unidas, alternando entre momentos de tristeza e alegria, e investindo intensamente na criança.

Pérez e Freitas (2014) destacam que há uma compreensão insuficiente das realidades educacionais regionais, o que faz com que a oferta de serviços especializados se concentre em grandes centros urbanos e capitais, deixando regiões periféricas e menos favorecidas sem atendimento adequado. Essa centralização agrava as desigualdades de acesso, já que a maioria das famílias brasileiras não possui recursos financeiros para arcar com deslocamentos.

Assim, a análise dos dois grupos revela que, enquanto as famílias de crianças com AHSD conseguem, em certa medida, superar barreiras geográficas para acessar atendimento (Virgolim, 2014), às famílias de crianças com TEA enfrentam obstáculos mais complexos, vinculados à manutenção da rotina (Schmidt et al., 2016), à dependência de terapias contínuas (Bosa, 2006), à vulnerabilidade socioeconômica (Paula et al., 2020) e à necessidade de suporte comunitário (Camargo & Bosa, 2009) — fatores amplamente discutidos na literatura sobre os desafios vivenciados por essas famílias no contexto brasileiro.

6.4. Diagnósticos das crianças e/ou adolescentes

6.4.1. Informações dadas pelos familiares AHSD

A pesquisa revelou informações mais detalhadas sobre os diagnósticos das crianças participantes, destacando a predominância de superdotação e sua associação com outras condições neurodivergentes, caracterizando a dupla excepcionalidade (DE).

Os dados do Quadro 20 revelam como os diagnósticos se distribuem entre os tutelados dos 33 participantes, indicando a ocorrência de superdotação isolada, também os casos em que ela aparece associada a uma ou mais condições neurodivergentes.

Quadro 20: Distribuição dos Diagnósticos nos tutelados do Grupo AHSD

DIAGNÓSTICO	NÚMERO DE PARTICIPANTES
Superdotação	22
Dupla Excepcionalidade (Superdotação e TEA)	6
Dupla Excepcionalidade (outros)	4
Só sabe dizer que é muito inteligente	1
TOTAL	33

Embora o diagnóstico de superdotação isolada ainda predomine entre os participantes, a pesquisa identificou casos de DE, especialmente na associação entre AHSD e TEA, além de outras combinações com transtornos do neurodesenvolvimento. Esse cenário evidencia a diversidade dos perfis presentes no grupo estudado e ressalta a importância de reconhecer as especificidades da DE.

Os dados indicam que, mesmo entre famílias que já haviam obtido o diagnóstico de superdotação, surgem relatos de características que sinalizam a possível coexistência de outras condições. Essa situação reflete os desafios descritos por Vilarinho-Rezende, Fleith e Alencar (2016), que, a partir de um estudo de caso, evidenciam como o processo de identificação da DE é marcado por incertezas, interpretações divergentes e ausência de consenso entre os profissionais.

As autoras destacam que “há com frequência confusões ao se diagnosticar superdotados com Síndrome de Asperger, uma vez que algumas características de superdotação se assemelham às da síndrome” (Vilarinho-Rezende; Fleith; Alencar,

2016, p. 67). Essa sobreposição de traços gera dúvidas tanto na prática clínica quanto no ambiente educacional, dificultando a compreensão sobre a origem de determinados comportamentos — relacionados às altas habilidades, a um transtorno do neurodesenvolvimento ou à interação entre ambos.

Essa indefinição impacta diretamente a vida escolar, as relações familiares e o acesso a intervenções adequadas, uma vez que a ausência de um diagnóstico claro compromete tanto o planejamento de estratégias pedagógicas quanto o suporte terapêutico.

6.4.2. Informações dadas pelos familiares TEA

Com base nos dados da pesquisa, realizou-se a análise do perfil dos diagnósticos das crianças cujos responsáveis integram o grupo TEA (quadro 20), revelando características importantes sobre este perfil específico.

Quadro 21: Distribuição dos diagnósticos no grupo TEA

CATEGORIA DIAGNÓSTICA	NÚMERO DE CASOS
Autismo Isolado	35
Autismo + TDAH	4
Autismo + Síndrome de Down (T21)	1
Autismo + Deficiência Intelectual	1
Em investigação para AHSD	1
Em investigação para TDAH	1
TOTAL	43

O grupo de responsáveis por crianças com TEA revela uma predominância absoluta de diagnósticos relacionados ao próprio transtorno, correspondendo a 100% dos participantes, o que confirma a especificidade da amostra. No entanto, os dados evidenciam uma significativa complexidade diagnóstica: 16,7% dos casos apresentam comorbidades ou estão em processo de investigação para outras condições, como TDAH, deficiência intelectual e, em apenas um caso, AHSD. Esses dados demonstram que o grupo não é homogêneo, refletindo uma diversidade expressiva de necessidades. O fato de apenas um participante estar em investigação para AHSD aponta para um cenário de subidentificação, que destaca como o diagnóstico de TEA pode mascarar as características associadas às altas habilidades.

Essa barreira é potencializada por desafios na comunicação, como ilustra o

relato de uma responsável (P40): “*Minha filha não é verbal*”, evidenciando que limitações na linguagem podem dificultar o reconhecimento das potencialidades. Crianças não verbais ou com comunicação restrita frequentemente têm seus talentos subestimados, o que reforça a importância de instrumentos e abordagens avaliativas sensíveis e adaptadas.

Visca (1987) defende avaliações centradas na aprendizagem, que considerem tanto as potencialidades quanto as dificuldades, em um processo que envolva famílias, educadores e profissionais da saúde mental, favorecendo o desenvolvimento integral dos alunos com DE.

Da mesma forma, Rocksley-Pavia (2015) enfatiza que o contexto sociocultural influencia diretamente o processo de identificação, uma vez que tanto as concepções de altas habilidades quanto de deficiência são construções socialmente determinadas. A autora também alerta que a falta de clareza conceitual compromete a pesquisa e a prática educacional, levando à subidentificação ou a intervenções inadequadas. Defende, portanto, a adoção de concepções amplas e multifacetadas de inteligência e superdotação — como as propostas por Gagné (2004) e Gardner (2001) —, que permitam reconhecer a coexistência de altas habilidades com qualquer tipo de deficiência, inclusive intelectual.

Nesse mesmo sentido, Baum, Shader e Owen (2017) ressaltam que a dupla excepcionalidade é um fenômeno complexo, no qual a combinação entre potencial elevado e deficiência ou transtorno gera perfis únicos, exigindo práticas avaliativas individualizadas. Como afirmam as autoras:

O cruzamento entre capacidades avançadas e deficiências — ambas são excepcionalidades — daí o termo dupla excepcionalidade, o qual cria uma relação paradoxal, muitas vezes conflituosa e, às vezes, simbiótica dentro do indivíduo. Entender o que ocorre quando se trabalha com a combinação dessas excepcionalidades é crucial para encontrar as necessidades emocionais e educacionais de estudantes duplamente excepcionais (Baum; Shader; Owen, 2017, p. 17).

Os achados desta pesquisa reforçam que a presença de múltiplas comorbidades no grupo TEA evidencia a necessidade de avaliações interdisciplinares, sensíveis e contextualizadas, capazes de oferecer diagnósticos mais precisos e acompanhamento integral. A baixa incidência de casos em investigação para AHSD sugere uma lacuna no reconhecimento das potencialidades em crianças autistas.

De maneira convergente ao grupo AHSD, os dados do grupo TEA reafirmam que a DE exige avaliações que considerem a complexidade dos perfis e as influências socioculturais. O diagnóstico assertivo é fundamental não apenas para reconhecer o potencial dessas crianças, mas também para garantir suporte adequado, com intervenções personalizadas, adaptações curriculares e planejamento educacional que favoreçam seu desenvolvimento pleno.

Os dados seguintes foram coletados por meio de um segundo questionário (Apêndice 2), aplicado com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre as percepções familiares em relação à Dupla Excepcionalidade. Para os responsáveis do grupo AHSD (n=33), o instrumento foi aplicado ao final da oficina *“O que é Dupla Excepcionalidade? A Importância da sua Aceitação pelos Pais”*, realizada pelo grupo DIECI UFF. Já no grupo TEA, o levantamento ocorreu durante uma roda de conversa online, em horário escolhido previamente pelos participantes. Apesar dos esforços, a adesão foi baixa, com participação de apenas cinco responsáveis, dos 43 que haviam respondido ao primeiro questionário ao longo da caminhada.

6.5. Idade Atual dos Filhos/Tutelados dos Participantes da Pesquisa

A análise da faixa etária dos participantes, apresentada no quadro 22, revela que ambos os grupos se concentram majoritariamente na idade escolar. No perfil analisado no grupo AHSD, as idades variam entre 5 e 18 anos, enquanto no grupo TEA predominam crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos. Essa coincidência no período do ensino fundamental reforça o que aponta os autores (Renzulli; Reis, 2014), que reconhece essa etapa como um momento em que tanto as características associadas à superdotação quanto ao autismo tendem a se tornar mais perceptíveis e demandam maior atenção no contexto escolar.

Quadro 22: Comparativo - Idade Atual dos Filhos dos Participantes

FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE – AHSD (N=33)	QUANTIDADE – TEA (N=5)
5 a 8 anos	8	2
9 a 12 anos	14	1
13 a 15 anos	6	0
16 a 18 anos	5	1

19 anos ou mais	0	1
TOTAL	33	5

O fato de os diagnósticos e o acompanhamento ocorrerem principalmente durante a trajetória escolar, como apontam os dados do quadro 22, destaca a centralidade da escola. Este é o palco no qual as demandas sociais e educacionais se intensificam, tornando crucial o suporte especializado para o pleno desenvolvimento das potencialidades (Assouline et al., 2020; Baum et al., 2017).

Fundamentada por teorias como as de Renzulli e Reis (2014) e Gardner (2001), a análise aponta para o preparo de educadores, e um ambiente escolar que reconheça e atenda às necessidades contínuas desses alunos.

6.6. A Idade do Diagnóstico AHSD E TEA

O Quadro 23 apresenta os dados referentes ao grupo de responsáveis por crianças com AHSD. Ele detalha a idade atual das crianças e a idade em que foi realizado o diagnóstico formal de superdotação ou de Dupla Excepcionalidade (quando identificado o TEA associado). Esses dados possibilitam uma análise crítica sobre o intervalo entre o surgimento de indícios e o reconhecimento oficial, evidenciando tanto os avanços quanto os obstáculos enfrentados pelas famílias no processo de identificação e encaminhamento.

Quadro 23: Idade Atual e Idade do Diagnóstico (Grupo AHSD) - O traço (—) indica que a condição não foi diagnosticada ou não se aplica.

IDADE ATUAL	IDADE DIAGNÓSTICO SUPERDOTAÇÃO	IDADE DIAGNÓSTICO TEA	IDADE DIAGNÓSTICO DUPLA EXCEPCIONALIDADE
7 anos	não soube responder	—	—
8 anos	5/6 anos	—	—
	5 anos	—	—
	5 anos	—	—
	5 anos	—	—
	5/6 anos	Investigação	Investigação
9 anos	5 anos	—	—
	5 anos	—	—
	6 anos	—	—
	7 anos	7 anos	—
10 anos	7 anos	Investigação aos 10 anos	Investigação aos 10 anos
	7 anos	—	7 anos
	7 anos	—	8 anos

	7 anos	10 anos (Investigação)	10 anos (investigação)
11 anos	9 anos	—	—
	6 anos	—	12 anos
12 anos	respondeu superdotação	—	—
	respondeu superdotação	—	—
	8 anos	—	—
	6/7 anos	—	—
13 anos	12 anos	—	—
	5 anos	—	—
14 anos	7 anos	—	—
15 anos	6 anos	—	—
	—	7 anos	9 anos
16 anos	8 anos	10 anos	10 anos
	8 anos	10 anos	10 anos
17 anos	8 anos	16 anos	16 anos
18 anos	9 anos	—	—
12 e 9 anos	10 e 8 anos	—	—
15 e 7 anos	12 anos	4 anos	7 anos
Não informado	Não informado	3 anos	Não informado
	—	—	—

No grupo de responsáveis por crianças inicialmente diagnosticadas com AHSD, observa-se que o reconhecimento dessas habilidades costuma ocorrer precocemente, geralmente entre 5 e 7 anos, período em que as famílias começam a perceber sinais de desenvolvimento acelerado em áreas específicas. Apesar de muitos indícios já serem notados desde a primeira infância, a confirmação formal geralmente ocorre com o ingresso na escola. Um relato típico desse processo ilustra bem essa dinâmica: “Meu filho foi diagnosticado com superdotação aos 6 anos” (P25).

Quando há presença da DE, o TEA tende a ser identificado mais tarde, normalmente entre 7 e 10 anos, após avaliações complementares motivadas por dificuldades comportamentais, sociais ou acadêmicas que não se explicam apenas pelas altas habilidades. Um responsável descreve essa trajetória: “Meu filho foi diagnosticado com dupla excepcionalidade aos 10 anos, quando finalmente conseguimos integrar as informações sobre sua superdotação e TEA” (P18). Assim, o diagnóstico da DE nesse grupo é um processo gradual, que exige a articulação de múltiplas informações e avaliações.

O Quadro 24 apresenta os dados do grupo TEA, evidenciando um percurso diagnóstico distinto, em que o TEA costuma ser identificado precocemente, enquanto as Altas Habilidades — quando presentes — são reconhecidas apenas posteriormente, após um processo contínuo de observação e reavaliação.

Quadro 24: Idade Atual e Idade do Diagnóstico (Grupo TEA). Nota: O traço (—) indica que a condição não foi diagnosticada ou não se aplica

IDADE ATUAL	DIAGNÓSTICO SUPERDOTAÇÃO (IDADE)	DIAGNÓSTICO TEA (IDADE)	DIAGNÓSTICO DUPLA EXCEPCIONALIDADE (IDADE)
10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
5 anos	-	2 anos	-
16 anos	-	5 anos	-
28 anos	-	8 anos	-
8 anos	-	6 anos	-

Por sua vez, no grupo de responsáveis por crianças com diagnóstico inicial de TEA, o percurso segue uma lógica distinta. O diagnóstico do transtorno costuma ocorrer precocemente, muitas vezes antes dos 6 anos, em consonância com os protocolos de rastreio precoce para o espectro autista. No entanto, a percepção de altas habilidades nesse contexto tende a ser mais complexa, frequentemente ofuscada pelas características próprias do TEA, como dificuldades de comunicação, comportamentos restritivos e desafios na interação social. Isso é evidenciado no relato de uma participante: “É muito difícil perceber se tem superdotação, porque a gente foca muito nas questões do autismo. Meu filho não fala, então nem sabemos direito” (P5).

Quando a DE é reconhecida nesse grupo, geralmente ocorre de forma tardia, muitas vezes após longos processos de adaptação escolar e intervenções. Essa situação é descrita por uma mãe ao relatar: “Só depois de muitos anos, quando ele já estava bem adaptado na escola, é que começaram a dizer que ele tinha inteligência, apesar do autismo” (P3).

O fenômeno do mascaramento recíproco — no qual as dificuldades associadas ao TEA podem ocultar as altas habilidades, assim como as potencialidades podem, por vezes, disfarçar características do espectro — é amplamente discutido na literatura como um dos principais entraves para o reconhecimento adequado da Dupla Excepcionalidade (Assouline et al., 2010; Baum; Schader; Owen, 2017; Nakano, 2021).

Com base nos dados analisados, observa-se que os percursos diagnósticos da Dupla Excepcionalidade (DE) são significativamente influenciados pela condição inicialmente identificada, seja AHSD ou TEA. Esse ponto de partida impacta diretamente tanto o tempo quanto às oportunidades de reconhecimento das

potencialidades e dos desafios que coexistem. Quando as altas habilidades são percebidas primeiro, a identificação dos traços do TEA tende a ocorrer mais tardiamente, geralmente em decorrência de dificuldades comportamentais, sociais ou acadêmicas que surgem ao longo do desenvolvimento. De maneira oposta, quando o TEA é diagnosticado inicialmente, o reconhecimento de altas habilidades costuma ser mais complexo e demorado, muitas vezes ofuscado pelas próprias características do transtorno. Esse cenário reflete o fenômeno do mascaramento recíproco, amplamente discutido por autores como Assouline et al. (2010), Baum, Schader e Owen (2017) e Nakano (2021), que destacam como as manifestações de uma condição podem ocultar ou minimizar os sinais da outra, dificultando uma compreensão plena da DE.

6.7. Descobrindo a Dupla Excepcionalidade: Pais AHSD e TEA

Foi perguntado aos responsáveis quem sugeriu a possibilidade de Superdotação e/ou TEA em seus tutelados. No caso das crianças inicialmente identificadas com AHSD os educadores aparecem como os principais responsáveis por essa indicação, totalizando 27,3% dos casos (Quadro 25).

Quadro 25: Distribuição das sugestões para avaliação (AHSD)

QUEM SUGERIU A AVALIAÇÃO	QUANTIDADE
Professores	9
Pais/Mães	8
Médicos	2
Terapeutas	4
Outros	6
Não soube informar	4
TOTAL	33

Os resultados apresentados no quadro 25 evidenciam que tanto os professores quanto as famílias desempenham um papel central no processo de sugestão para avaliação de crianças com características de superdotação e Dupla Excepcionalidade. A citação dos educadores como os principais identificadores reforça o papel da escola como espaço estratégico para a observação de comportamentos, talentos e necessidades diferenciadas. Logo em seguida, surgem os pais e mães, com 24,2%, demonstrando a relevância do olhar atento da família

na identificação das especificidades dos filhos. Além de educadores e familiares, os profissionais de saúde, como médicos e terapeutas, também desempenham um papel relevante nas indicações para avaliação, atuando de forma complementar na rede de apoio e no processo de identificação das necessidades dessas crianças.

Já os dados coletados sobre as crianças com TEA, revelam um cenário distinto (Quadro 26).

Quadro 26: Quem Sugeriu a Avaliação - Grupo TEA

QUEM SUGERIU A AVALIAÇÃO	QUANTIDADE
Professores	1
Pais/Mães	3
Terapeutas	1
TOTAL	5

A maior parte das sugestões de avaliação parte das próprias famílias, especialmente das mães, que percebem desde cedo sinais como atraso na fala, dificuldades na comunicação, no desenvolvimento social ou comportamentos atípicos. Em seguida, aparecem os profissionais da saúde, que são procurados para avaliar essas demandas. A escola desempenha um papel menor nesse processo, funcionando mais como espaço de confirmação do que como agente inicial de encaminhamento. Grupos de apoio, como GAMAM e GAIARB, também têm um papel relevante, orientando e acolhendo essas famílias.

Sob a perspectiva do Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano, proposto por Bronfenbrenner (1996), a identificação da DE não ocorre de forma isolada, mas resulta da interação entre os diferentes contextos que compõem a vida da criança — família, escola e serviços de saúde. É no mesossistema, espaço onde esses contextos se interconectam, que os processos de desenvolvimento se fortalecem, favorecendo a construção de trajetórias diagnósticas mais sensíveis, precisas e alinhadas às necessidades singulares de cada indivíduo.

Conforme destacam Rosa e Tudge (2013), “[...] o desenvolvimento ocorre através de processos proximais — interações complexas e recíprocas — dentro de contextos ambientais inter-relacionados” (p. 253). Essa compreensão se aplica diretamente ao processo de identificação da DE, que exige articulação contínua e colaborativa entre os diferentes agentes que acompanham o desenvolvimento da criança.

No grupo de crianças inicialmente identificadas com AHSD, observa-se uma dinâmica em que o ambiente escolar assume papel central no processo de reconhecimento. Na maioria dos casos, são os professores que primeiro percebem indícios de desempenho acima da média, tanto no aspecto cognitivo quanto no socioemocional, e sinalizam a necessidade de uma avaliação especializada. Esse protagonismo da escola se justifica, uma vez que muitos dos traços associados às altas habilidades se tornam mais evidentes nas interações acadêmicas e nos desafios propostos no ambiente escolar (Baum; Schader; Owen, 2017; Nakano, 2021).

Quando, ao longo do desenvolvimento, surgem dificuldades que não se explicam apenas pela superdotação — como desafios comportamentais, socioemocionais ou de interação —, o TEA tende a ser identificado em um segundo momento, por meio de avaliações complementares realizadas em resposta às demandas observadas. Dessa forma, a configuração da Dupla Excepcionalidade emerge de maneira gradual, construída a partir da integração de informações provenientes da escola, da família e dos profissionais da saúde.

Por outro lado, no grupo de crianças cujo diagnóstico inicial é o TEA, o percurso segue uma lógica distinta. Nesse contexto, a família — e, de forma particularmente expressiva, as mães — desempenha um papel central na condução do processo de busca por avaliação e intervenções. Na maioria dos casos, são elas que percebem, ainda nos primeiros anos, sinais de desenvolvimento atípico, dificuldades na comunicação, na interação social ou no comportamento, e iniciam a trajetória em busca de respostas e de apoio especializado.

Esse movimento evidencia um cenário em que a escola, muitas vezes, assume um papel secundário, atuando mais como validadora das percepções familiares do que como agente protagonista no processo de identificação. Além disso, esse percurso revela uma sobrecarga frequentemente atribuída às mães, que, em muitos casos, precisam reorganizar suas vidas pessoais e profissionais para se dedicar integralmente ao cuidado e acompanhamento dos filhos (Assouline et al., 2020; Baum; Schader; Owen, 2017).

Esses dados reforçam a importância de um trabalho colaborativo, fundamentado na escuta sensível, no diálogo permanente e na corresponsabilidade entre família, escola e profissionais da saúde. A identificação das singularidades e

das potencialidades das crianças com DE exige mais do que procedimentos técnicos; demanda um olhar atento, empático e capaz de compreender que cada trajetória é única, e que os sinais — muitas vezes sutis — precisam ser acolhidos, interpretados e ressignificados de forma coletiva.

Longe de ser um evento isolado, o reconhecimento da DE se configura como um verdadeiro mosaico, cujas peças são construídas a partir das contribuições de todos os contextos nos quais a criança está inserida. Nesse processo, o fortalecimento de práticas colaborativas torna-se essencial para assegurar um desenvolvimento pleno, que reconheça e respeite, de maneira integrada, tanto os desafios quanto os talentos que coexistem em cada sujeito.

6.8. Superdotação, Autismo ou Dupla Excepcionalidade: identificação da(s) condição(ções) da(s) criança(s) e adolescente(s)

Em um primeiro momento buscou-se entender quando as crianças e adolescentes foram identificadas com uma ou duas condições e qual condição, se fosse o caso, foi identificada primeiro. Os dados coletados evidenciam que a maioria dos participantes do grupo de responsáveis do Curso de Verão para Superdotados (60,6%) relatou o diagnóstico do seu (sua) tutelado (a) exclusivo de Superdotação, enquanto os responsáveis do grupo TEA relatam que a maioria dos participantes (97,6%) teve o diagnóstico exclusivo de autismo para seus tutelados (Gráfico 2).

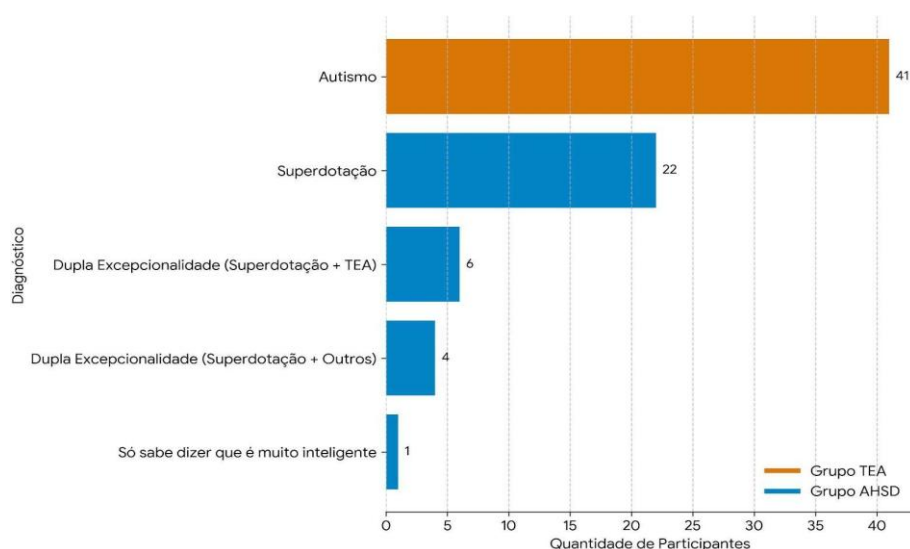


Gráfico 2: Análise Comparativa de Diagnóstico

A comparação entre os grupos de AHSD e TEA revela um contraste na ocorrência de DE. Enquanto no grupo AHSD a DE é relevante (39,4% dos casos), no grupo TEA ela é rara (2,4%), predominando o diagnóstico único de autismo.

A subidentificação de AHSD em indivíduos com TEA configura um fenômeno crítico, conforme evidenciado por Pfeiffer (2018) no *Handbook of Giftedness and Talent Development*. O autor demonstra que os critérios diagnósticos do TEA frequentemente ofuscam as manifestações de superdotação, particularmente nos domínios intelectual e acadêmico - um viés denominado *effect masking* na literatura internacional. Essa disparidade diagnóstica reflete lacunas estruturais nos sistemas de avaliação, que operam mediante paradigmas excludentes em vez de abordagens multidimensionais, como preconizado no modelo *Dual Differentiation* de Reis e McCoach (2000). No contexto brasileiro, a fragmentação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em modalidades distintas para AHSD e TEA (Brasil, 2020) agrava essa limitação, desconsiderando a necessidade de intervenções concomitantes de suplementação e complementação pedagógica - essenciais para o desenvolvimento pleno da DE, conforme os estudos longitudinais de Assouline et al. (2022) com populações DE (*twice-exceptional*).

A literatura aponta que o diagnóstico tardio e a invisibilidade dos talentos em meio às características do autismo agravam o problema. Como observado por Silva et al. (2023), "há uma tendência de uma das condições cercear a outra" – seja o alto potencial mascarando dificuldades, seja o transtorno ofuscando as habilidades. Esse fenômeno é particularmente crítico no TEA, onde o foco clínico tende a

priorizar as demandas do espectro, negligenciando a identificação de altas habilidades associadas.

6.8.1. Estrutura familiar das crianças e adolescentes

Em relação à composição familiar, observou-se que a maioria dos participantes dos dois grupos AHSD e TEA – relatou que seus filhos residem com ambos os genitores. No entanto, identificaram-se diferenças significativas entre os grupos.

No grupo AHSD, 84,8% dos responsáveis afirmaram que seus filhos residem com o genitor ou genitora, enquanto 15,2% declararam que não. Por outro lado, no grupo TEA, esse percentual foi menor: 68,3% dos participantes relataram que seus filhos residem com o genitor ou genitora, e 31,7% indicaram que não.

Esses dados refletem uma maior incidência de arranjos familiares monoparentais no grupo TEA quando comparado ao grupo AHSD. Tal aspecto pode influenciar diretamente no acesso aos serviços, na organização das rotinas familiares e na sobrecarga dos cuidadores, sobretudo no contexto de demandas educacionais e terapêuticas.

O Gráfico 3 ilustra de forma comparativa os dados referentes à composição familiar dos participantes dos dois grupos, evidenciando o percentual de crianças que residem ou não com pelo menos um dos genitores.

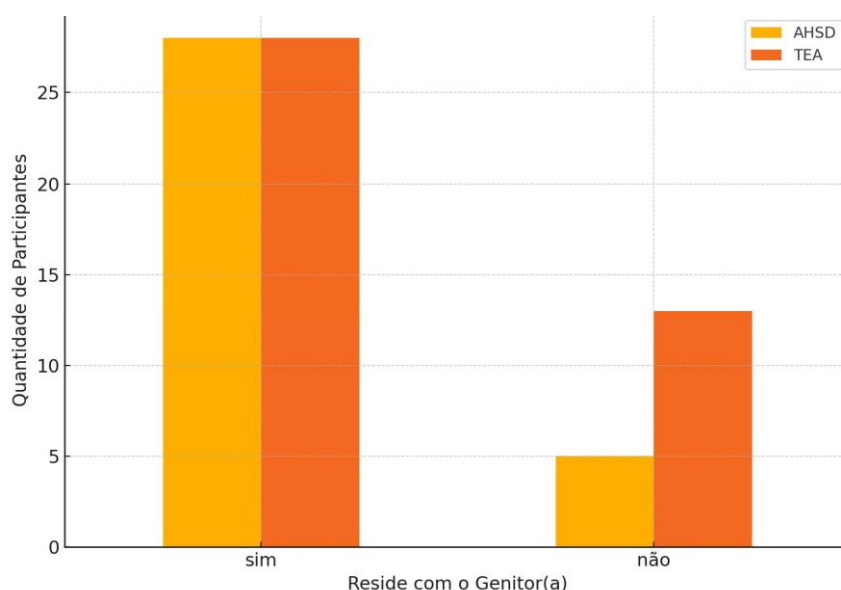


Gráfico 3: Composição familiar dos participantes dos grupos AHSD e TEA quanto à

Saad e colaboradores (2024) destacam que mães de crianças com TEA relatam rotinas intensas, falta de suporte público, necessidade de assistência multidisciplinar e resiliência diante das adversidades, fatores que influenciam diretamente a dinâmica e a configuração familiar. Sprovieri e Assumpção Jr. (2001) também apontam que famílias de crianças autistas apresentam maior dificuldade em proporcionar saúde emocional aos membros do grupo, com comunicação menos clara, papéis familiares rígidos e maior tensão relacional.

Por outro lado, os dados do grupo AHSD indicam uma predominância de arranjos familiares mais tradicionais, com maior presença de ambos os genitores e menos relatos de desestruturação familiar, possivelmente devido à menor sobrecarga de cuidados intensivos e terapias frequentes.

Essas evidências reforçam que a presença do autismo na família tende a demandar adaptações mais profundas, afetando a configuração familiar e o convívio cotidiano, enquanto no grupo AHSD essas mudanças são menos marcantes, favorecendo a manutenção de arranjos familiares convencionais.

No que se refere ao número de filhos diagnosticados com AHSD ou Dupla Excepcionalidade, a maioria dos participantes (90,9%) declarou ter um único filho com algum diagnóstico. Apenas 6 famílias relataram possuir dois filhos diagnosticados e um dos participantes informou ter filhos com diagnósticos distintos (um com AHSD e outro com outra condição associada à dupla excepcionalidade). O Gráfico 4 apresenta essa distribuição detalhada entre os participantes do grupo de AHSD.

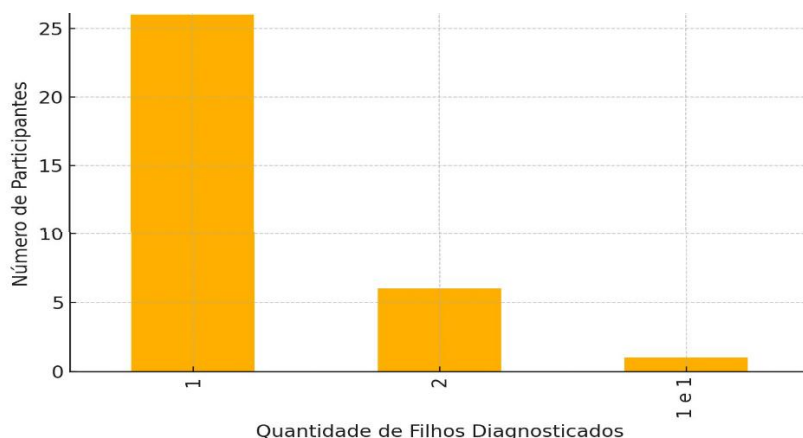


Gráfico 4: Número de filhos com diagnóstico de AHSD ou Dupla Excepcionalidade (Grupo

Quanto ao número de filhos diagnosticados com TEA ou Dupla Excepcionalidade, a análise mostra uma predominância: a maioria das famílias possui apenas um filho com diagnóstico. Dos participantes, 37 famílias relataram ter um filho diagnosticado, enquanto 4 famílias informaram possuir dois filhos com diagnóstico. Apenas um participante não respondeu a essa questão (Gráfico 5).

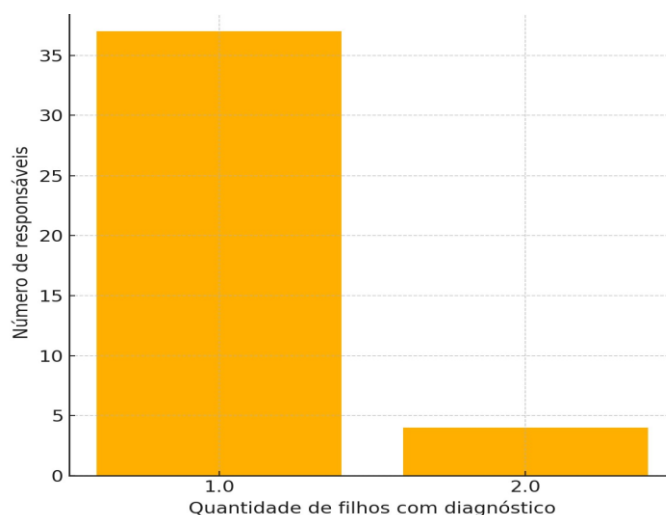


Gráfico 5: Número de filhos com diagnóstico de TEA ou Dupla Excepcionalidade (Grupo TEA)

Essa distribuição evidencia que, para a maior parte das famílias, a experiência com o diagnóstico de TEA ou Dupla Excepcionalidade está centrada em um único filho, o que pode impactar diretamente as demandas de suporte, às expectativas familiares e o engajamento com políticas públicas e práticas educacionais.

6.8.2. A Dupla Excepcionalidade na visão dos responsáveis

As percepções dos responsáveis sobre a DE revelam diferenças entre os grupos de participantes. No grupo de responsáveis por crianças com AHSD, a maioria dos participantes (93,75%) demonstrou compreender o termo, sendo que 68,75% associaram diretamente à superdotação; 18,75% descreveram a DE como a coexistência entre superdotação e TEA; e 12,5% apresentaram uma definição ampliada, relacionando a superdotação à presença de outros transtornos do

neurodesenvolvimento, como o TDAH. Apenas 3,1% dos respondentes apresentaram respostas vagas ou demonstraram desconhecimento do conceito (Gráfico 6).

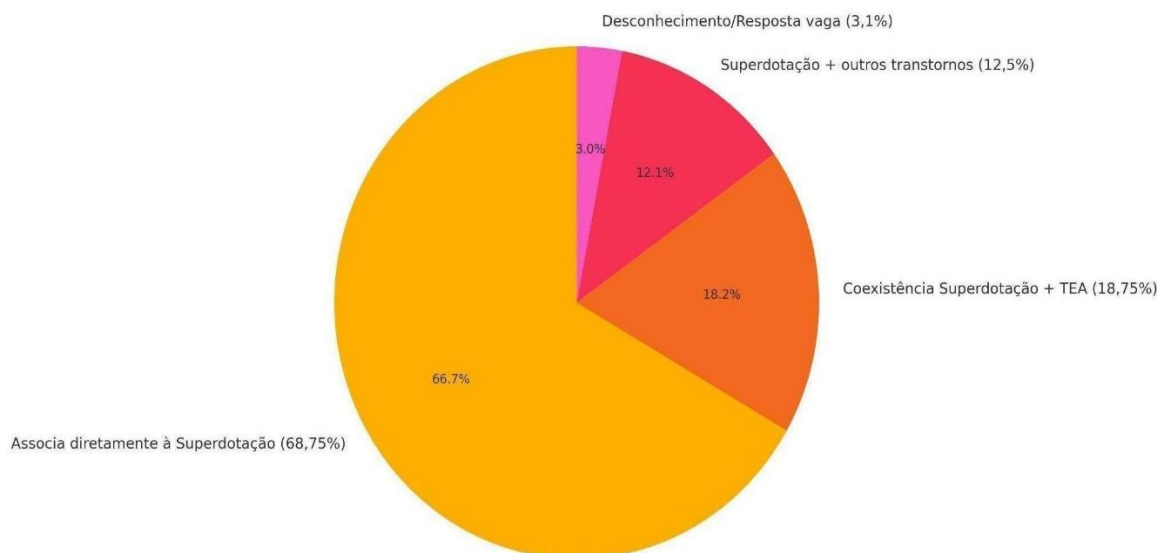


Gráfico 6: Conhecimento prévio sobre Dupla Excepcionalidade (Grupo AHSD)

Esse cenário indica que, embora haja um conhecimento considerável entre as famílias desse grupo, a compreensão do conceito ainda varia quanto à profundidade e à precisão. Como apontam Neihart (2008) e Reis, Baum e Burke (2014), mesmo em contextos em que a superdotação é reconhecida, o entendimento sobre a Dupla Excepcionalidade demanda constante formação, dado o caráter complexo e, muitas vezes, invisível desse perfil.

Por outro lado, no grupo de responsáveis por indivíduos diagnosticados com TEA, o desconhecimento sobre a Dupla Excepcionalidade é predominante. A maioria (97,6%) revelou não compreender o conceito, limitando-se a mencionar exclusivamente o termo “autismo” e desconsiderando a possibilidade de coexistência com AHSD. Apenas 2,4% forneceram respostas consideradas vagas ou desconectadas do tema (Gráfico 7).

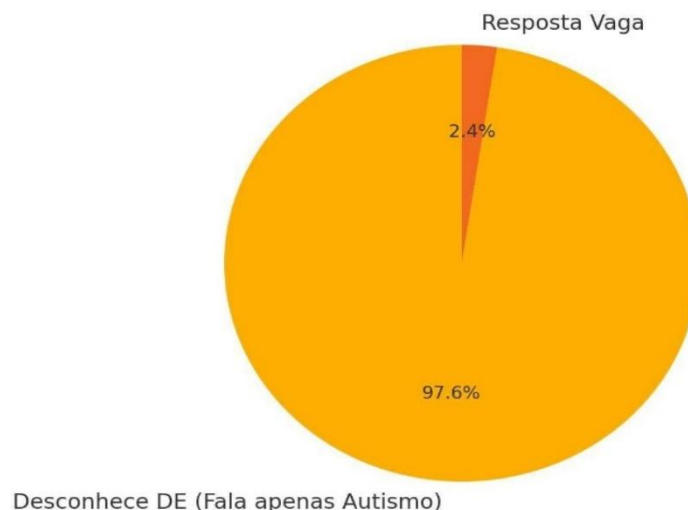


Gráfico 7: Conhecimento prévio sobre Dupla Excepcionalidade (Grupo TEA)

Este dado reflete uma realidade preocupante e, ao mesmo tempo, amplamente reconhecida na literatura, que denuncia a prevalência de uma abordagem centrada no modelo de déficit no contexto do autismo. Tal modelo tende a priorizar a identificação das limitações, relegando ao esquecimento as potencialidades cognitivas, criativas e acadêmicas que, muitas vezes, estão presentes, mas não são percebidas (Foley-Nicpon; Assouline; Colangelo, 2013).

Esse cenário de desconhecimento, particularmente no grupo TEA, está diretamente relacionado ao fenômeno do mascaramento, descrito pelos autores (Baum; Schader; Hébert, 2017; Baum; Owen, 2004). Esse fenômeno ocorre quando as AHSD ocultam as deficiências, quando as deficiências encobrem as AHSD ou, ainda, quando ambas se anulam mutuamente, levando o indivíduo a ser percebido como alguém de desenvolvimento aparentemente mediano. No contexto específico da Dupla Excepcionalidade associada a AHSD e TEA, é comum que dificuldades de comunicação social, rigidez comportamental e padrões restritos sejam interpretados como indicadores de limitação intelectual. Ao mesmo tempo, traços como vocabulário avançado, raciocínio lógico, hiperfoco e pensamento criativo acabam sendo atribuídos exclusivamente às características do autismo, sem o devido reconhecimento das AHSD (Foley-Nicpon et al., 2011; Pfeiffer, 2013).

Quando essa sobreposição de características não é devidamente reconhecida, compromete-se o processo de identificação e encaminhamento para serviços especializados, favorecendo o subdiagnóstico e negligenciando tanto os desafios quanto os talentos desses indivíduos. Como destaca Reis, Baum e Burke

(2014), essa invisibilidade não só limita o desenvolvimento acadêmico e socioemocional, como também impede o acesso a intervenções que integrem estratégias de enriquecimento e suporte. Além disso, priva esses alunos de direitos fundamentais, como o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a elaboração de Planos de Ensino Individualizados (PEI) capazes de atender às suas demandas de forma abrangente.

A DE, entendida como a coexistência de AHSD com uma ou mais condições, como o TEA ou o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), configura-se como um grande desafio tanto para o diagnóstico quanto para o atendimento educacional e terapêutico, uma vez que demanda o reconhecimento simultâneo das potencialidades e das dificuldades (Webb et al., 2016).

6.9 Desvendando a Dupla Excepcionalidade: Percepções Familiares, Desafios e Suporte

6.9.1 Percepções Familiares AHSD

Dos 33 responsáveis participantes, a maioria (81%) declarou manter sua opinião sobre o conceito de DE mesmo após a oficina, conforme apresentado no Gráfico 8.

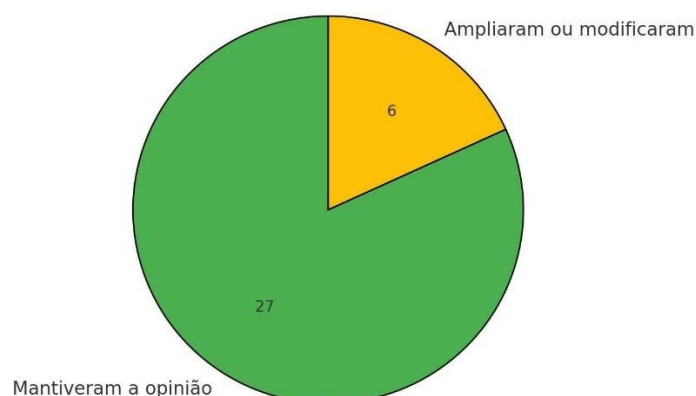


Gráfico 8: Percepção sobre Dupla Excepcionalidade após a Oficina (responsáveis AHSD)

Embora a maioria dos participantes tenha declarado que manteve sua percepção inicial sobre o conceito de DE — percentual que corresponde a 81% dos 33 responsáveis, conforme apresentado no Gráfico 9 —, a análise dos relatos revela que, na prática, houve ampliação, refinamento e enriquecimento desse

entendimento. As famílias passaram a compreender com mais clareza que a DE pressupõe, necessariamente, a coexistência entre AHSD e uma condição neurodivergente, como o TEA ou o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Essa dinâmica de ampliação do conceito, mesmo que não formalmente reconhecida pelos participantes como uma mudança de opinião, reflete um fenômeno já discutido na literatura. Como destacam Baum, Shader e Owen (2017, p. 7), “[...] o cruzamento entre capacidades avançadas e deficiências — ambas são excepcionalidades — cria uma relação paradoxal, muitas vezes conflituosa, e, às vezes, simbiótica dentro do indivíduo” (p. 17), o que exige um olhar mais apurado e sensível tanto dos profissionais quanto das famílias.

Ronksley-Paiva (2015) destaca que a ausência de clareza conceitual acerca da Dupla Excepcionalidade prejudica tanto a prática quanto a pesquisa na área, o que pode levar a subidentificações e erros diagnósticos, especialmente quando não se considera a possibilidade de coexistência entre altas habilidades e transtornos do neurodesenvolvimento. Isso se reflete diretamente nos depoimentos dos participantes, como observa-se nas falas dos participantes das pesquisas: “Não, passei a compreender com mais clareza a DE” (P16) e “Sim, acrescento que hoje entendi que o termo necessariamente associa AHSD a uma outra condição neurodivergente” (P18). Portanto, é fundamental aprimorar o entendimento sobre esse conceito para garantir diagnósticos mais precisos e intervenções adequadas.

6.9.2 Percepções Familiares TEA

Durante a roda de conversa online *“Desafios, Potencialidades e Caminhos para a Inclusão de Pessoas com Dupla Excepcionalidade (AHSD e TEA)”*, mães de crianças com Dupla Excepcionalidade compartilharam experiências e reflexões sobre seus percursos. A atividade configurou-se como um espaço de escuta qualificada, acolhimento e troca de saberes, promovendo uma reflexão sensível sobre os desafios e potencialidades que permeiam o cotidiano dessas famílias, mesmo com a participação de apenas cinco responsáveis.

A análise das respostas revelou que quatro participantes afirmaram não ter modificado sua compreensão sobre o conceito de Dupla Excepcionalidade após a

atividade. Apenas uma relatou que, ao identificar nas falas e exemplos situações semelhantes às vivenciadas com seu próprio filho, ampliou sua percepção sobre o tema. O Gráfico 9 representa visualmente essa distribuição, evidenciando as percepções dos responsáveis após a oficina.

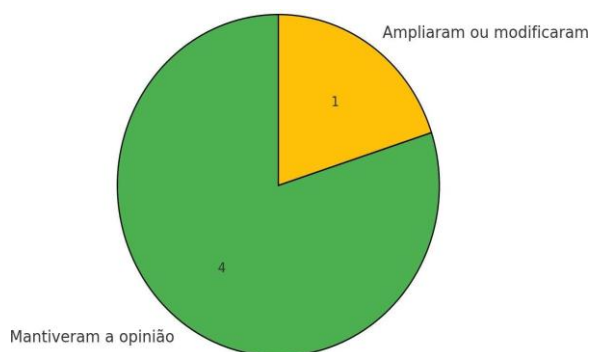


Gráfico 9: Percepção sobre Dupla Excepcionalidade após a Oficina (responsáveis TEA)

De modo geral, as participantes consolidaram o entendimento da DE como a coexistência de dois diagnósticos em um mesmo indivíduo, especialmente a associação entre AHSD e TEA, além de possíveis combinações com outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH.

Apesar dos desafios cotidianos impostos pelo TEA, todas as mães demonstraram reconhecer em seus filhos potenciais significativos, frequentemente associados a características de altas habilidades. Esse movimento de valorização das capacidades está alinhado às reflexões de Hidalgo (2020), que destaca o papel central das mães no reconhecimento dos talentos, na defesa dos direitos e na promoção do desenvolvimento de crianças com Dupla Excepcionalidade. Quando as famílias compreendem tanto os desafios quanto às potencialidades de seus filhos, tornam-se agentes fundamentais para fortalecer sua autonomia, favorecer conquistas acadêmicas e promover sua qualidade de vida.

6.10 Detalhamento das condições de prevalência das características: AHSD e/ou TEA

A observação inicial de uma ou outra condição na criança/adolescente é um processo que motiva os encaminhamentos para avaliação, no entanto exige uma

análise que vá além das características individuais das crianças, considerando também os contextos socioculturais e institucionais nos quais essas famílias estão inseridas. O Quadro 27 apresenta a característica que é predominante nos tutelados do grupo de responsáveis AHSD.

Quadro 27: Detalhamento das Condições que prevalecem (Grupo AHSD)

CONDIÇÃO	NÚMERO DE CASOS
Superdotação apenas	24
TEA apenas	2
Dupla Condição (AHSD e TEA)	5
Não respondeu	2
TOTAL	33

Verificou -se que a maioria dos responsáveis do grupo AHSD têm nível superior de escolaridade (quadro 22) o que pode ser uma determinante que influencia o tipo de ambiente frequentado por seus tutelados. Essa influência do ambiente sobre o processo de identificação é destacada por Pérez e Freitas (2016, p. 254), “[...] o reconhecimento das altas habilidades não é um processo neutro, mas profundamente condicionado pelas experiências, pelos espaços de socialização e pelo acesso a redes de informação que cada família possui”.

Ao falar do modelo bioecológico do desenvolvimento humano, Bronfenbrenner (1996, p. 165) explica que “[...] o desenvolvimento humano ocorre nas interações progressivamente mais complexas entre o indivíduo e os ambientes nos quais ele está inserido, especialmente no microssistema e no mesossistema”. Dessa forma, os percursos de identificação são diretamente moldados pelas interações entre família, escola e serviços especializados.

O Gráfico 10 aponta que a maioria das crianças/adolescentes desse grupo de responsáveis continua apresentando apenas a AHSD (60,6%), o que pode ser interpretado como resultado da exposição das crianças e/ou adolescentes a espaços que estimulem os seus potenciais, oferecendo maior acesso a informações, redes de apoio e serviços especializados. Esse padrão é consistente com a análise de Renzulli (2004, p. 249), que afirma: “[...] os indivíduos são mais facilmente identificados como superdotados quando estão inseridos em contextos que oferecem oportunidades para que seus talentos se manifestem e sejam reconhecidos”.

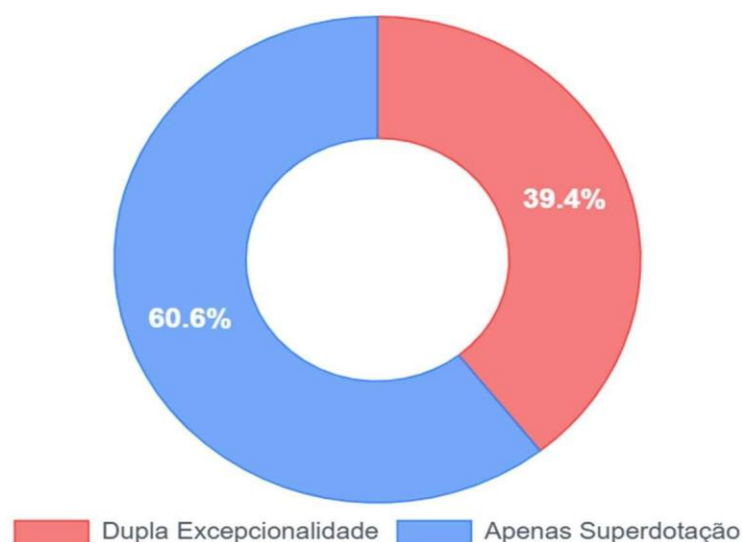


Gráfico 10: AHSD Diagnóstico como ponto de partida

A partir das respostas dos responsáveis por crianças com TEA, no quadro 28, observa-se que, entre os cinco casos analisados, quatro tiveram o autismo como condição predominante para a indicação à avaliação, enquanto apenas um caso teve a superdotação citada. Isso evidencia que, mesmo em contextos em que há suspeita de AHSD, o diagnóstico de TEA tende a se sobrepôr como critério de encaminhamento.

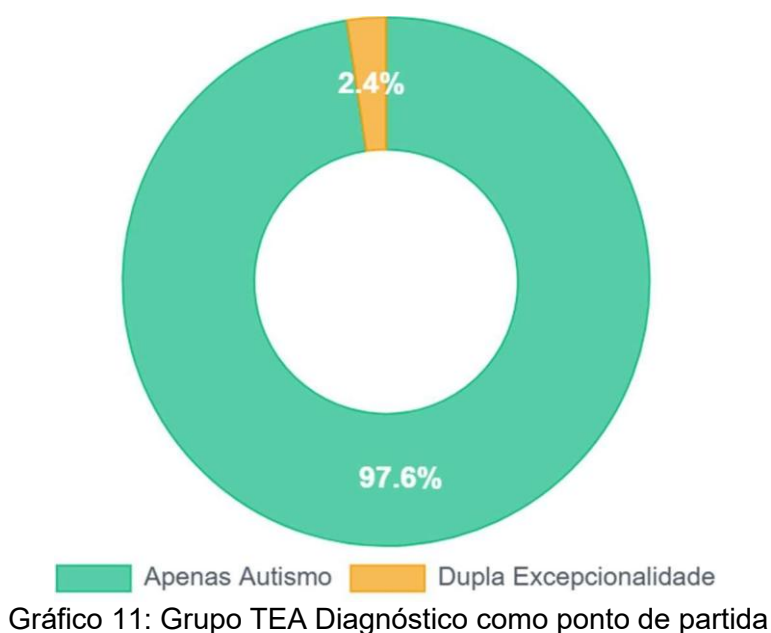
Quadro 28: Detalhamento das Condições que prevaleceram (Grupo TEA)

CONDIÇÃO PREVALENTE	FREQUÊNCIA
Autismo	4
Superdotação	1
TOTAL	5

No grupo TEA, o padrão é inverso do grupo AHSD, em quatro dos cinco casos, o autismo foi a condição que motivou o encaminhamento, enquanto a superdotação apareceu de forma isolada em apenas um caso. Este dado reflete o fenômeno conhecido como *efeito de mascaramento*, no qual as características associadas ao TEA acabam sobrepondo os sinais de AHSD Assouline, Foley Nicpon e Huber destacam que

[...] os desafios comportamentais e sociais relacionados ao TEA tendem a ser priorizados nos processos de avaliação, o que frequentemente resulta na negligência dos traços de altas habilidades presentes nesses indivíduos (Assouline, Foley Nicpon e Huber 2020, p. 206).

O Gráfico 11 reforça o que é apresentado no quadro 28 ao indicar que apenas 2,4% observam a característica da Superdotação, revelando a dificuldade no reconhecimento da Dupla Excepcionalidade no contexto do autismo também é enfatizada por Fleith e Vilarinho-Rezende (2022, p. 5), que afirmam: “As potencialidades de crianças com TEA e altas habilidades são frequentemente invisibilizadas, dado que as práticas escolares e terapêuticas tendem a se concentrar nas dificuldades, em detrimento dos talentos”.



Diante desse cenário, os dados desta pesquisa revelam que os percursos de identificação estão intrinsecamente ligados às redes de apoio, aos contextos institucionais e às experiências vivenciadas pelas famílias. Quando inseridas em ambientes que priorizam a superdotação, há maior sensibilidade para o reconhecimento dos talentos. Por outro lado, quando o foco está nas demandas adaptativas do TEA, essas mesmas potencialidades tendem a ser negligenciadas, reforçando um ciclo de subidentificação que já é amplamente discutido na literatura especializada. Ressalta-se, porém, que como o número de respondentes do 2º questionário participantes do grupo TEA foi pequeno comparado ao grupo AHSD, esse dado pode ter sofrido erros. Também é importante destacar que nem todas as crianças autistas terão diagnóstico de superdotação e vice-versa.

6.11 Distribuição das Inteligências acima da média dos filhos dos participantes

Com base nos dados da pesquisa, o quadro 29 apresenta a distribuição das inteligências consideradas acima da média pelos participantes do grupo com AHSD.

Quadro 29: Distribuição das inteligências (Grupo AHSD)

TIPO DE INTELIGÊNCIA	NÚMERO DE CRIANÇAS
Lógico-Matemática	21
Linguística	16
Musical	14
Interpessoal	9
Naturalista	8
Espacial	7
Intrapessoal	4
Todas as inteligências	1
Não informado	1

A análise revela que a inteligência Lógico-matemática é a mais recorrente, citada pelos participantes. Na sequência, destacam-se as inteligências Linguística e Musical. As inteligências Interpessoal, Naturalista e Espacial aparecem com frequência intermediária, enquanto a Intrapessoal foi a menos referida. Um dos participantes (P27) sinalizou que seu filho apresenta “todas as inteligências” acima da média.

Esses dados refletem o que defende Gardner (2001) em sua Teoria das Inteligências Múltiplas, segundo a qual *“todo ser humano possui uma combinação única de inteligências, que se manifestam de maneiras distintas”* (p. 35). No grupo AHSD, observa-se uma predominância dos domínios Lógico-matemático, Linguístico e Musical, frequentemente associados em combinações, especialmente entre as tríades Lógico-matemática, Linguística e Musical ou Lógico-matemática e Interpessoal, revelando perfis cognitivos complexos e variados.

No grupo TEA, os dados apresentados no Quadro 30 apontam um padrão diferente.

Quadro 30: Tipos de Inteligências e Números de Crianças (Grupo TEA)

TIPO DE INTELIGÊNCIA	NÚMERO DE CRIANÇAS
Musical	3
Lógico Matemática	3
Linguística	2

As inteligências mais citadas foram Lógico-matemática e Musical e Linguística. Embora menos diversificado em relação ao grupo AHSD, também é possível perceber a presença de múltiplas inteligências, reforçando que crianças com TEA apresentam perfis heterogêneos, com talentos que podem coexistir com os desafios característicos do transtorno.

A análise comparativa, ilustrada no Quadro 30 e Gráficos 10 e 11 demonstram que, apesar das diferenças nas frequências, as inteligências Lógico-matemática e Musical aparecem como predominantes em ambos os grupos. Esse dado reforça a premissa de Gardner de que “[...] não há uma única forma de ser inteligente; as inteligências operam em conjunto, moldando as diversas formas de aprender, compreender e interagir com o mundo” (Gardner, 2001, p. 39).

Portanto, tanto no grupo AHSD quanto no grupo TEA, observa-se que os perfis de inteligência são multifacetados, validando a concepção de que cada indivíduo apresenta uma configuração única de habilidades, que deve ser reconhecida e valorizada nos processos educacionais e de desenvolvimento.

6.12 Nível de Suporte das crianças com AHSD e/ou TEA

O conceito de nível de suporte está diretamente vinculado aos critérios diagnósticos do TEA e foi oficialmente incorporado na quinta edição do *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* – DSM-5, publicado pela American Psychiatric Association (APA) em 2013. Essa classificação tem como objetivo indicar a quantidade, a intensidade e a constância de apoio que o indivíduo necessita para enfrentar desafios nas áreas da comunicação social e dos comportamentos restritivos e repetitivos.

De acordo com a APA (2014), o TEA é classificado em três níveis de suporte:

Nível 1 – Suporte Leve: “Necessita de apoio”. As pessoas neste nível apresentam certa autonomia funcional, mas demonstram dificuldades perceptíveis nas interações sociais e podem ter comportamentos inflexíveis que impactam o funcionamento em contextos escolares, familiares ou sociais. As intervenções são geralmente pontuais e menos intensivas.

Nível 2 – Suporte Moderado: “Necessita de apoio substancial”. Há déficits significativos nas habilidades sociais e na comunicação, com interações sociais limitadas, mesmo com apoio. Comportamentos restritivos e dificuldades de adaptação são mais evidentes, demandando intervenções mais frequentes e um acompanhamento sistemático.

Nível 3 – Suporte Intenso: “Necessita de apoio muito substancial”. As dificuldades são severas tanto na comunicação quanto na flexibilidade comportamental. A pessoa necessita de suporte contínuo em praticamente todos os ambientes, dado que sua autonomia funcional é bastante limitada. Este nível não foi identificado nos dados da presente pesquisa.

Conforme a própria definição da APA (2014, p. 58), “[...] os níveis de gravidade não são determinados apenas pelas características do TEA, mas também pela quantidade de suporte necessário para o funcionamento adaptativo”. Ou seja, trata-se de uma classificação dimensional, que considera a intensidade das necessidades de suporte, e não uma hierarquização de comprometimentos cognitivos ou intelectuais.

É fundamental destacar que essa classificação de níveis de suporte é específica para o TEA e não se aplica a crianças diagnosticadas apenas com AHSD. Enquanto o TEA se estrutura a partir de déficits em comunicação social e padrões restritivos de comportamento, as AHSD se caracterizam por desempenho excepcional em uma ou mais áreas do conhecimento, criatividade ou habilidades psicossociais, sem, necessariamente, demandar suporte adaptativo — a não ser que haja uma condição associada, como no caso da Dupla Excepcionalidade.

Ressalta-se que a atribuição dos níveis de suporte tem implicações diretas no planejamento educacional e terapêutico. Segundo Schmidt et al. (2020, p. 3), “[...] o entendimento claro dos níveis de suporte no TEA permite que profissionais de saúde e educação alinhem intervenções personalizadas às demandas específicas de cada indivíduo, promovendo melhor qualidade de vida e

desenvolvimento”.

Assim, compreender os níveis de suporte é essencial não apenas para fins diagnósticos, mas também para orientar práticas pedagógicas, propostas de intervenção multidisciplinar e políticas de inclusão.

A análise dos dados apresentados no Quadro 31 revela que, no grupo de crianças inicialmente identificadas com AHSD, o Nível 1 de suporte foi predominante entre aquelas que posteriormente receberam o diagnóstico DE.

Quadro 31: Nível de Suporte (Grupo AHSD)

NÍVEL DE SUPORTE	QUANTIDADE
Nível 1	6
Não soube informar	2
Sem resposta	25
TOTAL	33

Esse nível de suporte indica que essas crianças, embora apresentem características associadas ao TEA, demandam um apoio considerado leve, especialmente nas interações sociais, na comunicação funcional e na adaptação a diferentes contextos. Segundo o DSM-5 (APA, 2014), o Nível 1 se aplica àqueles que “necessitam de apoio, mas que conseguem funcionar com intervenções pontuais, principalmente nas situações sociais” (APA, 2014, p. 55).

Esse dado é particularmente relevante, pois sinaliza que, no caso das crianças cujo diagnóstico inicial foi de superdotação, as manifestações do TEA costumam ser mais sutis e, conseqüentemente, podem passar despercebidas por longos períodos. Esse percurso faz com que a identificação da DE ocorra geralmente de forma tardia, muitas vezes após a emergência de dificuldades sociais, emocionais ou comportamentais que não são explicadas apenas pelas características de altas habilidades.

Por outro lado, no grupo de crianças que tiveram como diagnóstico inicial o TEA, observa-se um cenário similar (quadro 32), porém com nuances específicas.

Quadro 32: Nível de Suporte (Grupo TEA)

NÍVEL DE SUPORTE	QUANTIDADE
Nível 1	3
Nível 2	2
TOTAL	5

A maioria também foi classificada no Nível 1 de suporte, enquanto as demais foram enquadradas no Nível 2, que corresponde à necessidade de apoio substancial, especialmente no desenvolvimento de habilidades adaptativas, na comunicação funcional e na regulação emocional. Apesar dessa distribuição, chama atenção o fato de que, entre essas crianças, apenas uma recebeu o diagnóstico de Dupla Excepcionalidade, revelando o quão desafiador é reconhecer a coexistência do TEA com as AHSD nesse contexto.

Como apontam Assouline et al. (2020, p. 8), “[...] as características associadas ao TEA podem obscurecer os indicadores de superdotação, tornando o processo de identificação extremamente desafiador”, principalmente com níveis de suporte 2 ou 3 como é o caso de algumas crianças não verbais. De forma complementar, Baum, Schader e Owen (2017, p. 5) alertam que “[...] quando as dificuldades do espectro são mais visíveis, há uma tendência de os profissionais focarem nas limitações, negligenciando os pontos fortes e talentos que coexistem”.

Ao comparar os dados sugerem que, embora o Nível 1 de suporte apareça com maior frequência em ambos os grupos, os percursos de identificação da DE parecem seguir trajetórias distintas. No grupo de crianças inicialmente AHSD a chegada ao diagnóstico de TEA tende a ocorrer em um momento posterior, possivelmente motivada por desafios nas interações sociais, emocionais ou comportamentais que não se explicariam apenas pelas características da superdotação.

Por outro lado, no grupo de crianças inicialmente diagnosticadas com TEA, a identificação da DE se mostra menos comum, o que pode estar relacionado às próprias características do espectro, que, em alguns casos, parecem dificultar o reconhecimento de traços associados às altas habilidades, especialmente em perfis que demandam maior suporte no desenvolvimento adaptativo e na comunicação.

Esses achados apontam para a possibilidade de que o reconhecimento da Dupla Excepcionalidade ainda seja um processo complexo, que exige avaliações mais sensíveis, olhares interdisciplinares e uma articulação cuidadosa entre os contextos familiar, educacional e de saúde.

6.13 Rede de apoio dos responsáveis das crianças com AHSD e TEA

Ao entender o nível de suporte das crianças e/ou adolescentes cujos responsáveis participaram da pesquisa, fez-se igualmente importante compreender como é a rede de apoio a esses familiares.

No grupo de crianças com AHSD, observa-se que a maioria dos responsáveis relata contar com uma rede de apoio efetiva. Apesar do pai da criança ser a principal figura de suporte, em alguns casos há a participação de outros membros da família, como avós ou irmãos mais velhos (Quadro 33).

Quadro 33: Rede de apoio dos responsáveis das crianças com AHSD

FONTE DE APOIO	PARTICIPANTES
Pai	P1, P2, P3, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P16, P17, P18, P19, P24, P25, P27, P28, P29, P30, P31, P32 e P33
Avós	P2, P6, P14, P17 e P26
Irmã(o) mais velho	P9
Não possui apoio	P4 e P15
Não respondeu	P20, P21, P22 e P23

No grupo de responsáveis por crianças com TEA, os dados demonstram que a maioria também informou contar com algum tipo de suporte, e este se concentra quase exclusivamente na figura paterna, com pouca participação de outros familiares ou membros da rede ampliada (Quadro 34).

Quadro 34: Rede de apoio dos responsáveis das crianças com AHSD e TEA

FONTE DE APOIO	PARTICIPANTES
Pai	P1, P2, P4 e P5
Avós	P4
Não possui apoio	P3

A análise comparativa revela que a participação paterna se destaca como um pilar em ambos os contextos. Contudo, o Gráfico 12 traz um comparativo, e mostra que a principal diferença reside na amplitude dessa rede de apoio: mais diversificada no grupo AHSD e mais restrita ao núcleo parental no grupo TEA.

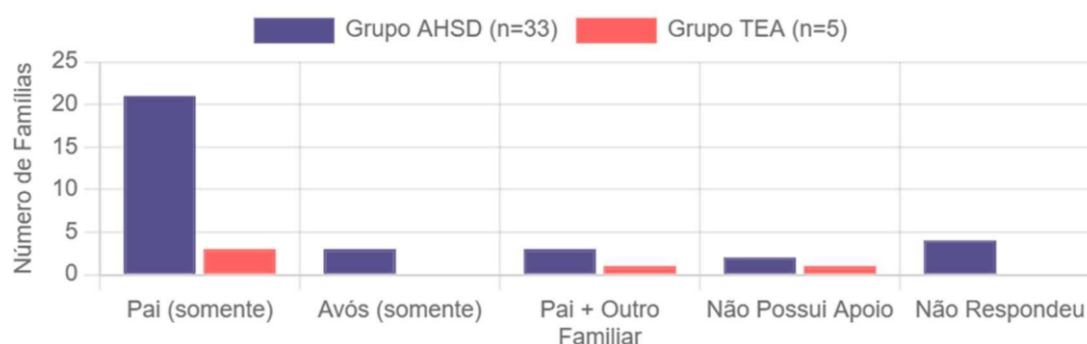


Gráfico 12: Comparativo de apoio Familiar

A jornada de famílias com crianças com Altas Habilidades/Superdotação (AHSD) ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) é frequentemente marcada por uma intensa sobrecarga emocional, especialmente quando a rede de apoio se mostra insuficiente. Ainda que o suporte familiar represente um alicerce fundamental em ambos os cenários, a pressão do cuidado diário acentua o risco de estresse, um peso que recai majoritariamente sobre as mães, que tradicionalmente assumem a linha de frente dessas responsabilidades. Apesar da presença do suporte, a sobrecarga materna persiste como uma realidade em ambos os cenários, especialmente nos casos em que a ajuda é limitada.

A ausência ou fragilidade das redes de apoio impacta diretamente o bem-estar familiar, aumentando a sobrecarga, sobretudo materna (Silva; Schmidt, 2010; Schmidt et al., 2016; Marques et al., 2019). No caso das famílias de crianças com AHSD, embora as altas habilidades sejam socialmente vistas como uma vantagem, também geram desafios emocionais, sociais e educacionais, demandando redes de apoio que compreendam essas especificidades (Pérez; Freitas, 2016; Alencar; Fleith, 2001).

Por sua vez, as famílias de crianças com TEA lidam com demandas mais intensas e contínuas, especialmente relacionadas a cuidados diários e intervenções terapêuticas, agravadas pela carência de suporte institucional e de políticas públicas eficazes (Schmidt et al., 2016; Silva; Schmidt, 2010).

6.14 Análise Descritiva e Crítica sobre Políticas Públicas e Suportes para Crianças com AHSD e TEA

Os responsáveis foram questionados sobre o tipo de necessidades e suportes que tanto seus tutelados necessitam, como eles próprios para que melhor possam auxiliar as crianças e/ou adolescentes (quadro 35).

Quadro 35: Necessidades e Suportes – Grupo AHSD

CATEGORIA	SIM	NÃO	NÃO INFORMADO
Necessita de Professor Mediador	9,1%	81,8%	9,1%
Possui Plano de Saúde	57,6%	33,3%	9,1%
Frequenta Atendimento Educacional Especializado (AEE)	18,2%	72,7%	9,1%
Acompanhamento por Equipe Multiprofissional	12,1%	87,9%	0%
Realiza Terapia	69,7%	21,2%	9,1%

O fato de 81,8% dos responsáveis informarem que seus filhos não necessitam de professor mediador não deve ser interpretado como ausência de necessidade de suporte, mas como uma indicação da natureza específica dos desafios enfrentados por esse grupo, que, muitas vezes, não se traduzem em demandas por mediação escolar, e sim por estímulo, enriquecimento curricular, atendimento especializado e suporte socioemocional.

Do ponto de vista da saúde, observa-se que 57,6% possuem plano de saúde, o que é relevante, pois, na prática, o acesso a profissionais especializados (como psicólogos, psicopedagogos e neuropsicólogos) acaba sendo terceirizado às redes privadas. Ainda assim, 33,3% das famílias não possuem plano de saúde, ficando dependentes de uma rede pública que, historicamente, não reconhece nem oferece protocolos específicos de atendimento para superdotação, conforme apontam Vieira e Fleith (2019).

O dado mais alarmante recai sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE): somente 18,2% das crianças o frequentam, embora a legislação brasileira, especialmente a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, inclua as AHSD no público-alvo da Educação Especial. A expressiva maioria (72,7%) não acessa esse serviço, o que configura uma violação de direito educacional, fruto da invisibilidade estrutural desse público nas políticas públicas, como bem problematizam Mantoan (2003) e Cardoso e Souza (2021).

O acompanhamento por equipes multiprofissionais, indicado por apenas

12,1% dos participantes, reflete uma falta grave de articulação intersetorial entre educação, saúde e assistência social, indo na contramão do que preconizam documentos como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

Segundo Pérez e Freitas (2019) e Renzulli (2004), os alunos com AHSD necessitam de práticas pedagógicas diferenciadas que promovam o desenvolvimento de seu potencial, e não apenas adaptações curriculares comuns à Educação Especial tradicional. Entretanto, a ausência de políticas públicas específicas para esse grupo faz com que seus direitos sejam frequentemente negligenciados, levando muitas vezes à evasão escolar, desmotivação ou desenvolvimento de quadros de sofrimento psíquico.

Por outro lado, um dado relevante e positivo é que 69,7% realizam algum tipo de terapia, especialmente na área psicológica, evidenciando uma ação proativa das famílias, que buscam preencher as lacunas deixadas pelo Estado. Contudo, 21,2% não realizam nenhuma terapia, o que, aliado à falta de suporte escolar, configura uma situação de alto risco para o desenvolvimento integral dessas crianças.

O não acompanhamento psicológico de indivíduos com AHSD pode gerar impactos severos em seu desenvolvimento socioemocional, resultando em quadros de ansiedade, depressão, isolamento social e dificuldades de ajustamento, como alertam autores como Silverman (2013), Pfeiffer (2015) e Neihart et al. (2016). Esses efeitos se agravam especialmente quando suas necessidades cognitivas são atendidas de forma desarticulada das socioemocionais, reforçando a urgência de modelos de atendimento multidisciplinar que incluam suporte psicológico contínuo (Baum; Foley-Nicpon; Dixon, 2014; Alves; Nakano, 2021).

A realidade do grupo de crianças com TEA, representada no Gráfico 35, apresenta contrastes importantes.

Quadro 36: Necessidades e Suportes – Grupo TEA

CATEGORIA	SIM	NÃO	NÃO INFORMADO
Necessita de Professor Mediador	60%	40%	0%
Possui Plano de Saúde	80%	20%	0%

Frequenta Atendimento Educacional Especializado (AEE)	20%	80%	0%
Acompanhamento por Equipe Multiprofissional	60%	40%	0%
Realiza Terapia	100%	0%	0%

Ao contrário do grupo AHSD, há uma alta demanda por professor mediador (60%), o que é coerente com as barreiras sociais e comunicacionais características do TEA, conforme apontam as diretrizes do Protocolo de Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com TEA (Brasil, 2014) e as contribuições de Amaral (2017).

O acesso à saúde é relativamente mais garantido neste grupo, com 80% dos participantes possuindo plano de saúde, o que facilita o ingresso em terapias fundamentais como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, integração sensorial e psicomotricidade. Esse dado confirma o que já é apontado por autores como Schmidt e Bosa (2019), que destacam o papel central das terapias no desenvolvimento de crianças autistas.

Apesar dos avanços no campo terapêutico, observa-se um cenário crítico no âmbito educacional, semelhante ao do grupo AHSD: apenas 20% frequentam o AEE, e a maioria (80%) não acessa esse direito, seja por falta de oferta, desinformação ou negligência das instituições escolares. Isso contradiz diretamente o que preconiza a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a própria Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

Um aspecto que diferencia positivamente o grupo TEA é o dado de que 100% das crianças realizam terapias, indicando um reconhecimento maior, por parte das famílias e dos serviços, da necessidade de suporte contínuo. Além disso, 60% são acompanhadas por equipes multiprofissionais, revelando uma rede de apoio mais estruturada, especialmente na saúde.

A análise conjunta dos dois grupos evidencia uma realidade paradoxal: O grupo AHSD sofre sobretudo com a invisibilidade e negligência institucional, especialmente na educação, saúde pública e assistência social. Suas necessidades são frequentemente desconsideradas pelas políticas públicas, que ainda operam com uma visão limitada sobre o que é inclusão, restrita às deficiências visíveis.

O grupo TEA, embora mais reconhecido nas áreas de saúde e terapias,

ainda enfrenta sérias barreiras no campo educacional, com baixa oferta ou efetivação do AEE, além da dificuldade na implementação de práticas pedagógicas inclusivas e adaptadas.

Essa realidade reflete o que Pletsch (2019) denomina de "fragmentação das políticas públicas na intersecção entre educação e saúde", além de denunciar a urgência da construção de políticas intersetoriais que reconheçam e acolham a complexidade das necessidades dos sujeitos neurodivergentes, sejam eles com TEA, AHSD ou ambos (Dupla Excepcionalidade).

6.15 Tipos de Terapias Realizadas AHSD e TEA

Os dados revelam que, entre as crianças com AHSD e/ou Dupla Excepcionalidade, a maioria realiza acompanhamento psicológico, que aparece como a intervenção mais recorrente (21 crianças), conforme ilustrado no Gráfico 13. Essa prevalência reflete a busca por apoio no desenvolvimento emocional, social e acadêmico, que muitas vezes não é contemplado adequadamente no contexto escolar.

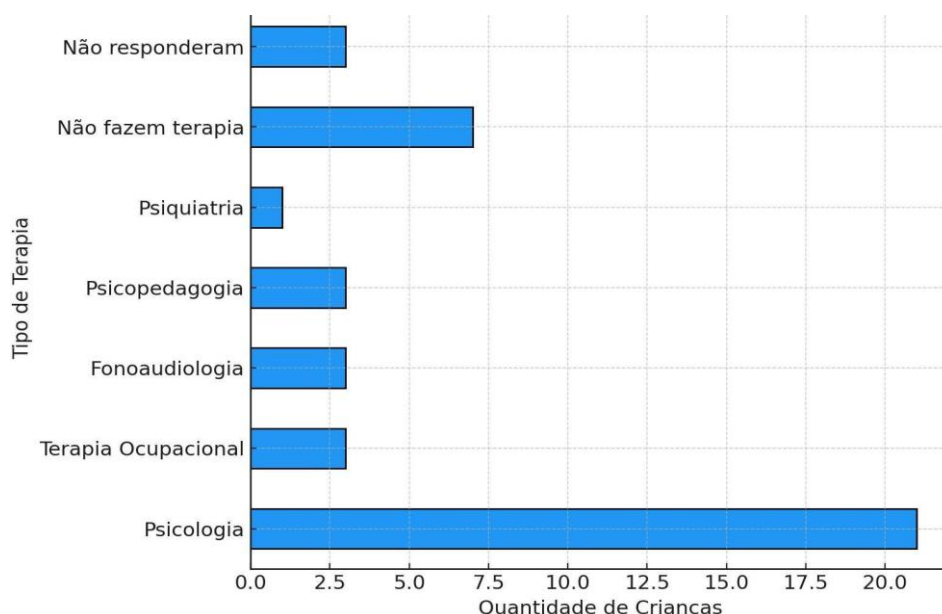


Gráfico 13: Tipos de Terapias Realizadas – Grupo AHSD

Outras terapias aparecem em menor escala, como Terapia Ocupacional (3), Fonoaudiologia (3) e Psicopedagogia (3), geralmente associadas a demandas

específicas de desenvolvimento ou dificuldades de aprendizagem. Apenas 1 participante relatou acompanhamento psiquiátrico. Além disso, 7 famílias relataram que seus filhos não realizam nenhuma terapia, e 3 não responderam à pergunta, o que também sugere desafios no acesso ou falta de indicação para acompanhamento terapêutico.

No grupo de familiares de crianças com TEA e/ou Dupla Excepcionalidade, os dados revelam uma realidade de acompanhamento terapêutico ainda mais intensa. Conforme ilustrado no Gráfico 14, todas as crianças realizam terapias, demonstrando o reconhecimento das demandas associadas ao TEA, sendo a psicologia a mais comum.

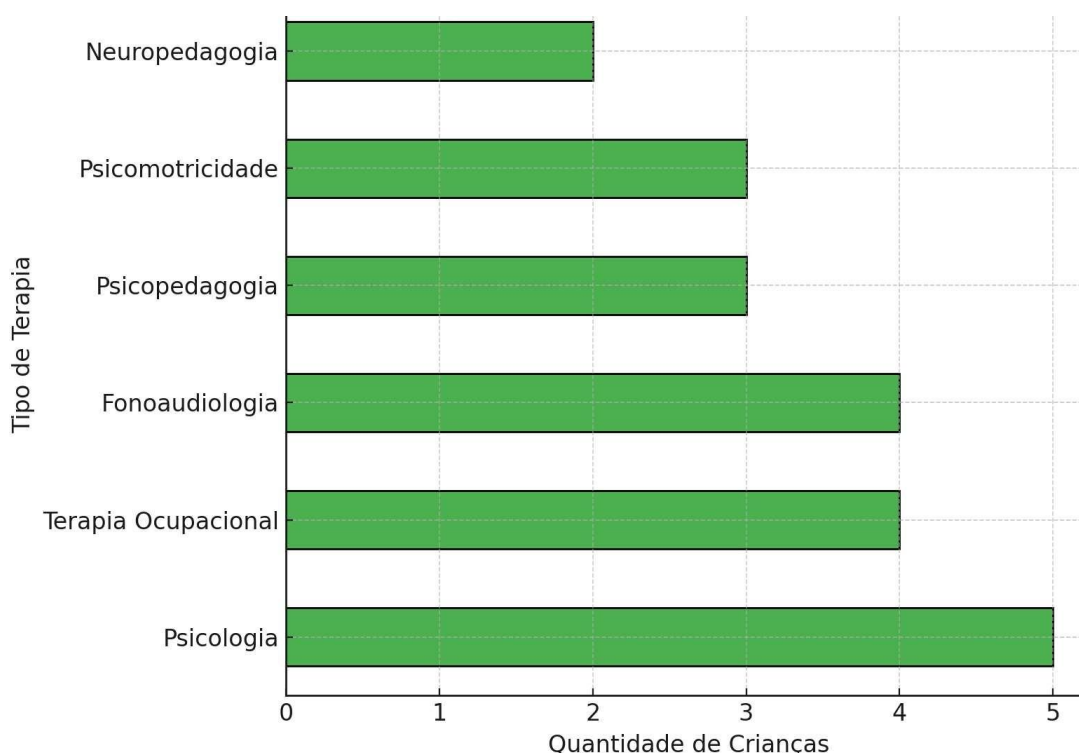


Gráfico 14: Tipos de Terapias Realizadas – Grupo TEA

As terapias apresentadas são igualmente importantes: (1) Psicologia – presente em todos os casos, com foco no desenvolvimento emocional, comportamental e social; (2) Terapia Ocupacional (TO) e Fonoaudiologia, muito frequentes, especialmente para trabalhar aspectos sensoriais, motores e de comunicação; (3) Psicomotricidade, Psicopedagogia e Acompanhamento Neuropedagógico aparecem em vários relatos, demonstrando uma abordagem mais diversificada e especializada no grupo TEA.

Esse cenário reflete tanto a maior complexidade das demandas associadas ao TEA quanto a dependência das famílias de serviços privados, muitas vezes não acessíveis na rede pública, como evidenciado nos dados de que 80% dos participantes possuem plano de saúde, fator determinante no acesso às terapias.

Essa diferença também reflete os próprios critérios de identificação: no contexto do TEA, as necessidades são geralmente mais evidentes desde a primeira infância, especialmente nos domínios da comunicação e do comportamento social (APA, 2013; OMS, 2022). Já no grupo AHSD, as demandas podem ser percebidas de forma mais sutil ou tardia, muitas vezes associadas a aspectos emocionais e escolares, como dificuldades de motivação, tédio, frustração e questões de ajustamento social (Alves; Nakano, 2021).

Portanto, a comparação revela que, enquanto o grupo AHSD prioriza majoritariamente o suporte psicológico, com intervenções complementares em menor escala, o grupo TEA apresenta uma abordagem terapêutica abrangente, envolvendo múltiplas áreas do desenvolvimento de forma simultânea e contínua (Gráfico 15).

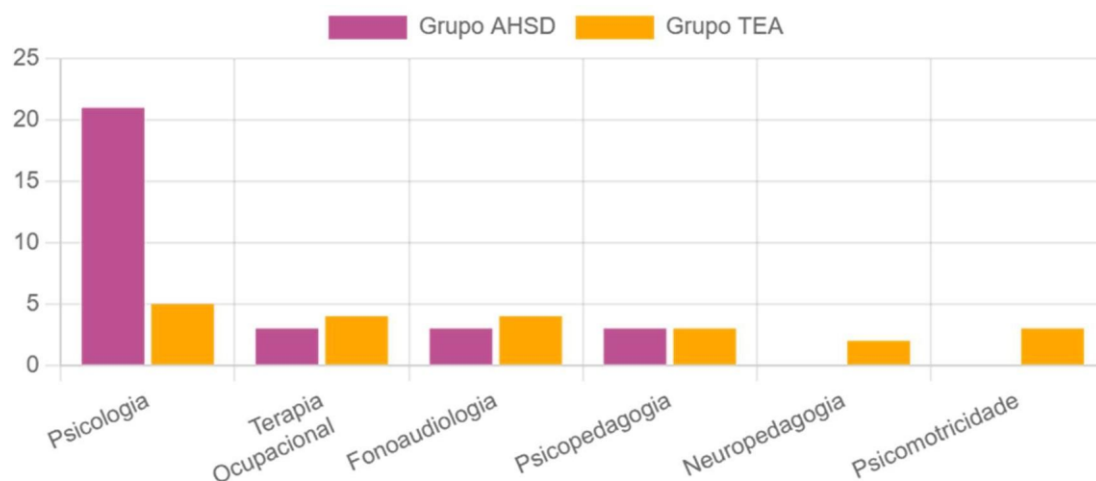


Gráfico 15: Comparação Atendimento terapêutico

Esse cenário dialoga diretamente com o que aponta Baum, Schader e Hébert (2017), ao destacar que a Dupla Excepcionalidade, especialmente quando associada ao TEA, exige uma compreensão profunda tanto das potencialidades quanto dos desafios que coexistem, demandando intervenções diferenciadas, sensíveis e multidimensionais.

Esse cenário desperta importantes reflexões sobre a disparidade de acesso, percepção e encaminhamento para serviços terapêuticos entre os dois grupos estudados. Os dados analisados evidenciam contrastes marcantes entre os grupos pesquisados no que se refere ao acesso e à diversidade dos acompanhamentos terapêuticos. Entre as crianças com AHSD e/ou Dupla Excepcionalidade, o suporte concentra-se predominantemente na Psicologia (21 casos), enquanto terapias como Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicopedagogia aparecem de forma esporádica, com apenas três registros em cada área. A quase inexistência de acompanhamento psiquiátrico (1 caso), a ausência total de terapias em sete famílias e a não resposta de três participantes indicam possíveis barreiras de acesso, desinformação ou até a negação institucional das necessidades dessa população.

No grupo TEA, o panorama é substancialmente distinto: todas as crianças recebem algum tipo de intervenção terapêutica, com destaque para Psicologia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia. Além disso, o uso de abordagens complementares, como Psicomotricidade, Psicopedagogia e Acompanhamento Neuropedagógico, demonstra uma busca por estratégias multidisciplinares, ajustadas à complexidade do Transtorno do Espectro Autista. Esse cenário revela não apenas uma maior sensibilidade às demandas do TEA, mas também uma dependência de serviços privados — reforçada pelo dado de que 80% das famílias desse grupo possuem plano de saúde.

A comparação apresentada no Gráfico 15 explicita essas diferenças: o grupo AHSD apresenta um perfil de cuidado mais restrito, centrado no aspecto emocional, enquanto o grupo TEA é acompanhado por uma rede terapêutica ampla, que abrange diferentes dimensões do desenvolvimento. Essa disparidade reflete não apenas os critérios diagnósticos vigentes, mas também a forma como cada condição é reconhecida socialmente e acolhida pelas instituições. No caso do TEA, os sinais costumam emergir precocemente, o que favorece o encaminhamento para intervenções especializadas desde a infância. Já entre os sujeitos com AHSD, os desafios tendem a ser interpretados de forma ambígua ou subestimada, muitas vezes mascarados por desempenhos acadêmicos elevados, o que retarda ou inviabiliza o acesso a apoios adequados.

Como ressaltam Baum, Schader e Hébert (2017), a Dupla Excepcionalidade requer intervenções que reconheçam simultaneamente o potencial e a

vulnerabilidade. Cuidar de forma efetiva exige uma abordagem sensível, integradora e multidimensional, que leve em consideração tanto as altas habilidades quanto as barreiras funcionais, emocionais e sociais enfrentadas por esses indivíduos.

6.16 Tipo de Escola

O tipo de escola frequentado pelas crianças e/ou adolescentes revela um padrão consistente com a literatura sobre AHSD e TEA no Brasil e no cenário internacional. No Quadro 37, é possível observar se as crianças e/ou adolescentes de ambos os grupos estão matriculados em escolas públicas ou privadas.

Quadro 37: Tipo de Escola (AHSD e TEA)

GRUPO	ESCOLA PÚBLICA	ESCOLA PARTICULAR	TOTAL
AHSD	16 (48,5%)	17 (51,5%)	33
TEA	2 (40%)	3 (60%)	5

Para o grupo AHSD, a distribuição equilibrada entre rede pública (48,5%) e privada (51,5%) evidencia a heterogeneidade do perfil socioeconômico das famílias, mas também indica que a presença em escolas particulares não garante, por si só, um atendimento adequado às necessidades educacionais específicas (Assouline et al., 2020; Baum; Schader; Hébert, 2017). As queixas recorrentes das famílias — tanto na rede pública quanto na privada — refletem o que Nakano (2021) descreve como “[...] invisibilidade institucional da Dupla Excepcionalidade”, principalmente no que se refere às necessidades da superdotação, um fenômeno em que as potencialidades dos alunos são negligenciadas quando existem diagnósticos concomitantes de TEA ou outros transtornos.

No caso das crianças com TEA, os dados desta pesquisa revelam uma maior presença na rede particular (60%) em comparação à pública (40%). Essa escolha, possivelmente, reflete a percepção das famílias de que a rede pública, apesar dos avanços legais em prol da inclusão, ainda não oferece, de forma consistente, os recursos, serviços e apoios necessários para atender plenamente às necessidades desse público. Essa realidade é corroborada por autores como Mantoan (2015), Freitas (2016) e Schmidt, Gomes e Souza (2020), que destacam que as escolas

públicas brasileiras seguem enfrentando desafios estruturais, carência de formação docente especializada e limitações na oferta de serviços de apoio. Além disso, essa decisão das famílias parece estar relacionada à busca por contextos escolares que ofereçam, no mínimo, condições básicas de acolhimento, suporte pedagógico e atenção às demandas socioemocionais. Essa percepção também é evidenciada por Foley-Nicpon et al. (2013), ao apontarem que as famílias de crianças com TEA frequentemente enfrentam dificuldades para encontrar instituições que não apenas garantam a inclusão física, mas também promovam, de forma efetiva, um ambiente pedagógico e emocional verdadeiramente acolhedor.

6.17 Reconhecimento Institucional da AHSD e/ou TEA

A análise dos dados revela que o reconhecimento institucional da DE ainda é, na maioria dos casos, parcial e limitado, tanto no grupo de crianças com AHSD quanto no grupo com TEA (Quadro 38).

Quadro 38: Comparativo do Reconhecimento Institucional – AHSD e TEA

CATEGORIA DE RECONHECIMENTO	GRUPO AHSD (N=33)	GRUPO TEA (N=5)
Reconhece a Dupla Excepcionalidade	7 (21,2%)	0 (0%)
Reconhece apenas a Superdotação	18 (54,5%)	1 (20%)
Reconhece apenas o Autismo	0 (0%)	2 (40%)
Não reconhece nenhuma condição	2 (6,1%)	1 (20%)
Não informado / Não se aplica	6 (18,2%)	1 (20%)

No grupo AHSD, observa-se uma tendência de as instituições reconhecerem apenas as altas habilidades, desconsiderando desafios associados, como o TEA, quando presente. Por sua vez, no grupo TEA, o olhar escolar permanece centrado nas características do autismo, o que leva à invisibilização de possíveis talentos — um fenômeno conhecido na literatura como “sombreamento diagnóstico” ou “diagnostic overshadowing” (Foley-Nicpon; Assouline; Colangelo, 2013; Baum; Schader; Owen, 2017; Alves; Nakano, 2021).

Esse quadro reflete um problema estrutural, a falta de formação docente e de protocolos específicos para identificação e atendimento da DE (Assouline et al., 2020; Nakano, 2021). Como destacam Renzulli e Reis (2014), a ausência de práticas pedagógicas baseadas na diferenciação, no enriquecimento curricular e na adaptação de estratégias impede que as potencialidades cognitivas e criativas desses alunos sejam plenamente desenvolvidas.

No grupo TEA, nenhuma das famílias relatou que as escolas reconhecem formalmente a Dupla Excepcionalidade. A maioria aponta que o foco institucional recai exclusivamente sobre o autismo, enquanto as características relacionadas às altas habilidades são negligenciadas. Isso fica evidente nos relatos, como o de uma mãe que afirma: *“A escola segue provendo o que é previsto na lei, focando nas dificuldades e limitações, mas falta preparo para trabalhar as potencialidades”* (P2 – Grupo TEA). Esse padrão confirma o que apontam Baum, Schader e Hébert (2017), ao descreverem a chamada “inclusão restrita”, na qual o atendimento foca apenas nas dificuldades, sem contemplar os pontos fortes dos alunos.

Por outro lado, no grupo AHSD, embora haja maior incidência de reconhecimento das altas habilidades, esse reconhecimento ainda é parcial. Dos 33 participantes, 54,5% relataram que a escola reconhece exclusivamente a superdotação, sem considerar outros diagnósticos associados. Apenas 21,2% indicaram que há um reconhecimento formal da DE, enquanto 6,1% relataram que nenhuma condição é reconhecida e 18,2% não souberam ou não responderam. Esses dados evidenciam uma compreensão limitada das instituições quanto à complexidade da DE. Como ressaltam Baum, Schader e Hébert (2017) e Nakano (2021), muitas escolas operam dentro de uma lógica fragmentada, que reconhece ora o talento, ora o desafio, sem compreender que ambos podem coexistir, exigindo abordagens pedagógicas integradas.

Os relatos das famílias reforçam essa análise. Um dos responsáveis do grupo AHSD relata: *“Meu filho só começou a ser atendido após nossa insistência, mas a superdotação ainda não tem o mesmo valor que outros diagnósticos no município onde residimos”* (P10 – Grupo AHSD). Outro afirma: *“Na escola estadual, meu filho foi acelerado de série sem qualquer plano de desenvolvimento das habilidades”* (P28 – Grupo AHSD). Essas falas evidenciam que, mesmo quando há

algum reconhecimento das altas habilidades, ele não se traduz, necessariamente, em práticas pedagógicas adequadas, planejadas ou individualizadas.

Quando se observa comparativamente os dois grupos, um padrão claro se destaca: no grupo AHSD, o reconhecimento recai predominantemente sobre o talento, sem considerar desafios associados. Já no grupo TEA, o foco está centrado no transtorno, invisibilizando possíveis talentos. Isso demonstra que o sistema educacional ainda opera dentro de uma lógica de categorização rígida, que não contempla a complexidade da neurodiversidade e da Dupla Excepcionalidade.

A literatura é clara ao apontar que a fragmentação no reconhecimento da Dupla Excepcionalidade (DE) compromete não apenas a trajetória acadêmica, mas também o desenvolvimento socioemocional desses alunos. Baum, Schader e Hébert (2017) descrevem a DE como um fenômeno de “mascaramento mútuo”, no qual os talentos podem ocultar as dificuldades, assim como os desafios podem ofuscar as potencialidades. Quando não há um olhar atento e integrado, esses estudantes ficam privados de uma educação verdadeiramente inclusiva e que potencialize suas capacidades.

Autores como Assouline et al. (2020), Nakano (2021) e Alves e Nakano (2015) reforçam que a identificação e o atendimento da DE dependem diretamente de profissionais capacitados, preparados para compreender perfis singulares e adotar práticas pedagógicas integradas e responsivas. A ausência desse olhar no ambiente escolar, como evidenciam os dados da pesquisa, compromete tanto o processo de ensino e aprendizagem quanto o acesso pleno aos direitos assegurados pela Lei nº 12.764/2012 e pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).

6.18 Distribuição por Ano Escolar e Percepções sobre Atendimento – Grupos AHSD e TEA

A análise da distribuição dos alunos por ano escolar revela informações relevantes sobre os momentos em que as famílias tendem a buscar reconhecimento institucional para as necessidades dos filhos. Tanto no grupo

AHSD quanto no grupo TEA, observa-se uma concentração no Ensino Fundamental, etapa em que as demandas acadêmicas, sociais e comportamentais se tornam mais evidentes, tanto no que diz respeito às potencialidades quanto aos desafios (Quadro 38).

Quadro 39: Distribuição dos Alunos por Ano Escolar

NÍVEL DE ENSINO	GRUPO AHSD (N=33)	GRUPO TEA (N=5)
Educação Infantil	0	1
Ensino Fundamental I	12	2
Ensino Fundamental II	13	1
Ensino Médio	6	1
Não informado	2	0

No grupo de alunos com AHSD, a maioria encontra-se no Ensino Fundamental I (36,4) e no Ensino Fundamental II (39,4%), uma vez que o Curso de Verão atende apenas alunos do Fundamental e Médio. Embora os sinais de superdotação possam emergir desde os primeiros anos, a busca por intervenções especializadas tende a se intensificar à medida que o currículo se torna mais complexo, exigindo maiores adaptações e desafios cognitivos.

Já no grupo com TEA, a concentração é maior no Ensino Fundamental I (70%), com um caso registrado ainda na Educação Infantil. Esse dado reflete uma tendência ao diagnóstico mais precoce do TEA, favorecido tanto pela ampliação dos processos de triagem e avaliação na primeira infância quanto pelas campanhas de conscientização e pela própria legislação vigente que fortalece o direito ao atendimento educacional especializado desde os anos iniciais.

A ausência de uma abordagem integrada impacta diretamente o acesso dos alunos a recursos essenciais, como o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a construção de Planos Educacionais Individualizados (PEI), que foram raramente mencionados pelos responsáveis durante a pesquisa. Tal lacuna reflete as fragilidades estruturais apontadas por autores como Assouline, Nicpon e Whitman (2020) e Nakano (2021), que destacam que a falta de protocolos específicos e o desconhecimento sobre a Dupla Excepcionalidade comprometem a efetividade das políticas de inclusão nas escolas.

6.19 Sugestões para Políticas Públicas e Atendimento Ideal: A Voz das Famílias

6.19.1 Percepções e Demandas do Grupo AHSD

Foi perguntado aos responsáveis o que indicavam como necessário para melhorar não só o reconhecimento como o atendimento adequado de seus tutelados e o que sugerem como possíveis demandas para a criação de Políticas Públicas (Quadro 40).

Quadro 40: Sugestões para Políticas Públicas (Grupo AHSD)

SUGESTÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS (GRUPO AHSD)
Capacitação de professores sobre superdotação e Dupla Excepcionalidade (DE)
Fiscalização do cumprimento das leis, especialmente do Plano Educacional Individualizado (PEI)
Ampliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para altas habilidades
Criação de centros de referência especializados para Altas Habilidades e Dupla Excepcionalidade
Integração efetiva entre os setores de saúde, educação e assistência social
Oferta de oficinas, disciplinas eletivas e espaços que desenvolvam os talentos e potencialidades dos alunos

Para as famílias de crianças com AHSD, mesmo quando há reconhecimento institucional da superdotação, as ações geralmente são limitadas. As respostas mais frequente das escolas tem sido a aceleração de série, adotada como única estratégia, sem considerar o desenvolvimento socioemocional, pedagógico ou a criação de ambientes que estimulem as potencialidades.

Como sintetiza uma participante: *“Minha filha estuda em escola pública, mas não há sala de recursos nem profissional qualificado para dar suporte”* (P22 – Grupo AHSD).

6.19.2 Percepções e Demandas do Grupo TEA

As sugestões desse grupo, embora numericamente menores, são semelhantes às do grupo AHSD (Quadro 41).

Quadro 41: Sugestões para Políticas Públicas (Grupo TEA)

SUGESTÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS (GRUPO TEA)
Capacitação de professores
Criação de salas de recursos
Cumprimento efetivo das leis e do Plano Educacional Individualizado (PEI)
Maior integração entre os serviços, especialmente educação, saúde e assistência social

Entre as famílias de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a queixa predominante é que o atendimento escolar está excessivamente centrado no diagnóstico do autismo, desconsiderando possíveis altas habilidades ou interesses específicos. As adaptações curriculares costumam focar nas limitações, deixando de lado o desenvolvimento dos potenciais. Segundo relata uma mãe: *“O que mais falta nas políticas públicas é um olhar que enxergue o potencial das crianças autistas, e não só as dificuldades”* (P1 – Grupo TEA).

6.19.3 Análise Comparativa: Convergências e Especificidades

Ambos os grupos convergem na percepção de que a escola, e por extensão as políticas públicas, falham tanto na valorização dos talentos quanto no suporte às dificuldades. No grupo AHSD, o problema central é a invisibilidade institucional da superdotação; já no grupo TEA, o desafio é romper com o modelo centrado no déficit, que ignora os potenciais das crianças autistas.

No Quadro 42, as famílias de ambos os grupos apontam a necessidade de políticas públicas mais eficazes e estruturadas. As sugestões, embora com focos distintos, convergem para a necessidade de um suporte mais completo e integrado.

Quadro 42: Sugestões para Políticas Públicas (Grupos AHSD e TEA)

PONTO DE MELHORIA	SUGESTÕES DO GRUPO AHSD	SUGESTÕES DO GRUPO TEA
Formação Profissional	Capacitação de professores sobre superdotação e Dupla Excepcionalidade.	Foco em profissionais que enxerguem o potencial além das dificuldades do autismo.

Estrutura de Atendimento	Criação de centros de referência, salas de recursos específicas para altas habilidades e ampliação do AEE.	Maior acesso a salas de recursos e equipes multidisciplinares que trabalhem as potencialidades.
Práticas Pedagógicas	Oferta de disciplinas eletivas e oficinas que valorizem os talentos; substituição da simples aceleração por um plano de desenvolvimento.	Adaptações curriculares que não foquem apenas nas limitações, mas que estimulem os interesses e talentos especiais.
Fiscalização e Integração	Fiscalização do cumprimento das leis (como o PEI) e integração efetiva entre saúde, educação e assistência social.	Cumprimento das leis e maior integração de serviços para um suporte completo.

Essa análise dialoga diretamente com autores como Kalbfleisch e Iguchi (2021) e Kerr e Sodano (2017), que destacam a necessidade de um modelo de atendimento centrado em três pilares: identificação adequada, intervenção qualificada e suporte socioemocional contínuo. A ausência desses pilares compromete significativamente o desenvolvimento acadêmico, social e emocional, aumentando os riscos de subdesempenho, desmotivação, evasão escolar e sofrimento psíquico.

Adicionalmente, o mascaramento mútuo entre TEA e superdotação, conforme discutem Alves e Nakano (2015), permanece como uma barreira central à identificação e, conseqüentemente, ao acesso aos serviços adequados.

6.19.4 Elementos Essenciais do Atendimento Ideal

Na percepção das famílias, o atendimento ideal não deve estar centrado apenas nas dificuldades, nem ser restrito a respostas isoladas como aceleração ou adaptação curricular simplificada. Esse modelo ideal, defendido por ambos os grupos, deve contemplar.

Nas Tabelas 1 e 2, na visão dos participantes, o atendimento ideal vai além do suporte fragmentado, devendo ser um modelo integrado que enxergue a criança em sua totalidade.

Tabela 1 : Elementos Essenciais para o Atendimento Ideal

ELEMENTO	PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA
Atendimento multidisciplinar integrado	35%
Mapeamento individualizado das potencialidades	30%
Suporte pedagógico e socioemocional	25%
Execução efetiva do PEI, com metas reais e acompanhamento	5%
Ambientes escolares acolhedores, que valorizem a singularidade do aluno	5%

Tabela 2: Atendimento Ideal segundo Pais TEA

ELEMENTO	PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA
Suporte pedagógico e socioemocional	35%
Atendimento multidisciplinar integrado	30%
Mapeamento individualizado das potencialidades	28%
Execução efetiva do PEI, com metas reais e acompanhamento	3.5%
Ambientes escolares acolhedores, que valorizem a singularidade do aluno	3.5%

Nas palavras de uma mãe: *“O atendimento ideal seria aquele que enxergasse as crianças por inteiro, estimulando suas características necessárias, independente do laudo”* (P22 – Grupo AHSD).

6.19.5 Prioridades Familiares no Atendimento

Quando perguntados sobre suas prioridades, as famílias dos dois grupos indicam Saúde e Educação como pilares fundamentais. Embora considerem lazer, cultura e esporte como dimensões complementares, esses também são vistos como cruciais para o desenvolvimento pleno, afetivo e social das crianças.

No quadro 43, ao definir as prioridades para o desenvolvimento de seus filhos, as áreas da Saúde e Educação destacam-se como pilares fundamentais para

ambos os grupos, enquanto lazer, cultura e esporte são vistos como complementos essenciais.

Quadro 43: Prioridades Familiares no Atendimento

ÁREA DE PRIORIDADE	FREQUÊNCIA (GRUPO AHSD)	FREQUÊNCIA (GRUPO TEA)
Saúde	23	7
Educação	22	6
Lazer	15	5
Cultura	13	5
Esporte	10	2
Transporte	4	1

A análise comparativa das percepções das famílias dos grupos AHSD e TEA evidencia que, embora enfrentem desafios distintos, ambos compartilham a experiência de um sistema educacional e de políticas públicas que não reconhecem plenamente as demandas da Dupla Excepcionalidade (DE). No grupo AHSD, predomina a invisibilidade institucional, com respostas restritas à aceleração de série, desconsiderando o desenvolvimento socioemocional e a criação de ambientes que favoreçam as potencialidades. Já no grupo TEA, observa-se um atendimento centrado nas dificuldades, com práticas pedagógicas que ignoram os interesses, talentos e possíveis altas habilidades, reforçando um modelo deficitário e pouco sensível às múltiplas dimensões desses sujeitos.

7. ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL PARA CONSTRUIR O GUIA

Como desdobramento direto das análises realizadas ao longo da pesquisa — tanto do levantamento bibliográfico e legislativo quanto da escuta ativa de pais e cuidadores — foi desenvolvido o produto técnico-científico intitulado Guia para a Formulação de Políticas Públicas: A Perspectiva dos Pais e Cuidadores sobre Pessoas com Dupla Excepcionalidade (AHSD e TEA). O material busca traduzir os achados da pesquisa em diretrizes concretas e aplicáveis para subsidiar ações no

campo da educação e da inclusão. A construção do guia seguiu uma metodologia aplicada, cuidadosamente planejada em cinco etapas complementares disposto no quadro 44 abaixo:

Quadro 44: Etapas da Elaboração do Guia

ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO GUIA	DESCRIÇÃO
Planejamento	A estrutura do guia foi delineada com base nas categorias emergentes da análise dos dados e nas lacunas identificadas nos documentos legais. Foram definidos eixos temáticos que articulassem conceituação, legislação, desafios enfrentados pelas famílias e proposições de políticas públicas.
Seleção e organização dos conteúdos	O conteúdo foi redigido com base nos dados empíricos da pesquisa e nas contribuições teóricas da revisão de literatura. As sugestões e reflexões das famílias foram priorizadas, compondo a base para a formulação de propostas e diretrizes. O texto buscou manter uma linguagem clara, acessível e, ao mesmo tempo, tecnicamente fundamentada.
Estruturação do documento	O guia foi organizado em seções temáticas, com destaque para a parte prática “Como Criar uma Política Pública Municipal para a Dupla Excepcionalidade”, na qual são apresentados os passos essenciais para o reconhecimento legal, diagnóstico da realidade local, elaboração de propostas legislativas, e acompanhamento intersetorial.
Diagramação e identidade visual	O projeto gráfico foi concebido com foco na comunicação clara e acessível. Foram utilizados elementos como boxes informativos, fluxogramas, quadros-síntese e infográficos com cores suaves, que facilitam a leitura e valorizam os principais pontos abordados. A capa traz elementos simbólicos como peças de quebra-cabeça e a figura de uma família, representando a neurodiversidade e o protagonismo parental.
Revisão e validação	O conteúdo foi revisado pelas orientadoras da pesquisa e por especialistas na área da Educação Especial, garantindo a consistência conceitual e a pertinência das propostas. Também foram realizados ajustes linguísticos e gráficos para assegurar coesão textual e fluidez comunicativa.

O Guia apresenta uma proposta que reúne, de forma integrada, dados da pesquisa, relatos de experiências e sugestões práticas voltadas ao reconhecimento e atendimento desse público. Estruturado a partir de investigação acadêmica, do diálogo com famílias e cuidadores e da análise das lacunas presentes nas normativas nacionais, o documento organiza seu conteúdo desde a conceituação e os desafios cotidianos até recomendações objetivas para a construção de políticas públicas intersetoriais.

7.1 Disponibilização gratuita e alcance ampliado

O guia será distribuído gratuitamente e estará disponível nos sites da Escola de Inclusão, do CMPDI (Centro de Memória, Pesquisa e Documentação em Inclusão da UFF) e do portal Educapes. A iniciativa busca garantir o acesso facilitado a gestores, educadores, profissionais de saúde e famílias, promovendo a disseminação do conhecimento e qualificando práticas integradas voltadas à Dupla Excepcionalidade.

A democratização do acesso potencializa o impacto do guia, pois aproxima o conteúdo de estratégias públicas, incentiva a formação continuada e oferece subsídios consistentes para a formulação de políticas nos âmbitos municipal e estadual. Elaborado com base técnica sólida e linguagem acessível, o material apresenta propostas concretas de apoio, acompanhamento e reconhecimento institucional tanto para estudantes quanto para suas famílias.

A disponibilização digital gratuita é, assim, mais do que um recurso de divulgação: trata-se de uma ação estratégica para fortalecer redes de apoio, estimular o debate público e fomentar avanços legislativos e práticos, contribuindo para uma inclusão efetiva e equitativa das pessoas com Dupla Excepcionalidade.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa evidenciou que a Dupla Excepcionalidade (AHSD / TEA) permanece invisível tanto no âmbito das políticas públicas quanto nas práticas institucionais no Brasil. Embora existam marcos legais específicos para AHSD e para o TEA, quando considerados isoladamente, a sobreposição dessas condições ainda carece de reconhecimento formal e sistemático, resultando em lacunas significativas no diagnóstico, no atendimento e no acompanhamento.

No que se refere às AHSD, observa-se que a compreensão institucional permanece restrita, frequentemente limitada a medidas como a aceleração de série, sem considerar as complexidades emocionais, sociais e cognitivas que se intensificam quando associadas ao TEA. Por sua vez, o atendimento às pessoas

com TEA segue predominantemente ancorado em uma abordagem centrada no déficit, negligenciando talentos, interesses e potencialidades cognitivas que podem coexistir com o diagnóstico.

A análise dos dados revelou, ainda, a ausência de protocolos claros para a identificação da DE e a baixa articulação entre os setores de educação, saúde e assistência social, dificultando a construção de respostas integradas. Instrumentos essenciais, como o Plano Educacional Individualizado (PEI), não são implementados, e inexistem centros de referência especializados no atendimento a esse público.

As consequências desse cenário recaem sobre as famílias, sobretudo sobre as mães, que assumem um protagonismo compulsório na busca por diagnóstico, na adaptação escolar e na mediação de direitos. O caso do grupo TEA ilustra essa realidade: embora 43 responsáveis tenham manifestado interesse em participar das rodas de conversa, apenas cinco mães compareceram. Tal fato não representa omissão, mas sim o reflexo de barreiras cotidianas — sobrecarga de cuidados, ausência de rede de apoio e limitações logísticas — que restringem a participação social dessas cuidadoras.

Esse conjunto de evidências reforça a urgência de reconhecer a DE como uma categoria específica nas políticas públicas, acompanhada de ações como:

- formação especializada e continuada de profissionais;
- articulação intersetorial efetiva;
- práticas pedagógicas individualizadas que conciliem potencialidades e necessidades;
- ampliação e fortalecimento das redes de apoio às famílias.

Como resposta prática às lacunas identificadas, este estudo resultou na elaboração do Guia para a Formulação de Políticas Públicas: A Perspectiva dos Pais e Cuidadores sobre Pessoas com Dupla Excepcionalidade (AHSD e TEA). Estruturado a partir de dados empíricos, revisão de literatura e contribuições diretas das famílias participantes, o documento apresenta:

- um mapeamento dos marcos legais e das lacunas existentes;
- diretrizes para identificação e atendimento da DE;
- propostas de articulação entre setores;
- modelos de ações práticas aplicáveis no âmbito municipal e escolar;
- recomendações para a formação de profissionais.

Dessa forma, o Guia configura-se como um produto técnico-científico e instrumento político capaz de subsidiar gestores, legisladores, equipes técnicas e movimentos sociais na construção de ações efetivas para visibilizar e incluir pessoas com DE. Ele traduz, de forma aplicada, a principal contribuição desta dissertação: transformar o conhecimento produzido em orientações concretas que fomentem mudanças estruturais no atendimento, rompendo o ciclo de invisibilidade e exclusão.

Conclui-se que apenas o reconhecimento formal, aliado a ações coordenadas e fundamentadas em evidências, permitirá que crianças e adolescentes com AHSD e TEA sejam plenamente reconhecidos, valorizados e incluídos nos sistemas educacionais, de saúde e de proteção social, assegurando não apenas o cumprimento da legislação, mas a efetivação do direito a uma educação e a uma vida digna e equitativa.

8.1 Perspectivas

A partir dos resultados desta pesquisa, tornam-se evidentes perspectivas e desdobramentos que se configuram como urgentes e necessários, tanto no campo acadêmico quanto na prática social e institucional. No âmbito científico, este trabalho busca contribuir significativamente para o fortalecimento da produção acadêmica sobre a Dupla Excepcionalidade (DE) no Brasil, estimulando a ampliação de estudos que aprofundem temáticas fundamentais, como os processos de identificação, as práticas pedagógicas específicas, a formação docente, o desenvolvimento socioemocional dos alunos com DE e os impactos das políticas públicas na vida desses sujeitos e de suas famílias. Contudo, é preciso destacar que o propósito deste trabalho transcende os limites acadêmicos.

O guia construído a partir desta pesquisa foi pensado como uma ferramenta prática, acessível e orientadora, que visa apoiar gestores públicos, secretarias de educação, conselhos municipais, estaduais e federais, bem como associações, coletivos, grupos familiares e profissionais que atuam diretamente com crianças e jovens com AHSD, TEA e, sobretudo, Dupla Excepcionalidade. A proposta é que este material sirva como referência concreta na formulação e na implementação de

políticas públicas específicas para a DE, especialmente no âmbito municipal e estadual, contribuindo diretamente para a construção de normativas que reconheçam oficialmente esse público como parte integrante e legítima do público alvo da Educação Especial.

No campo educacional, o guia também se configura como um suporte para escolas, redes de ensino e centros de atendimento, oferecendo diretrizes que auxiliam na construção de práticas pedagógicas mais inclusivas, sensíveis às singularidades e efetivas no atendimento às múltiplas dimensões que caracterizam os sujeitos com Dupla Excepcionalidade. Além de fornecer subsídios técnicos e teóricos, ele se consolida como um material de fortalecimento e empoderamento para as famílias, que frequentemente enfrentam jornadas solitárias na busca por direitos, por atendimento adequado e pela superação das inúmeras barreiras impostas tanto no ambiente escolar quanto na sociedade.

A partir desse entendimento, este trabalho também se propõe a orientar sobre os passos necessários para a construção de uma política pública efetiva e de uma lei municipal voltada à Dupla Excepcionalidade. A formulação de uma normativa específica começa, primeiramente, pelo reconhecimento formal da DE no âmbito do município, considerando-a como parte do público-alvo da Educação Especial, conforme estabelecem documentos como a Resolução CNE/CEB nº 4/2009 e a Lei Brasileira de Inclusão. Este reconhecimento deve ser acompanhado de um diagnóstico aprofundado da realidade local, que permita mapear quantas crianças e jovens possuem diagnóstico de AHSD, TEA ou DE, bem como identificar quais são as demandas não atendidas, os recursos existentes, as lacunas nas redes de ensino e as limitações nos serviços de saúde e assistência social.

A partir desse diagnóstico, a construção da política pública deve estar fundamentada em diretrizes que garantam o reconhecimento integral dos sujeitos, assegurando atendimento educacional especializado, formação continuada dos profissionais, criação de centros de referência, articulação intersetorial entre os setores de educação, saúde e assistência social, além da implementação de práticas pedagógicas alinhadas às singularidades desse público. Nesse processo, a elaboração de uma minuta de Projeto de Lei torna-se etapa fundamental. Tal documento precisa apresentar uma justificativa robusta, baseada na legislação vigente e na realidade local, além de estabelecer os direitos assegurados, às estruturas necessárias, os deveres do município, a previsão orçamentária e os

mecanismos de controle social, fiscalização e acompanhamento da efetivação da lei.

É igualmente essencial que esse processo seja construído de forma coletiva, envolvendo audiências públicas, rodas de conversa com famílias, encontros com gestores, vereadores, profissionais da educação e dos conselhos municipais. A participação ativa da sociedade civil fortalece o debate, dá legitimidade às propostas e amplia as chances de aprovação da lei no legislativo municipal. No entanto, a promulgação da lei representa apenas uma etapa. Sua implementação requer compromisso político, alocação de recursos financeiros, definição de metas, cronogramas e indicadores, além do acompanhamento contínuo por parte dos conselhos de educação, dos conselhos de direitos da pessoa com deficiência e da própria comunidade.

Diante desse cenário, este trabalho reafirma seu compromisso ético, social e político com a defesa dos direitos das pessoas com Dupla Excepcionalidade. Seu maior propósito é contribuir para romper o ciclo de invisibilidade que ainda marca profundamente a trajetória de tantas crianças, jovens e suas famílias, ampliando as possibilidades de desenvolvimento pleno, de inclusão efetiva e de reconhecimento social desse público. A expectativa é que este guia, aliado à proposta de minuta de Projeto de Lei aqui apresentada, inspire gestores, pesquisadores, educadores, profissionais da saúde, legisladores e famílias a atuarem conjuntamente na construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, na qual a Dupla Excepcionalidade não seja mais ignorada, mas compreendida, valorizada e atendida em toda a sua complexidade.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, E. M. L. S.; FLEITH, D. S. **Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação Superior**. Avaliação Psicológica, 2010.

ALENCAR, E. M. L. S.; FLEITH, D. S. **Superdotação: Mitos e Verdades**. São Paulo: EPU, 2001.

ALENCAR, E. M. L. S.; FLEITH, D. S.; GUIMARÃES, S. E. C. **Criatividade, superdotação e educação para talentos**. São Paulo: Vetor, 2012.

ALVES, R. J. R.; NAKANO, T. C. **A dupla-excepcionalidade: relações entre altas habilidades/superdotação com a síndrome de Asperger, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtornos de aprendizagem.** Revista Psicopedagogia, São Paulo, v. 32, n. 99, p. 346-360, 2015.

AMARAL, M. I. R. **Transtorno do Espectro Autista e Educação Inclusiva.** Petrópolis: Vozes, 2017.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION – APA. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5.** 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ASSOULINE, S. G.; FOLEY-NICPON, M.; WHITEMAN, C. Cognitive and psychosocial characteristics of gifted students with written language disability. **Gifted Child Quarterly**, v. 54, n. 2, p. 102-115, 2010.

ASSOULINE, S. G.; FOLEY NICPON, M.; HUBER, J. The impact of a strength-based model of twice-exceptionality: Parent perspectives. **Gifted Child Quarterly**, v. 64, n. 3, p. 213-231, 2020.

ASSOULINE, S. G. et al. Longitudinal Outcomes of an Instructional Model for Twice-Exceptional Students. **Gifted Child Quarterly**, 66(3), 185-200, 2022.

BASSO, E. et al. Identificação de Estudantes com Altas Habilidades/Superdotação no Ensino Superior. **Revista Brasileira De Educação Especial**, 26(3), 453–464, 2020.

BASSO, T. O.; SOUSA, S. S.; RIBEIRO, M. E. B. B. Políticas públicas e escolarização do aluno com altas habilidades/superdotação. **Revista Educação Especial**, Santa Maria, v. 33, e34, p. 1–20, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/1984686X43488>. Acesso em: 29 jun. 2025.

BAUM, S. M.; OWEN, S. V. **To be gifted and learning disabled:** Strategies for helping bright students with LD, ADHD, and more. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press, 2004.

BAUM, S. M.; SCHADER, R. M.; HÉBERT, T. P. Influence of the Twice-Exceptional Child on the Family. In: KAUFMAN, S. B. (Ed.). **Twice Exceptional: Supporting and Educating Bright and Creative Students with Learning Disabilities.** New York: Oxford University Press, 2017a. p. 245-260.

BAUM, S. M., SCHADER, R. M.; HÉBERT, T. P. Through a Different Lens: Reflecting on a Strengths-Based, Talent-Focused Approach for Twice-Exceptional Learners. **Gifted Child Quarterly**, 61(3), 243–249, 2017b.

BAUM, S.; SCHADER, R.; OWEN, S. V. **To Be Gifted and Learning Disabled:** Strength-Based Strategies for Helping Twice-Exceptional Students With LD, ADHD, ASD, and more. 3. ed. Prufrock Press, 2017c.

BAUM, S. M.; SCHADER, R. M.; OWEN, S. V. **Ser superdotado e ter dificuldades de aprendizagem:** estratégias baseadas em pontos fortes para

ajudar alunos duplamente excepcionais com DA, TDAH, TEA e outros (3ª ed.). Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781003239147>

BEYER, H. **Educação inclusiva**: uma via para a construção da cidadania. Porto Alegre: Mediação, 2006.

Bosa, Califórnia (2006). **Autismo: disciplinas psicoeducacionais**. Revista Brasileira de Psiquiatria, 28(Supl I), S47-S53.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 5 jan. 2025.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. MEC/SEESP, 2008.

BRASIL. **Resolução nº 4**, de 2 de outubro de 2009. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.

BRASIL. **Lei nº 12.764**, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

BRASIL. **Lei nº 13.146**, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 29 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 86 p. Pessoa com Deficiência). **Lei nº 13.146**, de 6 de julho de 2015.

BRONFENBRENNER, U. **A ecologia do desenvolvimento humano**: experimentos naturais e planejados. Porto Alegre: Artmed, 1996.

CARDOSO, F. S.; SOUZA, D. L. **Superdotação e Políticas Públicas: Avanços e Desafios na Educação Brasileira**. Revista Educação Especial, 2021.

CONDURÚ, M. T.; PEREIRA, J. A. R. **Elaboração de trabalhos acadêmicos: normas, critérios e procedimentos**. 4. ed. Belém: EDUFPA, 2010.

FLEITH, D. S.; VILARINHO-REZENDE, L. C. Altas habilidades/superdotação e deficiência: desafios e possibilidades no atendimento educacional especializado. **Revista Educação Especial**, v. 35, p. 1-20, 2022.

FOLEY-NICPON, M. et al. **The Gfted/LD Student: A Case of Mistaken Identity**. In: KAY, K. (Ed.). *Legal Issues in Gifted Education*. Tuscon, AZ: NAGC-Council of State Directors of Programs for the Gifted & The University of Arizona, 2011. p. 1-13.

FOLEY-NICPON, M.; ASSOULINE, S. G.; COLANGELO, N. Twice-Exceptional Learners: Who Needs to Know What? **Gifted Child Quarterly**, v. 57, n. 3, p. 169-180, 2013.

GAGNÉ, F. Modelo diferenciado de superdotación y talento in Benito, Y. y Alonso, J.A. *Superdotados, Talentos, Creativos y Dessarrolo Emocional*, Ecuador, Loja : UTPL, 2004.

GARDNER, H. **Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice**, 2006.

GARDNER, H. **Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences**, 1983.

GARDNER, H. **Inteligências Múltiplas: A teoria na prática**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos e pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas; 2008.

GOMES, P. T. M. et al. Autism in Brazil: a systematic review of family challenges and coping strategies. **Jornal De Pediatria**, 91(2), 111–121, 2015.

GUIMARÃES, S. E. C.; ALENCAR, E. M. L. S. Criatividade e superdotação: Contribuições para a educação. **Revista Brasileira de Educação**, v. 17, n. 50, p. 81-96, 2012.

GUIMARÃES, T. G.; OGEDA, C. M. M. A dupla excepcionalidade e a formação de professores: da invisibilidade à ação. **Revista Educação Especial**, v. 34, p. 1-22, 2021.

HIDALGO, D. L. **Associação entre clima escolar e sintomas de saúde mental em adolescentes: um estudo em escolas públicas brasileiras**. 2020. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

KAWA, H. M. et al. Cuidado parental e seus impactos na vida de mães de crianças com transtorno do espectro autista. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 10, p. 3363–3372, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320182310.21382016>. Acesso em: 29 jun. 2025.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?** Moderna, 2003.

MARTINS, M.; SANTOS, J.; LIMA, J.; **O impacto do diagnóstico do tratamento do espectro autista na vida familiar**. *Revista Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*. v.11, n.16, 2022.

MASSUDA, E.; RANGNI, R. R. **A negação da excepcionalidade nas políticas públicas de educação especial: implicações para a formação docente.** Revista Educação Especial, Santa Maria, v. 30, n. 60, p. 741–756, set./dez. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/27156>. Acesso em: 29 jun. 2025.

MEDEIROS, L. M.; SILVA, A. A.; FILGUEIRAS, K. F. Transtorno da Ansiedade Generalizada: uma análise no contexto das altas habilidades/superdotação. **Conecte-se! revista interdisciplinar de extensão**, v. 5 n. 9, 2021.

MENDONÇA, P. V. C.; FLEITH, D. S. Altas habilidades/superdotação e transtorno do espectro autista: interfaces e desafios. In: FLEITH, Denise de Souza (Org.). **Altas habilidades/superdotação: temas contemporâneos.** Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2021. p. 125-144.

MINATEL, M.; MASTSUKURA, T. Famílias de crianças e adolescentes com autismo: cotidiano e realidade de cuidados em diferentes etapas do desenvolvimento. **Revista de Terapia Ocupacional Da Universidade de São Paulo**, v.25, n.2, p. 126-134, 2014.

MORAES, R.; FERNANDES, C. O papel da família na identificação e desenvolvimento de crianças com altas habilidades/superdotação. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 25, n. 3, p. 345-360, 2019.

NAKANO, T. C. **Altas habilidades/superdotação: criatividade e desenvolvimento de potenciais.** Petrópolis: Vozes, 2018.

NAKANO, T. C. Altas Habilidades/Superdotação e a dupla excepcionalidade. In: RONDINI, C. A.; REIS, V. L. (Org.). **Altas Habilidades Superdotação: Instrumentais para identificação e atendimento do estudante dentro e fora da sala de aula comum.** Curitiba: CRV, 2021a.

NAKANO, T. C. Dupla excepcionalidade: compreensões iniciais sobre o conceito. In. ROAMA-ALVES, R. J.; NAKANO, T. C. (Org.) **Dupla excepcionalidade: altas habilidades/superdotação nos transtornos neuropsiquiátricos e deficiências.** São Paulo: Vetor Editora, 2021b.

NEIHART, M. Gifted and Talented Students with Asperger's Syndrome. **Gifted Child Quarterly**, v. 52, n. 1, p. 38-44, 2008.

NEIHART, M.; PFEIFFER, S. I.; CROSS, T. L. **The Social and Emotional Development of Gifted Children: What Do We Know?** 2. ed. Waco, TX: Prufrock Press, 2015.

NOGUEIRA, Sonia Regina Alves et al. **Freire, Renzulli e as Oficinas Interativas para Alunos Superdotados.** Educação em Foco, 2020.

OJS-UEL. **História da Educação Especial brasileira: 1854-1956.** OJS UEL, 2023.

PÉREZ, M. S. S.; FREITAS, S. N. Percurso de identificação e desenvolvimento de crianças superdotadas: uma análise bioecológica. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 20, n. 2, p. 251–259, 2016.

PÉREZ, S. G. P. B.; FREITAS, S. N. **Políticas públicas para as Altas Habilidades/Superdotação**: incluir ainda é preciso. 2014.

PÉREZ, S. G. P. B.; FREITAS, S. N. **Manual de identificação de Altas Habilidades/Superdotação**. Guarapuava: Apprehendere, 2016.

PÉREZ, L. L.; FREITAS, S. N. **Superdotação e Altas Habilidades: Desafios e Possibilidades na Escola Inclusiva**. Autores Associados, 2019.

PLETSCH, M. D. **Políticas Públicas e Inclusão: Uma Análise Crítica**. Revista Brasileira de Educação Especial, 2019.

PFEIFFER, S. I. **Serving the gifted**: Evidence-based clinical and psychoeducational practice. New York, NY: Routledge, 2013.

PFEIFFER, S. I. **Essentials of Gifted Assessment**. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015a.

PFEIFFER, S. I. Gifted students with a coexisting disability: The twice exceptional. **Estudos de Psicologia** (Campinas), v. 32, n. 4, pp. 717- 727, 2015b.

PFEIFFER, S. I. **Identifying and Assessing Gifted Students With Autism Spectrum Disorder**. In Handbook of Giftedness and Talent Development, p. 587-602. Springer, 2018.

PONDE, M. P.; GOMIDE, P. I. O desenvolvimento humano sob a perspectiva bioecológica: contribuições para a compreensão da infância e da adolescência. In: CUNHA, G. R. et al. (org.). **Psicologia do desenvolvimento**: desafios e possibilidades. Salvador: EDUFBA, 2017. p. 71-96.

REIS, S. M.; BAUM, S.; BURKE, Ed. An Operational Definition of Twice-Exceptional Learners: Implications and Applications. **Gifted Child Quarterly**, v. 58, n. 3, p. 217-230, 2014.

RENZULLI, J. S.; REIS, S. M. **The Schoolwide Enrichment Model**: A Comprehensive Plan for Educational Excellence. Mansfield: Creative Learning Press, 1985.

RENZULLI, J. S. **The Three-Ring Conception of Giftedness**: A Developmental Model for Promoting Creative Productivity. Storrs: University of Connecticut, 1986.

RENZULLI, J. S. **The three-ring conception of giftedness: A developmental model for promoting creative productivity**. In: STERNBERG, R. J. (ed.). Conceptions of Giftedness. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 246-279.

RENZULLI, J. S.; REIS, S. M. **The Schoolwide Enrichment Model**: A

Comprehensive Plan for Educational Excellence. 3. ed. Mansfield, CT: Creative Learning Press, 2014.

RENZULLI, J. S. **The Three-Ring Conception of Giftedness**. In: Sternberg, R. (Ed.). *Conceptions of Giftedness*, 2004.

RONKSLEY-PAVIA, M. O reconhecimento da dupla excepcionalidade: a influência da cultura e do contexto. In: PÉREZ, Susana M. R. (Org.). **Dupla excepcionalidade: altas habilidades/superdotação e deficiência**. Curitiba: Juruá, 2015. p. 99–124.

RONKSLEY-PAVIA, M. A model of twice-exceptionality: explaining and defining the apparent paradoxical combination of disability and giftedness in childhood. **Journal for the Education of the Gifted**, v. 38, n. 3, p. 318–340, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0162353215592508>. Acesso em: 29 jun. 2025.

ROSA, E. M.; TUDGE, J. The Urie Bronfenbrenner's bioecological theory of human development. **Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano**, São Paulo, v. 23, n. 2, p. 252-261, 2013.

SAAD, E. et al. Desafios cotidianos de mães de crianças com transtorno do espectro autista: demandas, sobrecarga e resiliência. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 30, n. 1, 2024.

SCHMIDT, C. et al. A importância dos níveis de suporte no diagnóstico e na intervenção no Transtorno do Espectro Autista. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas**, v. 16, n. 2, p. 1-12, 2020.

SCHMIDT, C.; BOSA, C. A. Intervenções Baseadas em Evidências no TEA. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas**, 2019.

SILVA, M. F. et al. Inclusão de pessoas com autismo no ensino superior. In: MONTENEGRO, Rúbia Kátia Azevedo (Org.). **Educação e linguagens: ensino, formação e discursos**. Campina Grande: Editora Amplla, 2022. p. 381-394.

SILVA, R. B. Autismo e o direito: uma análise da (des)proteção jurídica aos indivíduos portadores do Transtorno do Espectro Autista. **Revista Científica Multidisciplinar Recima** 21, v. 5, n. 11, 2024.

SILVERMAN, L. K. **Giftedness 101**. New York: Springer Publishing Company, 2012.

SOUTO, F. C. R.; DELOU, C. M. Altas habilidades/superdotação: uma análise da distribuição dos estudantes identificados no estado do Rio de Janeiro. **Revista Educação Especial**, Santa Maria, v. 35, e15, p. 1–20, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/1984686X67009>. Acesso em: 29 jun. 2025.

SPROVIERI, M. H.; ASSUMPÇÃO JUNIOR, F. B. A dinâmica familiar em famílias de crianças autistas. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 23, n. 1, p. 18-23, 2001.

UNESCO. **Declaração Mundial sobre Educação para Todos**: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. 1990.

UNESCO & MEC-Espanha. **Declaração de Salamanca e Linha de Ação**: sobre necessidades educacionais especiais. Brasília: CORDE, 1994.

VIEIRA, N. J. W.; SIMON, K. W. **Diferenças e semelhanças na dupla necessidade educacional especial**: altas habilidades/superdotação x Síndrome de Asperger. *Revista Educação Especial*, Santa Maria, v. 25, n. 43, p. 319-332, maio/ago. 2012.

VIEIRA, C.; FLEITH, D. Altas Habilidades/Superdotação: Desafios e Caminhos para a Educação Inclusiva. **Revista Educação Especial**, 2019.

Vilanova, J. R. S., Carneiro, C. T., Rocha, K. N. de S., Brito, M. de A., Rocha, R. C., Costa, A. de C., & Bezerra, M. A. R. (2022). Burden of mothers of children diagnosed with autism spectrum disorder: mixed method study. **Revista Gaúcha De Enfermagem**, Ed 43. <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2022.20210077>. Acesso em: 06 jul. 2025.

VILARINHO-REZENDE, D.; FLEITH, D. S.; ALENCAR, E. M. L. S. Desafios no diagnóstico de dupla excepcionalidade: um estudo de caso. **Revista Psicologia**, v. 34, n. 1, p. 61-84, 2016.

VIRGOLIM, A. M. C. **Superdotação e Criatividade**: Enriquecimento para além do potencial. Campinas: Papirus, 2007.

VIRGOLIM, A. M. C. As vulnerabilidades das altas habilidades e superdotação: questões sociocognitivas e afetivas. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 37, e81543, 2021.

VISCA, J. **Clínica Psicopedagógica**. Epistemologia Convergente. Porto Alegre, Artes Médicas, 1987.

WEBB, J. T. et al. **A parent's guide to gifted children**. Scottsdale, AZ: Great Potential Press, 2016.

ZANATTA, É.; PEREIRA, P. H. O ônus do cuidado: implicações de gênero e classe social. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 777–794, set./dez. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-026X2014000300011>. Acesso em: 29 jun. 2025.

10. APÊNDICES E ANEXOS

10.1 Apêndices

10.1.1 Apêndice I - Termo de Anuência

Declaramos que o projeto registrado na Pró Reitoria de Extensão da UFF "Escola de Inclusão" tem interesse em participar do projeto: ENTENDENDO O ALUNO COM DUPLA EXCEPCIONALIDADE (AM/SD e TEA) A PARTIR DO OLHAR DA FAMÍLIA, proposto pela pesquisadora: DANIELLE DE MORAES GÓIS DINIZ, autorizando o contato com os responsáveis de crianças com dupla excepcionalidade e que participam de atividades desenvolvidas pela Escola de Inclusão.

Declaramos ainda, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 466/2012. A coordenação do projeto Escola de Inclusão está ciente de suas coresponsabilidades como co-participante e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos participantes do projeto de pesquisa nela recrutados dispondo da infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.

Esta autorização está condicionada à aprovação final da proposta pelo (s) Comitê (s) de Ética em Pesquisa responsável (is) por sua avaliação.

Niterói, 26 de setembro de 2024



Profa. Dra. Tathiana Prado Dawes
SIAPE:2255851

Vice-Coordenadora do Projeto Escola de Inclusão

Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá
Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, Bloco P – Térreo – São Domingos, Niterói-RJ
CEP: 24210201
Email: escoladeinclusaouff@gmail.com

10.1.2 Apêndice II - Termo de compromisso Pesquisador



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE BIOLOGIA
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM DIVERSIDADE E
INCLUSÃO



TERMO COMPROMISSO ÉTICO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Eu, Danielle de Moraes Góis Diniz, pesquisador responsável pelo Projeto de Pesquisa intitulado “ Entendendo a Dupla excepcionalidade a partir olhar da Família”, junto aos demais pesquisadores Fernanda Serpa, declaramos ter total conhecimento do conteúdo do referido projeto e nos comprometemos a cumprir todos os Termos das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, especialmente a Resolução 466/12 e complementares, bem como todo ordenamento jurídico referente ao assunto.

Comprometemo-nos a tornar público os resultados desta pesquisa, quer sejam eles favoráveis ou não. Entregaremos ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, através de notificações na Plataforma Brasil, os relatórios parciais, de seis em seis meses, e o relatório final da pesquisa e produção científica.

Comprometemo-nos a manter a confidencialidade e sigilo dos dados obtidos, bem como a privacidade de seus conteúdos, mantendo a integridade moral e a privacidade dos participantes da pesquisa, garantindo o sigilo relativo às propriedades intelectuais e patentes industriais; garantia de que os benefícios resultantes do projeto retornem aos participantes da pesquisa, seja em termos de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa. Não repassaremos os dados coletados em sua íntegra, ou parte dele, a pessoas não envolvidas na equipe da pesquisa. Ao publicar os resultados da pesquisa, manteremos o anonimato dos participantes.

Também nos comprometemos com a utilização das informações obtidas nesta pesquisa apenas para o cumprimento dos objetivos científicos previstos no projeto aprovado por este CEP. Os dados coletados não serão utilizados para outras pesquisas, além disso, serão guardados de forma sigilosa, segura, confidencial e privada, por cinco anos, e depois serão destruídos, por via adequada.

Niterói, 07 de março de 2024.

Danielle de Moraes Góis Diniz

Nome e Assinatura do pesquisador responsável.

10.1.3 Apêndice III - TCLE - Pais e Responsáveis Termo de Consentimento Livre e Esclarecido



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE BIOLOGIA
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM DIVERSIDADE E
INCLUSÃO



TCLE - PAIS E RESPONSÁVEIS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: Entendendo os alunos com Dupla excepcionalidade (AHSD e TEA) a partir do olhar da família.

Pesquisadora Responsável: Danielle de Moraes Góis Diniz

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal

Fluminense Telefones para contato da Pesquisadora: (21) 96467-6776

Outras formas de contato com a pesquisadora: dmgdiniz@id.uff.br

Nome do (a) Participante: _____

O Sr. (a), está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Entendendo os alunos com Dupla excepcionalidade (AH ou SD e TEA) a partir do olhar da família”, de responsabilidade da pesquisadora Danielle de Moraes Góis Diniz.

O projeto de pesquisa tem como objetivo geral analisar a percepção e o conhecimento que os pais possuem sobre o diagnóstico dos filhos com dupla excepcionalidade, bem como investigar qualitativamente e quantitativamente o potencial de informações necessárias para o atendimento adequado ao reconhecimento desse sujeito na sua integralidade.

A sua participação, se consentida, ocorrerá da seguinte forma: inicialmente, irá responder a um questionário, que será enviado por e-mail, e depois será convidado a participar de uma roda de conversa com, no máximo, duas horas de duração, na Universidade Federal Fluminense. Durante a realização da oficina nós iremos fazer registro por foto e/ou vídeo. O questionário, após o preenchimento, somente será acessado pela equipe de pesquisa. A participação é voluntária. As informações obtidas serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre a sua participação. Todo material da pesquisa será arquivado aos cuidados da pesquisadora responsável pelo projeto.

Pode haver alguns riscos relacionados à sua participação neste projeto. O primeiro é o de sentir algum desconforto, que pode ser causado por algumas perguntas do questionário, as quais responderá se quiser, ou por alguma das atividades realizadas durante a roda de conversa. Para diminuir esses riscos, proporcionamos um ambiente descontraído e aberto ao diálogo e críticas, respeitando a todo momento suas opiniões. Há ainda o risco de quebra de sigilo das informações coletadas. No entanto, a equipe de pesquisa se compromete a manter o sigilo, anonimato e confiabilidade dos dados coletados. O Senhor (a) receberá um código formado por letras e números, que será escrito neste documento (TCLE) e utilizaremos apenas este código para identificá-lo (a) no questionário e na pesquisa. As gravações de vídeo das atividades serão salvas em um HD externo de forma codificada e não serão colocadas na internet. Este documento assinado (TCLE), juntamente com o questionário preenchido, ficarão sob responsabilidade da pesquisadora responsável, armazenados em local trancado.

Ao participar desta pesquisa, o Senhor (a) não está desistindo de nenhum direito. Esteja ciente de que tem total liberdade para interromper a participação na pesquisa a qualquer momento, sem punição ou qualquer tipo de prejuízo. Em caso de danos decorrentes da

pesquisa, têm direito à indenização, conforme Resolução 466 de 2012, item IV.3.h. Não há nenhum benefício direto e imediato pela participação no estudo. Indiretamente, terá a oportunidade de contribuir na geração de conhecimento e divulgação científica no tema da Dupla Excepcionalidade (AH ou SD e TEA). Está prevista a divulgação dos resultados em publicação de artigos.

No caso de dúvidas, deve-se entrar em contato com a responsável pela pesquisa no telefone e e-mail que se encontram no início desse documento ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFF nos contatos listados abaixo. Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e buscando garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Este documento será impresso em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a outra com você. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade E-mail: etica.ret@id.uff.br Tel./fax: (21) 26299189

Eu, _____, responsável legal por _____, declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, no projeto de pesquisa acima descrito.

Niterói, _____ de _____ de _____

(nome e assinatura do participante ou responsável legal)

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)

(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso)

(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso)

10.1.4 Apêndice IV - Termo de Cessão do Uso de Imagem (TCU)



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE BIOLOGIA
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM DIVERSIDADE E
INCLUSÃO



TERMO DE CESSÃO DO USO DE IMAGEM (TCUI)

Nome do participante:

Número de identidade do participante:

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto **“ENTENDENDO O ALUNO COM DUPLA EXCEPCIONALIDADE (AH ou SD e TEA) A PARTIR DO OLHAR DA FAMÍLIA”** sob a responsabilidade da pesquisadora Danielle de Moraes Góis Diniz, para gravação e fotos das Rodas de Conversas que tem como objetivo de pesquisa analisar a percepção e o conhecimento que os pais possuem sobre o diagnóstico dos filhos com dupla excepcionalidade (AH ou SD e TELA), bem como investigar qualitativamente e quantitativamente o potencial de informações necessárias para o atendimento adequado ao reconhecimento desse sujeito na sua integralidade. A pesquisadora pode ser contatada pelo telefone: (21)964676776.

Nenhuma informação que permita a sua identificação individual será liberada sem sua prévia autorização. Sua identidade será preservada e no caso de exposição visual de sua face será usado uma tarja preta, caso seja necessário o uso da imagem integral do participante, fica esclarecido neste termo que a participação nesta pesquisa é totalmente voluntária, e o(a) Sr.(a) não será penalizado(a) de nenhuma forma caso escolha não participar ou retirar seu consentimento durante o seu andamento da pesquisa. As imagens produzidas a partir da sua participação serão divulgadas artigo científico, pôster de congresso, livro, entre outros. Não haverá ganho financeiro com estas imagens.

Em qualquer momento o(a) Sr.(a) pode questionar os pesquisadores sobre qualquer dúvida.

Caso aceite participar, este Termo de Cessão do Uso de Imagem, deverá ser assinado em duas vias, onde uma via ficará o(a) Sr.(a), e a outra com a pesquisadora responsável.

Niterói, __de _____de _____

nome e assinatura do participante

10.1.5 Apêndice V - Questionário I da pesquisa



Universidade Federal Fluminense
Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão



Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada **Entendendo a dupla Excepcionalidade (Altas Habilidades ou Superdotação e Transtorno do Espectro Autista) a partir do olhar dos responsáveis**, conduzida pela mestrandia Danielle de Moraes Góis Diniz. Este estudo tem por objetivo geral analisar a percepção e o conhecimento que os pais possuem sobre o diagnóstico dos filhos com dupla excepcionalidade, também, investigar, qualitativamente e quantitativamente, o potencial de informações necessárias para o atendimento adequado, buscando o reconhecimento desse sujeito na sua integralidade.

Mesmo que não tenha um (a) filho (a) com dupla excepcionalidade, se ele tiver Superdotação ou Autismo, você pode participar da pesquisa.

Contatos do pesquisador responsável: Danielle de Moraes Góis Diniz – UFF. E-mail: dmgdiniz@id.uff.br Telefone: (21) 964676776.

Orientadoras: Fernanda Serpa e Viviane Lione

1-Você concorda em participar deste estudo?

() Sim () Não

2-E-mail : _____

3-Seu (sua) filho (a) tem:

() Superdotação () Dupla Excepcionalidade (Superdotação + TEA) ()
Dupla Excepcionalidade (Superdotação + outros) () Autismo

4- Você reside em qual município? _____

5- Sua idade (SOMENTE NÚMERO)? _____

6- Qual seu estado civil?

() Solteiro (a) () Casado/união estável/vive com companheiro (a) ()
Divorciado (a) () Possui companheiro (a) fixo (a) () Viúvo (a)

7- Você mora com o pai/ mãe do seu (sua) filho (a) que tem Superdotação ou Dupla Excepcionalidade ou autismo?

() Sim () Não

8- Quantas pessoas, incluindo você, residem na mesma casa? (só números)

9- Qual seu grau de escolaridade?

() Nenhum () Ensino Fundamental () Ensino Médio () Ensino Superior () Especialização () Doutorado

10- Qual sua ocupação atual? _____

11- Quantos filhos possuem diagnóstico de Dupla excepcionalidade (superdotação e TEA)?

Apenas Superdotação? _____ Dupla Excepcionalidade (superdotação e outros)? _____

12- Sabe o que significa Dupla Excepcionalidade?

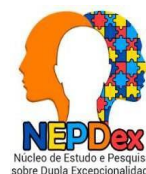
() Sim () Não

13- Em caso positivo, o que entende por Dupla Excepcionalidade?

10.1.6. Apêndice VI - Questionário II da pesquisa



Universidade Federal Fluminense
Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão



Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada **Entendendo a dupla Excepcionalidade (Altas Habilidades ou Superdotação e Transtorno do Espectro Autista) a partir do olhar dos responsáveis**, conduzida pela mestrandia Danielle de Moraes Góis Diniz. Este estudo tem por objetivo geral analisar a percepção e o conhecimento que os pais possuem sobre o diagnóstico dos filhos com dupla excepcionalidade, também, investigar, qualitativamente e quantitativamente, o potencial de informações necessárias para o atendimento adequado, buscando o reconhecimento desse sujeito na sua integralidade.

Mesmo que não tenha um (a) filho (a) com dupla excepcionalidade, se ele tiver Superdotação ou Autismo, você pode participar da pesquisa.

Contatos do pesquisador responsável: Danielle de Moraes Góis Diniz – UFF. E-mail: dmgdiniz@id.uff.br Telefone: (21) 964676776.

Orientadoras: Fernanda Serpa e Viviane Lione

1. **Você concorda em participar deste estudo?** () Sim () Não

2. **E-mail:** _____

3. **Depois de ouvir a palestra, você mantém a sua resposta sobre Dupla excepcionalidade?** () Sim () Não

4. **Se não, pode escrever em poucas palavras o que entendeu?**

5. **Com quantos anos seu (sua) filho (a) teve diagnóstico de (somente números) Superdotação?** _____ **TEA?** _____
Dupla Excepcionalidade? _____ **Outros** _____

6. **A idade atual do (s) seu/sua (s) filho (a) (s) que tem alguma das condições citadas anteriormente? (Somente Número, em anos)**

7. **Quem sugeriu uma avaliação ao filho?**

() mãe/pai () professor
() médico () terapeutas () outros

8. Qual a condição do seu (sua) filho (a) que prevaleceu na hora da indicação? ()
Superdotação () Autismo () Ambas () outros

9. Qual o nível de suporte do seu (a) filho (a)? Caso tenha mais de um (a) filho (a) com autismo e com nível de suporte diferente, selecione, as opções correspondentes. (MARQUE TODAS AS OPÇÕES QUE SE APLICAM).

() Nível de suporte 1 () Nível de suporte 2 () Nível de suporte 3
() Não sabe informar

10. Qual inteligência seu filho apresenta acima da média? (MARQUE TODAS AS OPÇÕES QUE SE APLICAM)

() Inteligência lógico-matemática
() Inteligência linguística
() Inteligência naturalista
() Inteligência interpessoal
() Inteligência intrapessoal
() Inteligência espacial
() Inteligência corporal-cinestésica
() Inteligência musical

11. Na Dupla Excepcionalidade do seu (sua) filho (a), o que você mais evidencia? (apenas para responsáveis cujo (a) filho (a) tenha Dupla Excepcionalidade) () Altas Habilidades ou Superdotação () Transtorno do Espectro Autista

12. Você possui ajuda no cuidado do (a) seu (sua) filho (a)? () Sim () Não

10. Quem é a principal pessoa que lhe ajuda no cuidado do (a) seu (sua) filho (a)?

11. Seu (sua) filho (a) precisa de professor mediador? () Sim () Não

12. Possui plano de saúde? () Sim () Não

13. Seu (sua) filho (a) frequenta o AEE (Atendimento Educacional Especializado)?
() Sim () Não

14. Seu (sua) filho (a) é acompanhado por alguma equipe multidisciplinar? ()
Sim () Não

15. Seu (sua) filho (a) faz terapias? () Sim () Não

16. Quais terapias seu (sua) filho (a) realiza?

() Psicologia () Fonoaudiologia () Terapia Ocupacional () Fisioterapia
() Psicopedagogia () Neuropedagogia () Psicomotricidade () Musicoterapia () Outro:

17. Seu (sua) filho (a) estuda em: () Escola Pública () Escola Particular () Outros

18. Em qual ano escolar seu (sua) filho (a) está matriculado?

19. A escola reconhece as necessidades específicas do(a) seu (sua) filho (a)?

() Sim, reconhece a Dupla Excepcionalidade.
() Reconhece apenas o Autismo.
() Reconhece apenas a Superdotação.
() Reconhece apenas a superdotação, pois meu (minha) filho (a) não tem TEA.
() Não reconhece nenhuma das condições.

19. Qual a relação que você faz sobre o atendimento dado ao/à seu/sua filho (a) realizado pela escola e as políticas públicas voltadas para o público-alvo da educação inclusiva?

—

20. Em termos de políticas públicas, o que falta para que as potencialidades do seu/sua filho (a) superdotado (a) sejam estimuladas?

—

21. Em termos de políticas públicas, o que falta para que as potencialidades do seu/sua filho (a) autista sejam estimuladas?

—

22. Para você, o que seria um atendimento ideal para as crianças com Dupla Excepcionalidade?

—

23. Qual sua prioridade no atendimento ao seu/sua filho (a)? (MARQUE TODAS QUE SE APLICAM)

() Saúde () Educação () Transporte () Lazer () Esporte () Cultura () outros

24. Você teria interesse em participar da roda de conversa sobre Dupla Excepcionalidade (Superdotação e TEA).

() Sim () Não

25. Se sim, deixe seu contato telefônico (preferencialmente WhatsApp).

26. Deixe sua sugestão.

10.2. ANEXOS

10.2.1. Aprovação Plataforma Brasil

Palavra-chave:

« SITUAÇÃO DA PESQUISA

☒ Marcar Todas
☒ Aprovado
☒ Em Apreciação Ética
☒ Em Edição
☒ Em Recepção e Validação Documental
☒ Não Aprovado - Não Cabe Recurso
☒ Não Aprovado na CONEP

☒ Não Aprovado no CEP
☒ Pendência Documental Emitida pela CONEP
☒ Pendência Documental Emitida pelo CEP
☒ Pendência Emitida pela CONEP
☒ Pendência Emitida pelo CEP

☒ Recurso Submetido ao CEP
☒ Recurso Submetido à CONEP
☒ Recurso não Aprovado no CEP
☒ Retirado
☒ Retirado pelo Centro Coordenador

Buscar Projeto de Pesquisa

Limpar

LISTA DE PROJETOS DE PESQUISA:

Tipo *	CAAE *	Versão *	Pesquisador Responsável *	Comitê de Ética *	Instituição *	Origem *	Última Apreciação *	Situação *	Ação
P	81010924.3.0000.8160	4	DANIELLE DE MORAES GOIS DINIZ	8160 - Universidade Federal Fluminense Humanas - UFF		PO	PO	Aprovado	

LEGENDA:

(*) Tipo
P = Projeto de Centro Coordenador Pp = Projeto de Centro Participante Pc = Projeto de Centro Coparticipante

(*) Formação do CAAE

Ano de submissão do Projeto	Tipo do centro	Código do Comitê que está analisando o projeto